

Bunga Rampai

PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK

CONTOH KASUS SEDERHANA DAN PENYELESAIAN ASUHAN

Ulfa Nur Rohmah • Asnani • Susi Milwati • Nina Sunarti
Domianus Namuwali • Erwin Silitonga • Ethyca Sari • Tutik Rahayu

Editor : Dhian Luluh Rohmawati



BUNGA RAMPAI

PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK CONTOH KASUS SEDERHANA DAN PENYELESAIAN ASUHAN

Penulis:

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.
Asnani, S.Kep., Ns., M.Ked.
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.
Ns. Nina Sunarti, M.Kep.
Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep.
Erwin Silitonga, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dr. Ns. Tutik Rahayu, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Editor:

Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.



BUNGA RAMPAI PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK CONTOH KASUS SEDERHANA DAN PENYELESAIAN ASUHAN

Penulis:

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.
Asnani, S.Kep., Ns., M.Ked.
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.
Ns. Nina Sunarti, M.Kep.
Domianus Namuwali., S.Kep., Ns., M.Kep.
Erwin Silitonga, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dr. Ns. Tutik Rahayu, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Editor: Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-66-0

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga bookchapter berjudul “Bunga Rampai: Praktik Keperawatan dalam Berbagai Situasi Klinik Contoh Kasus Sederhana dan Penyelesaian Asuhan” dapat tersusun dan diselesaikan. Kehadiran bookchapter ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan pembelajaran dan praktik keperawatan, khususnya dalam memperkuat kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, dan keterampilan menyusun asuhan keperawatan secara sistematis.

Bookchapter ini disusun berdasarkan realitas bahwa praktik keperawatan berlangsung dalam dinamika yang sangat beragam. Perawat tidak hanya berhadapan dengan keluhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, spiritual, serta konteks keluarga dan lingkungan pasien. Setiap situasi klinik memiliki karakteristik tersendiri, sehingga menuntut perawat mampu melakukan pengkajian yang komprehensif, menentukan prioritas masalah, mengambil keputusan klinis secara tepat, dan mendokumentasikan proses keperawatan secara jelas. Pada saat yang sama, praktik di lapangan sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, waktu yang terbatas, serta kompleksitas kondisi pasien. Kondisi ini membuat kemampuan menyusun rencana asuhan yang efektif, realistis, dan mudah diimplementasikan menjadi sangat penting.

Melalui pendekatan bunga rampai, bookchapter ini memuat berbagai contoh kasus sederhana yang merepresentasikan situasi klinik yang umum ditemui dalam pelayanan kesehatan. Penyajian kasus dibuat ringkas, tetapi tetap mengarah pada gambaran nyata yang membutuhkan penalaran klinis. Setiap kasus diikuti dengan tahapan penyelesaian asuhan keperawatan yang mencakup pengkajian, analisis data, penetapan diagnosis keperawatan, perumusan luaran, penyusunan intervensi, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami “apa” tindakan yang dilakukan, tetapi juga “mengapa” tindakan tersebut dipilih dan “bagaimana” menilai keberhasilannya. Harapannya, pembaca dapat menjadikan contoh-contoh tersebut sebagai referensi praktis sekaligus bahan latihan untuk mengembangkan keterampilan klinik secara bertahap.

Dalam penyusunan bookchapter ini, penulis berupaya menggunakan bahasa yang jelas, runtut, dan mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan istilah keperawatan. Selain itu, materi disusun agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan baik mahasiswa D3, S1, profesi ners, maupun perawat pemula di layanan klinik. Bookchapter ini juga diharapkan dapat membantu dosen, preceptor, dan pembimbing

klินิก sebagai bahan ajar maupun bahan diskusi dalam pembelajaran berbasis kasus (case-based learning). Lebih jauh, pembaca diharapkan terlatih untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, serta mampu menyusun asuhan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, kenyamanan, dan peningkatan kualitas hidup.

Penulis menyadari bahwa bookchapter ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan dapat ditemukan baik dari sisi cakupan kasus, kedalaman pembahasan, maupun variasi pendekatan yang disajikan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada edisi selanjutnya. Semakin banyak perspektif yang masuk, semakin besar peluang buku ini menjadi lebih relevan dengan kebutuhan praktik dan perkembangan ilmu keperawatan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan bookchapter ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing, rekan sejawat, serta semua pihak yang telah memberikan ide, masukan, dan motivasi, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga segala dukungan dan kebaikan tersebut menjadi amal yang bernilai.

Akhir kata, semoga bookchapter “Bunga Rampai: Praktik Keperawatan dalam Berbagai Situasi Klinik—Contoh Kasus Sederhana dan Penyelesaian Asuhan” dapat memberikan manfaat sebagai sumber belajar dan rujukan praktis, serta mampu mendorong peningkatan kompetensi perawat dalam memberikan asuhan yang profesional, humanis, dan berbasis bukti. Semoga karya ini turut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan memperkuat peran perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

Februari, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 NYERI AKUT: PENGKAJIAN DAN INTERVENSI KEPERAWATAN YANG MUDAH DITERAPKAN..... 1

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Konsep dan Manajemen Nyeri Akut	2
C. Karakteristik dan respons nyeri akut.....	4
D. Pengkajian Nyeri Akut.....	6
E. Intervensi Keperawatan Nyeri Akut	11
F. Simpulan.....	14
G. Referensi.....	15
H. Glosarium.....	19

CHAPTER 2 DIARE PADA ANAK : TANDA BAHAYA, PERAWATAN, DAN PERAN PERAWAT.....21

Asnani, S.Kep., Ns., M.Ked.	21
A. Pendahuluan/ Prolog.....	21
B. Konsep Penyakit Diare	22
C. Tanda bahaya Diare.....	29
D. Perawatan anak dengan diare	31
E. Peran Perawat.....	35
F. Simpulan.....	36
G. Referensi.....	38
H. Glosarium.....	39

CHAPTER 3 PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK: CONTOH KASUS SEDERHANA DAN PENYELESAIAN ASUHAN41

Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.....	41
A. Pendahuluan / Prolog.....	41
B. Tujuan Pembelajaran Chapter	42
C. Ruang Lingkup Pembahasan	42
D. Konsep Dasar Praktik Keperawatan Klinis	43
E. Kerangka Penyelesaian Kasus Keperawatan.....	45

F. Contoh Kasus Klinis dan Penyelesaian Asuhan Keperawatan	46
G. Contoh Kasus Klinis dan Penyelesaian Asuhan Keperawatan	49
H. Tabel Ringkasan Asuhan Keperawatan	55
I. Simpulan.....	56
J. Referensi.....	57
K. Glosarium.....	58

CHAPTER 4 PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK IBU POST PARTUM DENGAN NYERI LUKA SECTIO CAESAREA :

PENDEKATAN KEPERAWATAN PRAKTIS61

Ns. Nina Sunarti, M.Kep.61

A. Pendahuluan / Prolog.....	61
B. Konsep Teori.....	63
C. Metode Penelitian.....	72
D. Hasil Penelitian.....	73
E. Pembahasan.....	74
F. Implikasi praktik keperawatan.....	76
G. Simpulan.....	77
H. Referensi.....	78
I. Glosarium.....	81

CHAPTER 5 ASUHAN LANSIA DENGAN RISIKO JATUH: INTERVENSI

PENCEGAHAN YANG MUDAH DILAKUKAN87

Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep.....87

A. Pendahuluan / Prolog.....	87
B. Epidemiologi Jatuh pada lansia	88
C. Faktor Resiko Jatuh.....	89
D. Pengkajian Risiko Jatuh Pada Lansia.....	91
E. Diagnosis Keperawatan.....	93
F. Intervensi Keperawatan.....	94
G. Simpulan.....	99
H. Referensi.....	99
I. Glosarium.....	101

CHAPTER 6 PASIEN CEMAS MENJELANG TINDAKAN MEDIS: KOMUNIKASI TERAPEUTIK DASAR.....103

Erwin Silitonga, S.Kep., Ners., M.Kep.103

A. Pendahuluan / Prolog.....	103
B. Kecemasan.....	104
C. Kecemasan Menjelang Tindakan Medis	105

D. Komunikasi Terapeutik.....	107
E. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Cemas Menjelang Tindakan Medis Komunikasi Terapietik Dasar.....	110
F. Kesimpulan	114
G. Referensi.....	115
H. Glosarium.....	117

CHAPTER 7 ANAK DENGAN DEMAM AKUT : PERAN PERAWAT DALAM EDUKASI ORANG TUA119

Dr. Ethyca Sari S.Kep., Ns., M.Kes.119

A. Pendahuluan / Prolog.....	119
B. Konsep Demam pada Anak.....	120
C. Dampak Demam Akut pada Anak dan Keluarga	123
D. Peran Perawat dalam Asuhan Anak dengan Demam Akut.....	125
E. Edukasi Orang Tua tentang Demam Akut	129
F. Strategi Edukasi yang Efektif.....	130
G. Penanganan Demam di Rumah: Peran Edukasi Perawat.....	131
H. Pencegahan Kesalahan Umum dalam Penanganan Demam pada Anak.....	134
I. Kolaborasi Perawat dan Orang Tua dalam Perawatan Anak dengan Demam Akut.....	136
J. Tantangan Perawat dalam Edukasi Orang Tua tentang Demam Akut	138
K. Simpulan.....	139
L. Referensi.....	140
M.Glosarium.....	142

CHAPTER 8 CARA MEMBUAT RENCANA ASUHAN YANG SEDERHANA BERDASARKAN CONTOH KASUS.....147

Dr. Ns. Tutik Rahayu, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat.....147

A. Pendahuluan / Prolog.....	147
B. Konsep Rencana Asuhan Keperawatan Sederhana	148
C. Karakteristik Pasien Kanker Serviks yang Menjalani Kemoterapi	150
D. Langkah Praktis Penyusunan Rencana Asuhan Keperawatan.....	152
E. Contoh kasus klinis dan rencana asuhan keperawatan.....	154
F. Peran Perawat Maternitas pada Pasien Kanker Serviks yang Menjalani Kemoterapi	157
G. Simpulan.....	158
H. Referensi.....	160
I. Glosarium.....	163

PROFIL PENULIS165

CHAPTER 1

NYERI AKUT: PENGKAJIAN DAN INTERVENSI KEPERAWATAN YANG MUDAH DITERAPKAN

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Nyeri akut merupakan salah satu masalah klinis yang paling sering dihadapi dalam praktik keperawatan dengan berbagai kondisi. Nyeri akut tidak hanya memengaruhi kenyamanan pasien, tetapi memiliki dampak kepada fungsi, proses penyembuhan dan kenyamanan hidup pasien. Nyeri akut yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi nyeri kronis sehingga lebih sulit diobati dan dapat secara signifikan menurunkan kualitas hidup pasien (Vijayvargiya et al., 2021). Bahkan pada kasus pasien bedah dan trauma, nyeri akut dapat menghambat pemulihan kesehatan karena dapat membatasi mobilitas yang mengakibatkan komplikasi seperti kejadian tromboemboli, atrofi otot, dan masa rawat inap yang lebih lama (Hay & Nesbitt, 2019).

Penilaian nyeri yang tepat dan pemilihan intervensi keperawatan yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nyeri dapat menjadi fenomena subjektif yang bersifat kompleks dan memerlukan penilaian terstruktur untuk mengidentifikasi karakteristik, intensitas, dan faktor yang mempengaruhi pengalaman nyeri pada pasien. Penilaian nyeri yang tepat menjadi dasar untuk tenaga medis dapat melakukan manajemen intervensi berupa farmakologis atau non farmakologis (Cox, 2022). Akan tetapi, penanganan nyeri akut tidak hanya berfokus kepada farmakologis berupa pemberian analgesik dalam praktik keperawatan (Junaidi et al., 2025).

Kolaborasi tim interdisipliner dapat meningkatkan manajemen nyeri dengan mengintegrasikan berbagai keahlian profesi dan memberikan perawatan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien secara individual (Brogi & Forfori, 2023). Diketahui peran perawat juga dalam manajemen nyeri akut semakin berkembang, termasuk dalam penggunaan instrumen penilaian nyeri yang sesuai untuk berbagai kondisi klinis dan populasi pasien, serta penerapan pendekatan multimodal dalam pemberian terapi nyeri (Dias et al., 2025). Manajemen nyeri akut yang efektif sangat penting untuk meningkatkan hasil menurunkan tingkat nyeri bagi individu pasien secara keseluruhan.

B. Konsep dan Manajemen Nyeri Akut

Menurut *Association for the Study of Pain* (IASP), nyeri memiliki definisi sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial. Definisi nyeri akut menegaskan bahwa nyeri ternyata dapat melibatkan aspek emosional dan subjektif individu bukan hanya merupakan respons fisiologis terhadap rangsangan nosiseptif. Nyeri akut secara khusus merupakan nyeri yang timbul akibat kerusakan jaringan dan berfungsi sebagai tanda peringatan terhadap adanya proses patologi atau cedera yang sedang berlangsung, seperti pada kondisi medis akut maupun trauma bedah. Secara umum, nyeri akut akan berkurang intensitasnya seiring dengan penanganan langsung penyebab yang mendasari nyeri akut serta proses penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan sehingga dapat bersifat sementara.

Meskipun bersifat sementara, nyeri akut memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi pasien. Persepsi nyeri dapat memicu respons fisiologis dan psikologis yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, meningkatkan stres, serta menyebabkan keterlambatan dalam proses penyembuhan dan pemulihan seseorang. Apabila nyeri akut tidak dikelola secara tepat, kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap fungsi tubuh sehingga dapat menurunkan kualitas hidup pasien (Liu & Kelliher, 2022; Schwerin & Mohny, 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait penanganan nyeri menjadi penting dalam praktik klinis. Nyeri akut juga dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, yakni sebagai berikut:

1. Trauma dan Cedera

Trauma adalah penyebab utama nyeri akut, terutama dalam kondisi darurat medis. Cedera pada otot, ligamen, tulang, sendi, dan diskus di punggung dapat menyebabkan nyeri akut dengan intensitas yang bervariasi (Blake, 2019; McCarberg, 2023).

2. Prosedur Medis dan Bedah

Nyeri akut juga sering terjadi pada tindakan invasif seperti pembedahan, pungsi lumbal atau aspirasi sumsum tulang yang memicu nyeri sebagai respons terhadap kerusakan jaringan yang disengaja untuk pemeriksaan diagnostik atau terapeutik (Jensen & Patterson, 2012).

3. Penyakit dan Kondisi Medis

Penyakit seperti pankreatitis akut, kolesistitis, apendisitis, pendarahan dan ulkus perforatif, ileus, hernia strangulata, dan iskemia mesenterial akut diketahui dapat memicu nyeri akut daerah gastrointestinal (Goebel, 2017; Welman et al., 2024).

4. Infeksi dan Peradangan

Nyeri inflamasi akut yang sering terjadi pada anak-anak akibat penyakit infeksi. Selain itu, kondisi endometriosis juga merupakan contoh penyakit inflamasi kronis yang dapat menyebabkan nyeri akut melalui infiltrasi langsung atau produksi zat inflamasi di sekitar saraf (CIPRANDI & SCAGLIONE, 2025; Oliveira et al., 2020).

5. Masalah Saluran Pencernaan

Nyeri akut pada saluran pencernaan sering kali disebabkan oleh fisura anal, abses perianal, fistula, dan trombosis vena perianal. Nyeri perut akut juga bisa disebabkan oleh berbagai gangguan pencernaan, baik yang jinak maupun yang ganas untuk menentukan penatalaksanaan yang tepat (Chilou et al., 2024; Welman et al., 2024).

Secara fisiologis, nyeri menimbulkan rangsangan nosiseptif berupa timbulnya respon kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Proses awal dari timbulnya persepsi nyeri adanya aktivasi nociceptor, yaitu ujung saraf aferen primer yang peka terhadap rangsangan mekanik, termal, dan kimia yang berpotensi merusak jaringan. Aktivasi tersebut menimbulkan proses transduksi dengan timbulnya energi rangsangan sehingga memiliki perubahan menjadi impuls listrik. Impuls listrik kemudian dihantarkan melalui serabut saraf aferen, terutama serabut A-delta yang menghantarkan nyeri secara cepat dan terlokalisasi, serta peran serabut C yang bertugas untuk menghantarkan nyeri lambat, tumpul, dan difus yang menuju ke sumsum tulang belakang.

Impuls nyeri mengalami transmisi sinaptik ke neuron orde kedua sekaligus mengalami proses modulasi awal pada tingkat daerah tanduk dorsal sumsum tulang belakang. Neurotransmitter eksitatorik seperti glutamat dan substansi P memiliki peran dalam memperkuat transmisi nosiseptif, sedangkan interneuron inhibitorik melalui mekanisme inhibisi segmental dapat menekan impuls nyeri. Proses modulasi ini sangat menentukan intensitas dan kualitas sinyal nyeri yang diteruskan ke tingkat supraspinal. Jika terdapat gangguan pada mekanisme tersebut dapat meningkatkan eksitabilitas neuron spinal dan berkontribusi terhadap terjadinya sensitisasi sentral.

Selanjutnya, impuls nyeri diteruskan melalui jalur ascenden, terutama traktus spinotalamikus, menuju thalamus sebagai pusat integrasi sensorik. Jalur ini menyampaikan informasi mengenai lokasi, durasi, dan intensitas nyeri. Selain itu, jalur spinoretikular dan spinomesencefalik menghubungkan impuls nyeri dengan struktur batang otak dan sistem limbik, yang berperan dalam aspek afektif, otonom, serta respons kewaspadaan terhadap nyeri. Setelah itu, impuls nyeri dari thalamus diproyeksikan ke berbagai area korteks serebri, termasuk korteks somatosensorik,

insula, dan korteks cingulata anterior. Sehingga nyeri dapat dipersepsikan secara sadar dan terintegrasi dengan respons emosional dan kognitif seseorang.

Jalur desenden inhibitorik yang berasal dari pusat-pusat supraspinal, khususnya *periaqueductal gray* (PAG) dan rostral ventromedial medulla (RVM) mempengaruhi modulasi nyeri. Jalur desenden inhibitorik dapat mengatur transmisi nosiseptif di tanduk dorsal melalui pelepasan neurotransmitter seperti serotonin dan noradrenalin, yang berperan dalam menghambat maupun memfasilitasi penghantar impuls nyeri. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara mekanisme inhibisi dan fasilitasi desenden maka dapat memperkuat transmisi nyeri dan berperan dalam perkembangan nyeri secara persisten. Oleh karena itu, pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis dapat dipilih dengan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai jalur dan mekanisme terjadinya nyeri menjadi acuan penting dalam pendekatan klinis terhadap manajemen nyeri (Liu & Kelliher, 2022).

Pengukuran nyeri yang terstandar dan tepat memberikan landasan yang sistematis bagi pasien dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan cara pengendalian nyeri serta memperbaiki luaran klinis pasien, seperti fungsi dan kualitas hidup. Langkah awal yang penting dalam penilaian nyeri adalah membedakan nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif akut secara umum digambarkan sebagai rasa sensasi tajam atau berdenyut, sedangkan nyeri neuropatik sering ditandai dengan sensasi terbakar, menusuk, seperti tertusuk jarum, atau seperti sengatan listrik. Perbedaan ini menjadi dasar dalam menentukan strategi manajemen nyeri yang tepat dan efektif.

Pengkajian nyeri memerlukan pendekatan biopsikososial karena nyeri pada dasarnya bersifat subjektif. Komponen dari biologis, psikologis, dan sosial yang diperoleh selama anamnesa riwayat kesehatan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengalaman nyeri pasien. Sebagai contoh, seorang pasien dengan pankreatitis akut yang memiliki toleransi nyeri tinggi mungkin menilai nyerinya berada pada nilai 4 dari 10, sementara pasien lain dengan cedera pergelangan tangan dapat melaporkan nyeri berada pada nilai 8 dari 10 padahal tingkat kerusakan jaringan relatif lebih ringan. Kedua penilaian dari pasien sama-sama mencerminkan pengalaman subjektif yang valid.

C. Karakteristik dan respons nyeri akut

Nyeri akut ditandai dengan onset yang tiba-tiba yang dapat berlangsung dalam waktu singkat, serta sering kali muncul sebagai respons terhadap kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nyeri akut dirasakan sebagai sensasi yang hebat, tajam, atau parah, baik bersifat lokal maupun menyebar, dan sering disertai dengan berbagai respons fisiologis, perilaku, serta psikologis.

Secara umum, tanda dan gejala nyeri akut dapat diklasifikasikan dengan tanda-tanda klinis sebagai berikut.

1. Gejala fisik (Daly, 2011; Edwards & Mishra, 2022)

Nyeri akut dapat timbul dengan berbagai karakteristik sensasi seperti nyeri tajam, berdenyut, tumpul, terbakar, atau menusuk. Intensitasnya dapat bervariasi dari ringan hingga berat dan dapat bersifat konstan atau terintermittent (tidak terus-menerus) tergantung penyebab dan derajat kerusakan jaringan.

2. Gejala sistemik terkait (Tans et al., 2024)

Gejala sistemik yang muncul dapat berupa mual dan muntah, khususnya pada nyeri akut di gangguan sistem pencernaan. Mual dan muntah sering dilaporkan bersamaan dengan nyeri akut, terutama pada kasus nyeri pada abdomen dan masalah pencernaan lainnya.

Selain itu, diaphoresis juga sering muncul pada pasien yang mengalami nyeri akut. Pada kondisi nyeri yang berat, pasien dapat menunjukkan tanda-tanda syok, seperti hipotensi, takikardia, dan penurunan perfusi perifer.

3. Gejala Perilaku dan Psikologis

Gejala lain akibat nyeri akut memicu respons emosional dan perilaku tertentu. Persepsi nyeri dapat memburuk akibat adanya peningkatan kecemasan. Selain itu, kelelahan juga dapat muncul bersama nyeri akut khususnya pada kondisi sistemik atau inflamasi.

4. Tanda-tanda klinis (Buel et al., 2024; Hay & Nesbitt, 2019)

Nyeri akut dapat menyebabkan kejang otot karena mekanisme protektif untuk membatasi pergerakan dan mencegah cedera lebih lanjut. Pasien juga dapat menunjukkan kekakuan otot termasuk defans muskular pada dinding abdomen.

Respon fisiologis dan psikologis pasien terhadap nyeri akut

Secara patofisiologis, proses timbulnya nyeri akut terjadi di sistem saraf perifer yang umumnya bersifat nosiseptif dan berasal dari aktivasi reseptor nyeri. Impuls nyeri ditransmisikan melalui serabut aferen menuju tanduk dorsal sumsum tulang belakang, kemudian diteruskan melalui traktus spinotalamik ke talamus dan korteks serebri. Ketika impuls mencapai sistem saraf pusat dengan melampaui ambang rangsang tertentu, persepsi nyeri akhirnya terbentuk. Namun demikian, pada kondisi tertentu, nyeri juga dapat bersifat neuropatik atau mengalami sentralisasi.

Ketika nyeri akut berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 3 hingga 6 bulan sehingga dapat menyebabkan penurunan ambang persepsi nyeri disebut *centralized pain*. Penurunan ambang ini bersifat maladaptif, karena nyeri yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, akan tetapi muncul akibat

rangsangan yang tidak menimbulkan nyeri (*allodynia*) atau menunjukkan respons berlebihan terhadap rangsangan yang ringan (*hiperalgesia*).

Di sisi lain nyeri neuropatik disebabkan oleh disfungsi atau kerusakan pada jalur somatosensorik yang berasal dari sistem saraf perifer maupun sentral dan tidak hanya melibatkan traktus spinotalamik. Nyeri sentral dan nyeri neuropatik sering kali terjadi bersamaan, meskipun keduanya tidak bersifat saling eksklusif. Kedua jenis nyeri ini menunjukkan peningkatan eksitabilitas sistem saraf dan berperan penting dalam perkembangan nyeri kronis. Oleh karena itu, akibat beberapa jenis nyeri lebih responsif terhadap modulasi neurotransmitter atau saluran ion maka penting pendekatan terapeutik nyeri harus disesuaikan dengan patofisiologi yang mendasarinya. Sementara jenis lainnya akan lebih efektif ditangani dengan terapi yang menargetkan reseptor opioid (Stretanski et al., 2025).

Respon emosional dan kognitif pada nyeri

Respons terhadap nyeri akut tidak hanya melibatkan aspek fisiologis, akan tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor emosional dan kognitif secara signifikan. Faktor psikologis seperti kecemasan, ketakutan, dan depresi dapat memperkuat persepsi nyeri akut, sedangkan emosi yang positif dan rasa aman dapat menurunkan nyeri. Hal ini menjelaskan bahwa nyeri adalah pengalaman multidimensional seseorang yang dibentuk oleh interaksi antara proses sensorik, emosional, dan kognitif (Koberskaya & Tabeeva, 2021; Tsui et al., 2021).

Selain itu, aspek kognitif seperti perhatian, harapan, dan penilaian individu terhadap nyeri juga memengaruhi intensitas nyeri yang dirasakan. Fokus yang berlebihan pada nyeri dapat meningkatkan intensitas sehingga terbentuk persepsi yang berlebihan, sedangkan ketika seseorang dapat mengalihkan perhatian dan memiliki strategi koping adaptif dapat membantu mengurangi pengalaman nyeri. Temuan ini mendukung pentingnya pemilihan salah satu bentuk intervensi psikologis sebagai bagian integral dari manajemen nyeri akut yang komprehensif (Koberskaya & Tabeeva, 2021; Peters, 2015).

D. Pengkajian Nyeri Akut

Penilaian nyeri akut merupakan komponen penting dalam proses diagnosis dan penentuan terapi yang tepat dan akurat. Terdapat berbagai skala penilaian nyeri telah dikembangkan, baik yang bersifat unidimensional maupun multidimensional. Penilaian nyeri tersebut termasuk skala yang disesuaikan untuk kondisi nyeri tertentu dan kelompok populasi yang spesifik. Instrumen skala nyeri memberikan cara yang cepat, sederhana, dan praktis untuk menilai serta memantau intensitas nyeri, sehingga membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis untuk nyeri. Namun, seiring berkembangnya pemahaman mengenai nyeri sebagai

pengalaman yang kompleks dan multidimensional maka pendekatan penilaian nyeri juga mengalami perubahan. Penilaian multidimensional diyakini berpotensi meningkatkan ketepatan diagnosis dan efektivitas pengelolaan nyeri akut. Meskipun demikian, penilaian nyeri masih banyak melalui pendekatan unidimensional yang terutama berfokus pada intensitas nyeri berdasarkan laporan subjektif pasien dalam praktik klinis sehari-hari (Brasure M et al., 2019).

Skala penilaian nyeri juga diklasifikasikan sesuai dengan kelompok usia, mulai dari bayi prematur hingga dewasa. Sebuah studi ada melaporkan bahwa lebih dari 20 jenis skala nyeri yang digunakan pada bayi prematur sampai anak dan remaja usia 18 tahun. Selain itu, terdapat juga skala khusus untuk pasien non-verbal serta pasien dengan gangguan kognitif, seperti demensia. Secara general, pengukuran nyeri dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengamatan perilaku, pengukuran respons fisiologis, dan pelaporan diri. Diketahui skala berbasis pelaporan diri merupakan yang paling banyak digunakan karena dianggap memiliki validitas terbaik dalam mengukur intensitas nyeri dari ketiga pendekatan tersebut. Akan tetapi, penggunaannya terbatas pada populasi yang telah memiliki kemampuan kognitif dan bahasa yang layak, sehingga kurang sesuai untuk anak usia dini yang belum mampu mengungkapkan pengalaman nyeri secara verbal (Schwerin & Mohny, 2025).

Berikut beberapa instrumen nyeri akut sebagai berikut:

1. Skala NIPS (*Neonatal Infant Pain Scale*)

Digunakan pada anak yang berusia kurang dari satu (1) tahun.

Diadaptasi dari skala CHEOPS dan terdiri dari enam (6) indikator:

Ekspresi wajah

Skor 0: Tenang / Rileks

Skor 1: Meringis

Menangis

Skor 0: Tidak menangis

Skor 1: Merengek ringan (kadang-kadang)

Skor 2: Menangis keras/berteriak kencang

Pola pernapasan

Skor 0: Normal

Skor 1: Perubahan pernapasan dengan tidak teratur dari biasanya

Lengan

Skor 0: Terkendali

Skor 0: Normal

Skor 1: Fleksi

Skor 1: Ekstensi

Kaki

Skor 0: Terkendali/Rileks

Skor 0: Normal

Skor 1: Fleksi

Skor 1: Ekstensi

Kesadaran

Skor 0: Tidur

Skor 0: Bangun

Skor 1: Rewel

Tingkat Nyeri

0 - 2 = Tidak nyeri hingga nyeri ringan; tidak perlu intervensi

3 - 6 = Nyeri sedang; intervensi non-farmakologis dengan penilaian ulang dalam 30 menit

7 - 10 = Nyeri hebat; intervensi non-farmakologis dan kemungkinan intervensi farmakologis dengan penilaian ulang dalam 30 menit

2. Skala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

Skala digunakan untuk anak-anak berusia antara dua bulan dan tujuh tahun. Hal ini juga dapat bermanfaat bagi individu yang tidak dapat mengkomunikasikan rasa sakitnya, seperti pasien dewasa yang diintubasi di unit perawatan intensif.

Perhitungan skor total dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing kriteria sehingga didapatkan skor dari 0 sampai 10.

Wajah

Skor 0: Wajah tampak tenang dan tidak ada ekspresi nyeri atau tersenyum

Skor 1: Terkadang meringis atau mengerutkan kening; tampak menarik diri atau kurang tertarik

Skor 2: Dagus sering atau terus-menerus bergetar, rahang terkatup rapat

Kaki

Skor 0: Posisi normal atau rileks

Skor 1: Gelisah, tidak tenang, atau tampak tegang

Skor 2: Menendang atau kaki ditarik ke atas

Aktivitas

Skor 0: Berbaring tenang dalam posisi normal dan mudah bergerak.

Skor 1: Menggeliat atau bergeser maju mundur atau tampak tegang

Skor 2: Tubuh kaku, melengkung kaku atau tersentak-sentak

Menangis

Skor 0: Tidak menangis (saat bangun atau tidur)

Skor 1: Mengerang atau merintih sesekali

Skor 2: Menangis terus-menerus, menjerit atau terisak-isak

Kemampuan dihibur

Skor 0: Tenang dan nyaman

Skor 1: Mudah teralihkan perhatiannya, merasa tenang dengan sentuhan, pelukan, atau diajak bicara sesekali.

Skor 2: Sulit atau tidak dapat ditenangkan

Tingkat Nyeri

0 = Tidak Sakit

1 - 3 = Nyeri Ringan

4 - 6 = Nyeri Sedang

7 - 10 = Nyeri Berat

3. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale

Skala Wong-Baker FACES awalnya dikembangkan untuk membantu anak-anak mengekspresikan rasa nyeri yang mereka rasakan. Saat ini, skala ini digunakan secara luas pada pasien usia 3 hingga 18 tahun, serta pada individu yang mengalami keterbatasan komunikasi verbal. Skala ini dapat digunakan pada individu yang mengalami gangguan. Pasien memilih dari serangkaian wajah yang berkorelasi dengan nilai numerik.

Skala

Wajah Tersenyum (0) - Tidak nyeri

Wajah sedikit senyum (2) – Nyeri sangat ringan

Netral (4) – Nyeri ringan

Wajah sedikit cemberut (6) – Nyeri sedang

Wajah mengerutkan kening (8) – Nyeri berat

Wajah menangis (10) – Nyeri sangat berat

4. Skala NRS (Numeric Rating Scale)

Salah satu metode penilaian nyeri adalah Numeric Rating Scale. Penilaian ini pasien diminta melingkari atau menyebutkan angka bulat (0-10) yang sesuai dengan intensitas persepsi nyeri pasien. Angka (0) berarti tidak ada nyeri dan (10) berarti nyeri yang sangat berat. Skala ini telah terbukti memiliki reliabilitas dan validasi uji yang tinggi untuk nyeri akut pada pasien.

Tingkat Nyeri

0 = Tidak nyeri

1 - 3 = Nyeri ringan; masih bisa beraktivitas dan berkonsentrasi

4 - 6 = Nyeri sedang; cukup mengganggu beraktivitas dan berkonsentrasi

7 - 10 = Nyeri sangat berat; sulit atau tidak bisa beraktivitas dan berkonsentrasi

5. Skala NVPS (*Nonverbal Pain Scale*) untuk pasien Nonverbal

Skala pengukuran nyeri ini merupakan kombinasi pengukuran perilaku dan fisiologis untuk pasien non-verbal.

Wajah

Skor 0: Tidak ada ekspresi atau senyum

Skor 1: Ekspresi wajah meringis sesekali, mengeluarkan airmata, mengerutkan kening, dahi berkerut.

Skor 2: Sering meringis, menangis, mengerutkan kening, dahi berkerut

Aktivitas (gerakan)

Skor 0: Berbaring tenang, posisi normal

Skor 1: Mencari perhatian melalui gerakan lambat dan hati-hati

Skor 2: Gelisah, aktivitas berlebihan, dan/atau refleks menarik diri

Posisi tubuh

Skor 0: Berbaring tenang, tidak ada posisi tangan di atas tubuh tertentu

Skor 1: Gerakan mengeliat, tampak tegang

Skor 2: Kekakuan tubuh

Fisiologi (tanda-tanda vital)

Skor 0: Tanda vital tidak berubah dan stabil

Skor 1: Perubahan sistole > 20 mmHg atau denyut jantung > 20 kali/menit

Skor 2: Perubahan sistole > 30 mmHg atau denyut jantung > 25 kali/menit

Pernapasan

Skor 0: Frekuensi pernapasan sesuai data dasar/SpO₂ dasar sesuai dengan ventilator

Skor 1: Frekuensi pernapasan > 10 kali/menit di atas nilai dasar, penurunan SpO₂ 5% atau asinkronisasi ventilator ringan

Skor 2: Frekuensi pernapasan > 20 kali/menit di atas nilai dasar, penurunan SpO₂ 10% atau asinkronisasi ventilator yang berat

Skor Nyeri

0 - 2 = Tidak nyeri hingga nyeri ringan

3 - 6 = Nyeri sedang; pertimbangkan pemberian analgesik. Sepsis, hipovolemia, dan hipoksia perlu diatasi sebelum intervensi.

7 - 10 = Nyeri berat; pertimbangkan pemberian analgesik. Sepsis, hipovolemia, dan hipoksia perlu diatasi sebelum intervensi.

6. Penilaian PAINAN (*Pain Assessment in Advanced Dementia Scale*)

Warden, Hurley, dan Volicer mengembangkan skala PAINAN yang mirip dengan skala FLACC tetapi menggunakan skala nyeri 0-10.

Skala PAINED menilai tingkat nyeri melalui pengamatan dari pernapasan, vokalisasi negatif, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kemampuan untuk ditenangkan.

Skor Nyeri

0 = Tidak ada rasa sakit

1 - 3 = Nyeri ringan

4 - 6 = Nyeri sedang

7 - 10 = Nyeri hebat

E. Intervensi Keperawatan Nyeri Akut

Manajemen nyeri merupakan salah satu intervensi keperawatan dapat dilakukan untuk nyeri akut. Manajemen nyeri merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan tetap konstan.

Menurut SIKI penatalaksanaan nyeri akut salah satunya dilakukan dengan manajemen nyeri akut berupa (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018):

Tabel 1.1 penatalaksanaan nyeri akut

Observasi	- o Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri - o Identifikasi skala nyeri - o Identifikasi respon nyeri non verbal - o Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri - o Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri - o Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri - o Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup - o Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
Terapeutik	- o Monitor efek samping penggunaan analgetik - o Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) - o Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) - o Fasilitasi istirahat dan tidur - o Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri
Edukasi	o Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri

- Jelaskan strategi meredakan nyeri
 - Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
 - Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
 - Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri
- Kolaborasi
- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

1. Intervensi nonfarmakologis yang mudah diterapkan

a. Terapi kompres

Terapi Hangat: pemberian panas dapat membantu merilekskan otot dan meningkatkan aliran darah sehingga dapat mengurangi rasa nyeri (Jawad & Fadheel, 2025; Mota et al., 2021).

Terapi Dingin: Kompres dingin dengan menggunakan es dapat mengurangi peradangan dan membuat efek mati rasa sehingga membantu meredakan rasa nyeri (Jawad & Fadheel, 2025; Mota et al., 2021).

b. Terapi Manual

Terapi Pijat: Terapi pijat merupakan terapi yang memanipulasi jaringan lunak untuk tujuan terapeutik oleh terapis terlatih. Terapi ini membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat menurunkan tingkat nyeri (Jawad & Fadheel, 2025; Kassim et al., 2023; Mota et al., 2021; Wang et al., 2025).

Akupresur dan akupunktur: kedua teknik tersebut merangsang titik-titik area tertentu pada tubuh untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan keseimbangan tubuh (Hargett et al., 2022; Kassim et al., 2023; Mota et al., 2021).

c. Electrical and Light Therapies

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): TENS diketahui menggunakan arus listrik bertegangan rendah sehingga dapat menghambat transmisi sinyal nyeri dan meredakan rasa sakit (Jawad & Fadheel, 2025; Kassim et al., 2023; Mota et al., 2021).

Low-Level Light Therapy: terapi ini menggunakan cahaya untuk mengurangi rasa nyeri dan kondisi inflamasi (Hargett et al., 2022).

d. Intervensi Mind-Body

Teknik Relaksasi: beberapa teknik dalam teknik relaksasi berupa teknik napas dalam, meditasi, dan *mindfulness* dapat mengurangi stres dan menurunkan persepsi nyeri (Hargett et al., 2022; Kassim et al., 2023; Mota et al., 2021).

Terapi lainnya: Terapi tersebut berupa tai chi, yoga, dan qigong menawarkan pendekatan holistik dalam manajemen nyeri yang mengintegrasikan gerakan fisik, fokus mental, dan pernapasan terkontrol. Selain itu, terapi tersebut dapat

meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan. Praktik tersebut juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi tubuh. Intervensi *mind-body* ini selaras dengan respons fisiologis (level 1) dan respons kesadaran (level 2), karena bertujuan meningkatkan kesadaran tubuh dan refleksi diri (Wang et al., 2025).

Terapi Perilaku Kognitif (CBT): CBT membantu pasien dalam mengelola rasa nyeri dengan mengubah pikiran dan perilaku pasien yang berhubungan dengan pengalaman nyeri (Kassim et al., 2023; Wang et al., 2025).

e. Intervensi fisik

Reposisi dan Imobilisasi: Intervensi fisik dapat berupa memposisikan tubuh atau imobilisasi area yang terkena sehingga dapat mengurangi rasa nyeri dan mencegah perburukan kondisi tubuh (Mota et al., 2021).

Kompresi dan Elevasi: Teknik ini dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri (Mota et al., 2021).

Latihan fisik berupa olahraga mengurangi tingkat keparahan nyeri dan memperbaiki fungsi fisik, suasana hati, kelelahan, dan kualitas tidur, dibandingkan dengan tanpa intervensi.

f. Terapi sensorik

Terapi Musik: Mendengarkan musik dapat mengalihkan perhatian dari rasa nyeri dan mengurangi kecemasan (Kassim et al., 2023; Mota et al., 2021; Prandeh Afshar et al., 2025).

Aromaterapi: Aromaterapi yang menggunakan minyak esensial dapat memberikan efek menenangkan dan menurunkan persepsi nyeri (Hu et al., 2021).

2. Kolaborasi farmakologis secara singkat

Penatalaksanaan nyeri akut melibatkan berbagai strategi farmakologis yang bertujuan untuk menurunkan nyeri yang efektif sekaligus meminimalkan efek samping. Berikut adalah pendekatan farmakologis utama yang digunakan dalam pengobatan nyeri akut (Brown, 2025; Green et al., 2025; Matthews et al., 2018; Pergolizzi et al., 2015, 2021; Vijayan, 2015):

a. Obat Antiinflamasi Nonsteroid (NSAID)

NSAIN efektif untuk nyeri ringan hingga sedang, sering digunakan sebagai terapi lini pertama. Contoh: Ibuprofen, naproxen, celecoxib

Pasien dengan risiko gangguan pencernaan, ginjal, atau kardiovaskular harus berhati-hati dalam mengonsumsi NSAID.

b. Asetaminofen (Parasetamol)

Asetaminofen bekerja secara sentral untuk menurunkan nyeri dan demam. Obat ini sering digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang, dapat

dikombinasikan dengan NSAID atau opioid secara simultan untuk efek yang lebih baik. Pemantauan diperlukan untuk mencegah hepatotoksitas, terutama pada dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang.

c. Opiod

Opioid bekerja dengan berikatan pada reseptor opioid pada sistem saraf pusat untuk menghambat transmisi nyeri. Opiod digunakan pada keluhan nyeri sedang hingga berat saat pemberian analgesik lain tidak efektif. Contohnya meliputi morfin, oksikodon, dan hidroksidolon. Penggunaan opioid harus mempertimbangkan risiko ketergantungan, depresi pernapasan, dan efek samping lainnya.

d. Terapi kombinasi

Analgesia Multimodal: pendekatan ini mengkombinasikan obat-obatan dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk menurunkan nyeri dan mengurangi efek samping obat. Contohnya adalah penggabungan konsumsi NSAID dengan asetaminofen atau menggunakan kombinasi asetaminofen dan opioid (Matthews et al., 2018; Vijayan, 2015).

Kombinasi Dosis Tetap : Sediaan kombinasi dosis tetap, seperti oksikodon/asetaminofen (XARTEMIS™ XR) dapat memberikan manfaat secara sinergis dan berpotensi menurunkan kebutuhan dosis opioid serta risiko penyalahgunaan obat untuk menurunkan nyeri (Pergolizzi et al., 2015).

F. Simpulan

Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik dan emosional seorang individu yang bersifat kompleks akibat adanya kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Nyeri akut berperan sebagai mekanisme adanya peringatan terhadap gangguan atau cedera pada tubuh seseorang. Nyeri akut dapat muncul akibat berbagai kondisi seperti trauma, penyakit akut, infeksi, peradangan, serta gangguan sistem pencernaan, trauma, prosedur bedah dan medis. Prosesnya terjadinya nyeri akut dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, dan kognitif yang melibatkan aktivitas nociceptor, transmisi impuls melalui serabut saraf A-delta dan C, modulasi di tingkat spinal dan supraspinal, hingga adanya persepsi nyeri di korteks serebri. Respon nyeri akut tidak hanya muncul dalam bentuk respon keluhan nyeri, akan tetapi terdapat perubahan fisiologis, perilaku, dan emosional yang muncul sehingga memiliki dampak pada fungsi tubuh, proses penyembuhan dan kualitas hidup pasien.

Pengkajian nyeri akut yang tepat dan komprehensif merupakan dasar utama dalam tatalaksana manajemen nyeri yang efektif. Penggunaan alat ukur nyeri yang tepat dalam berbagai usia, kondisi, dan kemampuan komunikasi pasien memungkinkan perawat menentukan tingkat keparahan nyeri dan mengevaluasi

respons terhadap manajemen nyeri. Manajemen nyeri akut dengan pendekatan keperawatan mencakup pendekatan nonfarmakologis yang dapat diterapkan yakni terapi kompres, teknik relaksasi, terapi manual, intervensi *mind-body*, serta terapi sensorik. Pendekatan non farmakologi tersebut telah terbukti dapat menurunkan persepsi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, kolaborasi farmakologis melalui pendekatan analgesia multimodal menjadi salah satu strategi penting untuk mencapai kontrol nyeri yang optimal sekaligus meminimalkan efek samping pengobatan pasien. Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan aman, efektif dan berpusat pada pasien dengan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait konsep, karakteristik, pengkajian, dan manajemen nyeri akut.

G. Referensi

- Blake, J. (2019). Treatment of Nonsurgical Pain. In Pain (pp. 1035–1038). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99124-5_221
- Brasure M, Nelson VA, & Scheiner S. (2019, October). Treatment for Acute Pain: An Evidence Map. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US).
- Brogi, E., & Forfori, F. (2023). Pain Management. In Textbook of Emergency General Surgery (pp. 243–263). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22599-4_17
- Brown, M. B. (2025). Use established and emerging analgesics for acute pain management while new therapies are in development. *Drugs & Therapy Perspectives*, 41(11–12), 484–488. <https://doi.org/10.1007/s40267-025-01196-8>
- Buel, K. L., Wilcox, J., & Mingo, P. T. (2024). Acute Abdominal Pain in Children: Evaluation and Management. *American Family Physician*, 110(6), 621–631. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85212325582&partnerID=40&md5=3cb0b5ae2184af86e18548bf615e2e54>
- Chilou, C., Hahnloser, D., Hübner, M., & Grass, F. (2024). [Management of acute and chronic anal pain]. *Revue Medicale Suisse*, 20(878), 1151–1157. <https://doi.org/10.53738/REVMED.2024.20.878.1151>
- CIPRANDI, G., & SCAGLIONE, F. (2025). Ketoprofen and ketoprofen lysine salt in managing children with mild-moderate acute pain: evidence emerging from comparative trials. *Panminerva Medica*, 67(1). <https://doi.org/10.23736/S0031-0808.25.05296-6>

- Cox, F. (2022). An overview of pain assessment and management. *Nursing Standard*, 37(4), 61–66. <https://doi.org/10.7748/ns.2022.e11936>
- Daly, M. F. (2011). The differential diagnosis of acute pelvic pain in various stages of the life cycle of women and adolescents: gynecological challenges for the family physician in an outpatient setting. *Osteopathic Family Physician*, 3(3), 112–119. <https://doi.org/10.1016/j.osfp.2010.03.004>
- Dias, G. M., Santiago, E. C. de L., & Funez, M. I. (2025). Nursing interventions for acute pain management in the postanesthesia care unit: scoping review. *Brazilian Journal of Pain*, 8, e20250043. <https://doi.org/10.63231/2595-0118.20250043-en>
- Edwards, D. A., & Mishra, P. (2022). Acute Pain. In *Hospitalized Chronic Pain Patient* (pp. 7–9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08376-1_3
- Goebel, S. (2017). Abdominal Emergencies. In *Sitaraman and Friedman's Essentials of Gastroenterology* (pp. 381–397). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119235170.ch25>
- Green, V. G., Polk, D. E., Turturro, M. A., Moore, P. A., & Carrasco-Labra, A. (2025). Evidence-based clinical practice guidelines for the management of acute dental pain. *The American Journal of Emergency Medicine*, 89, 247–253. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2024.12.054>
- Hargett, J., Criswell, A., & Palokas, M. (2022). Nonpharmacological interventions for acute pain management in patients with opioid abuse or opioid tolerance: a scoping review. *JBIC Evidence Synthesis*, 20(11), 2697–2720. <https://doi.org/10.11124/JBIES-21-00169>
- Hay, D., & Nesbitt, V. (2019). Management of acute pain. *Surgery (Oxford)*, 37(8), 460–466. <https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2019.05.004>
- Hu, Y., Lu, H., Huang, J., & Zang, Y. (2021). Efficacy and safety of non-pharmacological interventions for labour pain management: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 30(23–24), 3398–3414. <https://doi.org/10.1111/jocn.15865>
- Jawad, R. H., & Fadheel, Q. J. (2025). Non-pharmacological pain management strategies: a mini-review. *Pharmakeftiki*, 37(2S), 525–529. <https://doi.org/10.60988/p.v37i2S.281>
- Jensen, M. P., & Patterson, D. R. (2012). *Hypnosis in the relief of pain and pain disorders*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198570097.013.0020>

- Junaidi, J., Syahputra, A., Erika, N., & Hasibuan, R. A. F. (2025). Implementation Of Nursing Pain Management in Gastritis Patients With Acute Pain in The Emergency. *International Journal of Health and Social Behavior*, 2(1), 208–216. <https://doi.org/10.62951/ijhsb.v2i1.328>
- Kassim, M. A. K., Pantazi, A. C., Nori, W., Tuta, L. A., Balasa, A. L., Mihai, C. M., Mihai, L., Frecus, C. E., Lupu, V. V., Lupu, A., Andrusca, A., Iorga, A. M., Litrin, R. M., Ion, I., Ciciu, E., Chirila, S. I., & Chisnoiu, T. (2023). Non-Pharmacological Interventions for Pain Management in Hemodialysis: A Narrative Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(16), 5390. <https://doi.org/10.3390/jcm12165390>
- Koberskaya, N. N., & Tabeeva, G. R. (2021). A role of cognitive and emotional factors in formation of pain. *Zhurnal Nevrologii i Psikhiiatrii Im. S.S. Korsakova*, 121(11), 111. <https://doi.org/10.17116/jnevro20211211111111>
- Liu, S., & Kelliher, L. (2022). Physiology of pain—a narrative review on the pain pathway and its application in the pain management. *Digestive Medicine Research*, 5, 56–56. <https://doi.org/10.21037/dmr-21-100>
- Matthews, M. L., Melika, R., & Murray, Y. (2018). Nonopioid and Adjuvant Analgesics for Acute Pain Management. In *Clinical Approaches to Hospital Medicine* (pp. 225–241). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64774-6_16
- McCarberg, B. (2023). Acute Pain in Perspective. *The Journal of Family Practice*, 72(06 Supp). <https://doi.org/10.12788/JFP.0617>
- Mota, M., Santos, E., Cunha, M., Abrantes, T., Caldes, P., & Santos, M. R. (2021). Non-pharmacological interventions for acute pain management in adult trauma victims: a scoping review. *JBIC Evidence Synthesis*, 19(7), 1555–1582. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00189>
- Oliveira, M. A. P., Raymundo, T. S., Lopez-Jaramillo, J. D., Lopez-Isanoa, J. D., & Villegas-Echeverri, J. D. (2020). Neuroanatomical Insights in Adolescents with Endometriosis and Pain. In *Endometriosis in Adolescents* (pp. 227–245). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52984-0_10
- Pergolizzi, J. V., Magnusson, P., LeQuang, J. A., Breve, F., Taylor, R., Wollmuth, C., & Varrassi, G. (2021). Can NSAIDs and Acetaminophen Effectively Replace Opioid Treatment Options for Acute Pain? *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 22(9), 1119–1126. <https://doi.org/10.1080/14656566.2021.1901885>

- Pergolizzi, J. V., Taylor, R., & Raffa, R. B. (2015). The Potential Role of an Extended-Release, Abuse-Deterrent Oxycodone/Acetaminophen Fixed-Dose Combination Product for the Treatment of Acute Pain. *Advances in Therapy*, 32(6), 485–495. <https://doi.org/10.1007/s12325-015-0213-5>
- Peters, M. L. (2015). Emotional and Cognitive Influences on Pain Experience (pp. 138–152). <https://doi.org/10.1159/000435938>
- Prandeh Afshar, P., Ali, E. S. A., Dehghan, F., & Dehghan, M. (2025). Non-pharmacological interventions for managing acute pain and delirium in hospitalized older patients: a systematic review. *BMC Geriatrics*, 25(1), 1036. <https://doi.org/10.1186/s12877-025-06764-1>
- Schwerin, D. L., & Mohny, S. (2025). EMS Pain Assessment And Management.
- Stretanski, M. F., Stinocher, S., & Grandhe, S. (2025). Pain Assessment.
- Tans, A., Struyf, T., Geboers, R., Smeets, T., Asselbergh, Y., Declerck, E., Bloemen, L., & van den Bruel, A. (2024). Signs and symptoms of serious illness in adults with acute abdominal pain presenting to ambulatory care: a systematic review. *BJGP Open*, 8(3), BJGPO.2023.0245. <https://doi.org/10.3399/BJGPO.2023.0245>
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tsui, P. W., Gupta, A. K., Cervoni, C. A., Page, C. R., & Sonty, N. (2021). Pain Psychology and Perioperative Pain Management. In *Perioperative Pain Control: Tools for Surgeons* (pp. 117–133). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56081-2_9
- Vijayan, R. (2015). Drugs for the Management of Pain. In *Pharmacological Basis of Acute Care* (pp. 149–160). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10386-0_18
- Vijayvargiya, M., Panchal, S., Asawale, K., & Desai, A. (2021). Oligoanalgesia in the emergency setting – An Indian review. *Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma*, 18, 38–43. <https://doi.org/10.1016/j.jcot.2021.03.025>
- Wang, Y., Aaron, R., Attal, N., & Colloca, L. (2025). An update on non-pharmacological interventions for pain relief. *Cell Reports Medicine*, 6(2), 101940. <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.101940>
- Welman, T., Yao, S., Romain, K., & Pahal, G. S. (2024). Plastic and Reconstructive Surgery. In *Hamilton Bailey's Emergency Surgery* (pp. 438–463). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003511557-25>

H. Glosarium

Allodynia

Kondisi nyeri yang muncul akibat rangsangan yang normalnya tidak menimbulkan nyeri, seperti sentuhan ringan.

Analgesia Multimodal

Pendekatan pengelolaan nyeri dengan menggabungkan beberapa metode atau obat yang memiliki mekanisme kerja berbeda untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping.

Centralized Pain (Nyeri Terpusat)

Kondisi nyeri yang terjadi akibat penurunan ambang nyeri dan peningkatan sensitivitas sistem saraf pusat, biasanya setelah nyeri berlangsung lama.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Terapi psikologis yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif yang berkaitan dengan pengalaman nyeri.

Diaphoresis

Kondisi berkeringat berlebihan yang sering menyertai nyeri akut atau respons stres.

Hiperalgesia

Peningkatan respons nyeri terhadap rangsangan yang seharusnya hanya menimbulkan nyeri ringan.

IASP (International Association for the Study of Pain)

Organisasi internasional yang menetapkan definisi dan klasifikasi nyeri secara global.

Imobilisasi

Tindakan membatasi pergerakan pada bagian tubuh tertentu untuk mengurangi nyeri dan mencegah cedera lanjutan.

Intervensi Mind–Body

Pendekatan terapi yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, dan emosional untuk mengelola nyeri, seperti meditasi, yoga, dan tai chi.

Jalur Ascenden Nyeri

Lintasan saraf yang menghantarkan impuls nyeri dari perifer menuju otak, terutama melalui traktus spinothalamikus.

Jalur Desenden Inhibitorik

Lintasan saraf dari otak ke sumsum tulang belakang yang berfungsi menghambat atau memodulasi transmisi nyeri.

Nociceptor

Ujung saraf aferen primer yang peka terhadap rangsangan mekanik, termal, atau kimia yang berpotensi merusak jaringan.

Nosiseptif

Jenis nyeri yang timbul akibat aktivasi nociceptor sebagai respons terhadap kerusakan jaringan.

NSAID (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs)

Kelompok obat yang memiliki efek analgesik dan antiinflamasi, digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang.

Nyeri Neuropatik

Nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau disfungsi pada sistem saraf perifer atau pusat.

Nyeri Nosiseptif

Nyeri yang berasal dari rangsangan nociceptor akibat kerusakan jaringan.

Reposisi

Pengaturan ulang posisi tubuh pasien untuk meningkatkan kenyamanan dan menurunkan nyeri.

Sensitisasi Sentral

Kondisi peningkatan eksitabilitas neuron sistem saraf pusat yang menyebabkan nyeri berlebihan atau persisten.

Spinotalamikus

Traktus saraf utama yang menghantarkan impuls nyeri dan suhu dari sumsum tulang belakang ke thalamus.

CHAPTER 2

DIARE PADA ANAK : TANDA BAHAYA, PERAWATAN, DAN PERAN PERAWAT

Asnani, S.Kep., Ns., M.Ked.

A. Pendahuluan/ Prolog

Diare menjadi salah satu masalah kesehatan global, dengan angka kejadian yang tinggi di berbagai belahan dunia. Penyakit diare juga masih menjadi masalah kesehatan khususnya di negara berkembang. (Kusumawardani et al. 2021)

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Menurut WHO (*World Health Organization*), Diare merupakan penyebab utama kematian pada balita, dengan lebih dari 1,7 miliar kasus setiap tahunnya (*World Health Organization*, 2024). Penyakit diare juga masih menjadi masalah kesehatan khususnya di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang juga mempunyai masalah kesehatan utama terkait penyakit diare. Penyakit diare merupakan penyakit endemis dan seringkali berhubungan angka kematian (Heryanto et al., 2022). Angka kejadian diare pada balita mencapai 12,3%, sementara pada bayi sebesar 10,6% (Risikesdas, 2023).

World Health Organization (2019), menyatakan diare merupakan gejala infeksi saluran pencernaan, yang dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus dan parasit. Penyebab terjadinya diare antara lain: virus, bakteri dan protozoa. Infeksi yang menular melalui makanan atau minum yang terkontaminasi, kebersihan lingkungan yang buruk, diare ini juga merupakan salah satu penyebab kematian pada anak usia dibawah lima tahun (balita) (Andayani, 2020). Penyebab kematian anak akibat diare yang tidak segera diatasi yaitu anak akan mengalami dehidrasi berat dan kehilangan cairan dalam jumlah yang banyak (WHO, 2022).

Departemen Kesehatan mulai melakukan sosialisasi Panduan Tata Laksana Pengobatan Diare pada balita yang baru didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, dengan merujuk pada panduan WHO. Tata laksana ini sudah mulai diterapkan di rumah sakit-rumah sakit. Rehidrasi bukan satu-satunya strategi dalam penatalaksanaan diare. Memperbaiki kondisi usus dan menghentikan diare juga menjadi cara untuk mengobati pasien. Untuk itu, Departemen Kesehatan menetapkan lima pilar penatalaksanaan diare bagi semua kasus diare yang diderita anak balita baik yang dirawat di rumah maupun sedang dirawat di rumah sakit, yaitu:

Rehidrasi dengan oralit, Zink diberikan selama 10 hari berturut-turut, Air susu ibu dan makanan tetap diteruskan, Antibiotik, Nasihat / Pendidikan kesehatan pada ibu atau pengasuh (Debie Anggraini Dkk, 2022). Penanganan diare juga dapat diberikan kepada penderita diare dengan intervensi pemberian oralit, ASI atau makanan yang cukup, dan memberikan edukasi kepada keluarga balita (Kusumawardani et al. 2021).

Peran perawat dalam upaya pencegahan dan penanganan diare pada balita yaitu memiliki peran preventif dan kuratif. Peran preventif mencakup upaya perawat dalam mencegah terjadinya diare pada balita. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi kepada ibu mengenai pengelolaan makanan balita yang bersih, sehat, dan aman. Peran kuratif melibatkan tindakan perawat dalam menangani balita yang sudah mengalami diare. Ini meliputi deteksi dini gejala diare, pemberian terapi baik secara mandiri maupun kolaboratif, serta penyusunan asuhan keperawatan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan mendukung pemulihan kesehatan balita secara optimal (Sari & Kusyani, 2023).

B. Konsep Penyakit Diare

1. Definisi Diare

Diare merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan respon buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dengan konsistensi feses yang cair. Diare dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kekurangan cairan (dehidrasi) yang parah, bahkan sampai kematian. (Pramana et al., 2023)

Diare didefinisikan sebagai buang air besar (BAB) yang cair atau berjumlah tiga kali atau lebih sehari yang disertai perubahan, dengan disertai atau tanpa darah dan atau lendir (WHO, 2013). Diare menandakan adanya infeksi atau inflamasi pada saluran pencernaan yang dapat disebabkan organisme seperti bakteri, virus, dan parasite (Nagabushana dkk., 2014). Infeksi paling banyak menyebabkan diare akut dimana bersifat *self-limited*. Diare kronik adalah diare berdurasi lebih dari 4 minggu dengan penyebab tersering *non-infectious*. Penyebab *non-infectious* dapat berupa malabsorpsi, *inflammatory bowel disease* dan efek samping pengobatan (Wenzl, 2012).

2. Etiologi

Diare dapat disebabkan oleh berbagai infeksi, selain penyebab seperti malabsorpsi. Diare sebenarnya merupakan salah satu gejala dari penyakit pada sistem gastrointestinal atau penyakit lain di luar saluran pencernaan (Sattar & Singh, 2022).

Faktor penyebab diare antara lain:

- a. Faktor Infeksi

1) Infeksi enteral

Infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak, meliputi:

- a) Infeksi bakteri: *Vibrio*, *E.Coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Aeromonas* dan sebagainya.
- b) Infeksi virus: Enterovirus (virus ECHO, Coxsackie, Poliomyelitis), Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus
- c) Infeksi parasit: cacing (*Ascaris*, *Trichuris*, *Oxyuris*, *Strongyloides*), protozoa dan jamur.

2) Infeksi Parenteral

adalah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti: otitis media akut (OMA), tonsilitis/ tonsilofaringitis, bronkopneumonia, ensefalitis dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak di bawah 2 tahun.

b. Faktor Malabsorpsi

- 1) Malabsorpsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa, maltosa, dan sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa). Pada bayi dan anak terpenting dan sering (intoleransi laktosa)

2) Malabsorpsi lemak

3) Malabsorpsi protein

c. Faktor makanan, makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan.

d. Faktor psikologis, rasa takut dan cemas (jarang, tetapi dapat terjadi pada anak yang lebih besar). Selain kuman, ada beberapa perilaku yang dapat meningkatkan resiko terjadinya diare yaitu:

- 1) Tidak memberi ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama dari kehidupan.
- 2) Menggunakan botol susu
- 3) Penyimpanan makanan masak pada suhu kamar
- 4) Air minum tercemar dengan bakteri tinja
- 5) Tidak mencuci tangan sesudah buang air besar dan buang air kecil, sesudah membuang tinja atau sebelum menjamah makanan

Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan (2011) faktor risiko terjadinya diare adalah:

1) Faktor perilaku yang meliputi :

- a) Tidak memberikan air susu ibu/ASI (ASI eksklusif), memberikan makanan pendamping/MP, ASI terlalu dini akan mempercepat bayi kontak terhadap kuman.
- b) Menggunakan botol susu terbukti meningkatkan risiko terkena penyakit diare karena sangat sulit untuk membersihkan botol susu.

- c) Tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum memberi ASI/makan, setelah buang air besar (BAB), dan setelah membersihkan BAB anak.
 - d) Penyimpanan makanan yang tidak higienis.
- 2) Faktor lingkungan antara lain: a) Ketersediaan air bersih yang tidak memadai, kurangnya ketersediaan mandi cuci kakus (MCK).

3. Klasifikasi Diare

Berdasarkan waktunya, diare di bagi menjadi:

a. Diare Akut

Diare akut yaitu kondisi dimana buang air besar berlangsung selama kurang dari 14 hari dengan konsistensi lunak atau cair dengan atau tanpa lendir dan darah dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari (Sodikin, 2011).

b. Diare Persisten

Diare persisten yaitu diare akut dengan atau tanpa disertai darah yang berlangsung sampai 14 hari atau lebih. Diare persisten menyebabkan kehilangan berat badan karena pengeluaran feses dalam jumlah banyak. Diare persisten dibagi menjadi dua yaitu diare persisten berat dan diare persisten ringan. Dikatakan diare persisten berat yaitu kondisi dimana diare berlangsung selama lebih dari 14 hari dan terdapat tanda dehidrasi sedang atau berat sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan diare persisten ringan merupakan diare yang berlangsung selama lebih dari 14 hari yang tidak menunjukkan tanda dehidrasi (Ariani, 2016).

c. Diare Kronik

Diare kronik yaitu diare yang berlangsung secara terus-menerus selama lebih dari 14 hari serta secara umum disertai dengan kehilangan berat badan secara signifikan dan masalah nutrisi (Sodikin, 2011).

Berdasarkan derajat dehidrasi yang di timbulkannya:

Tabel 1.1 Derajat Dehidrasi (Juffrie, M.M. 2009)

Simptom	Minimal atau tanpa dehidrasi Kehilangan BB<3%	Dehidrasi Ringan-Sedang. Kehilangan BB 3%-9%	Dehidrasi Berat. Kehilangan BB>9%
Kesadaran	Baik	Normal, lelah, gelisah, irritable	Apathis, letargi, tidak sadar
Denyut jantung	Normal	Normal- meningkat	Takikardi, bradikardi pada kasus berat
Kualitas nadi	Normal	Normal- lemah	Lemah, kecil, tidak teraba

Pernafasan	Normal	Normal- cepat	Dalam
Mata	Normal	Sedikit cowong	Sangat cowong
Air mata	Ada	Berkurang	Tidak ada
Mulut dan lidah	Basah	Kering	Sangat kering
Cubitan kulit	Segera kembali	Kembali <2 detik	Kembali >2 detik
Capillary refill time	Normal	Memanjang	Memanjang, minimal
Ekstremitas	Hangat	Dingin	Dingin, mottled, sianotik
Urin	Normal	Berkurang	Minimal

4. Manifestasi Klinis Diare

Manifestasi klinis anak diare menurut Wijayaningsih (2013) adalah sebagai berikut:

- Mula-mula anak cengeng, gelisah, suhu tubuh mungkin meningkat, nafsu makan berkurang.
- Sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer, kadang disertai wial dan wiata.
- Warna tinja berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur dengan empedu.
- Anus dan sekitarnya lecet karena seringnya difekasi dan tinja menjadi lebih asam akibat banyaknya asam laktat.
- Terdapat tanda dan gejala dehidrasi, turgor kulit jelas (elastisitas kulit menurun), ubun-ubun dan mata cekung membrane mukosa kering dan disertai penurunan berat badan.
- Perubahan tanda-tanda vital, nadi dan respirasi cepat, tekanan darah menurun, denyut jantung cepat, pasien sangat lemas, kesadaran menurun (apatis, samnolen, spoor, komatus) sebagai akibat hipovolemik.
- Diuresis berkurang (oliguria sampai anuria).
- Jika terjadi asidosis metabolik klien akan tampak pucat dan pernafasan cepat dan dalam.

Bentuk Klinis diare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Bentuk manifestasi klinis diare

Diagnosa	Didasarkan pada keadaan
----------	-------------------------

Diare cair akut	- Diare lebih dari 3 kali sehari berlangsung kurang dari 14 hari - Tidak mengandung darah
Kolera	- Diare yang sering dan banyak akan cepat menimbulkan dehidrasi berat, atau - Diare dengan dehidrasi berat selama terjadi KLB kolera, atau - Diare dengan hasil kultur tinja positif untuk V. Cholera 01 atau 0139
Disentri	- Diare berdarah (terlihat atau dilaporkan)
Diare persisten	- Diare berlangsung selama 14 hari atau lebih
Diare dengan gizi buruk	- Diare apapun yang disertai gizi buruk
Diare terkait antibiotika	- Mendapat pengobatan antibiotikoral spectrum luas
Invaginasi	- Dominan darah dan lender dalam tinja - Massa intra abdominal (abdominal mass) - Tangisan keras dan keputihan pada bayi

Sumber: Nurarif, Amin Huda dan Kusuma, Hardhi, 2015

5. Pemeriksaan Penunjang

Menurut Nuraarif & Kusuma (2015) pemeriksaan penunjang pada diagnosis medis diare adalah :

- Pemeriksaan tinja meliputi pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, Ph dan kadar gula dalam tinja, dan resistensi feses (colok dubur).
- Analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa.
- Pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui faal ginjal.
- Pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na,K,kalsium dan Prosfat.

6. Penatalaksanaan

Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan (2011) program lima langkah tuntaskan diare yaitu:

- Rehidrasi menggunakan Oralit osmolalitas rendah.

Oralit merupakan campuran garam elektrolit, seperti natrium klorida (NaCl), kalium klorida (KCl), dan trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat. Oralit diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Walaupun air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, air minum tidak mengandung garam elektrolit yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga lebih

diutamakan oralit. Campuran glukosa dan garam yang terkandung dalam oralit dapat diserap dengan baik oleh usus penderita diare.

Sejak tahun 2004, WHO/UNICEF merekomendasikan Oralit dengan osmolaritas rendah. Berdasarkan penelitian dengan Oralit osmolaritas rendah diberikan kepada penderita diare akan:

- 1) Mengurangi volume tinja hingga 25%
- 2) Mengurangi mual muntah hingga 30%
- 3) Mengurangi secara bermakna pemberian cairan melalui intravena sampai 33%.

Aturan pemberian oralit menurut banyaknya cairan yang hilang, derajat dehidrasi dapat dibagi berdasarkan :

- 1) Tidak ada dehidrasi, bila terjadi penurunan berat badan 2,5% Umur < 1 tahun: $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret Umur 1 – 4 tahun : $\frac{1}{2}$ - 1 gelas setiap kali anak mencret Umur diatas 5 Tahun : 1 – $1\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret
- 2) Dehidrasi ringan bila terjadi penurunan berat badan 2,5%-5%
Dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 75 ml/ kgbb dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi.
- 3) Dehidrasi berat bila terjadi penurunan berat badan 5-10%
Penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke Puskesmas. Untuk anak dibawah umur 2 tahun cairan harus diberikan dengan sendok dengan cara 1 sendok setiap 1 sampai 2 menit. Pemberian dengan botol tidak boleh dilakukan. Anak yang lebih besar dapat minum langsung dari gelas. Bila terjadi muntah hentikan dulu selama 10 menit kemudian mulai lagi perlahan-lahan misalnya 1 sendok setiap 2-3 menit. Pemberian cairan ini dilanjutkan sampai dengan diare berhenti.

b. Zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut

Zinc merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Zinc yang ada dalam tubuh akan menurun dalam jumlah besar ketika anak mengalami diare. Untuk menggantikan zinc yang hilang selama diare, anak dapat diberikan zinc yang akan membantu penyembuhan diare serta menjaga agar anak tetap sehat. Zinc merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Zinc yang ada dalam tubuh akan menurun dalam jumlah besar ketika anak mengalami diare. Untuk menggantikan zinc yang hilang selama diare, anak dapat diberikan zinc yang akan membantu penyembuhan diare serta menjaga agar anak tetap sehat.

Obat Zinc merupakan tablet dispersible yang larut dalam waktu sekitar 30 detik. Zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut dengan dosis sebagai berikut:

- 1) Balita umur < 6 bulan: 1/2 tablet (10 mg)/ hari
- 2) Balita umur ≥ 6 bulan: 1 tablet (20 mg)/ hari

c. Pemberian Makan

Memberikan makanan selama diare kepada balita (usia 6 bulan ke atas) penderita diare akan membantu anak tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. Sering sekali balita yang terkena diare jika tidak diberikan asupan makanan yang sesuai umur dan bergizi akan menyebabkan anak kurang gizi. Bila anak kurang gizi akan meningkatkan risiko anak terkena diare kembali. Oleh karena perlu diperhatikan:

- 1) Bagi ibu yang menyusui bayinya, dukung ibu agar tetap menyusui bahkan meningkatkan pemberian ASI selama diare dan selama masa penyembuhan (bayi 0 – 24 bulan atau lebih).
- 2) Dukung ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi berusia 0- 6 bulan, jika bayinya sudah diberikan makanan lain atau susu formula berikan konseling kepada ibu agar kembali menyusui eksklusif. Dengan menyusui lebih sering maka produksi ASI akan meningkat dan diberikan kepada bayi untuk mempercepat kesembuhan karena ASI memiliki antibodi yang penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi.
- 3) Anak berusia 6 bulan ke atas, tingkatkan pemberian makan. Makanan Pendamping ASI (MP ASI) sesuai umur pada bayi 6 – 24 bulan dan sejak balita berusia 1 tahun sudah dapat diberikan makanan keluarga secara bertahap.
- 4) Setelah diare berhenti pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan anak.

d. Antibiotik Selektif

Antibiotik hanya diberikan jika ada indikasi, seperti diare berdarah atau diare karena kolera, atau diare dengan disertai penyakit lain. Efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional adalah timbulnya gangguan fungsi ginjal, hati dan diare yang disebabkan oleh antibiotik.

e. Nasihat kepada orang tua/pengasuh

Berikan nasihat dan cek pemahaman ibu/pengasuh tentang cara pemberian Oralit, Zinc, ASI/makanan dan tanda-tanda untuk segera membawa anaknya ke petugas kesehatan jika anak:

- 1) Buang air besar cair lebih sering
- 2) Muntah berulang-ulang

- 3) Mengalami rasa haus yang nyata
- 4) Makan atau minum sedikit
- 5) Demam
- 6) Tinjanya berdarah
- 7) Tidak membaik dalam 3 hari

7. Pencegahan

Diare umumnya ditularkan melalui 4f, yaitu *food, feces, fly* dan *finger*. Oleh karena itu upaya pencegahan diare adalah dengan memutuskan rantai penularan tersebut.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- a. Siapkan makanan memadai, sehat dan bergizi/ASI atau susu formula yang rendah laktosa jika anak masih berumur di bawah 6 bulan.
- b. Penyediaan air minum yang bersih.
- c. Kebersihan perorangan.
- d. Cuci tangan sebelum makan dan sebelum merawat anak/bayi.
- e. Pemberian ASI eksklusif.
- f. Buang air besar pada tempatnya.
- g. Tempat buang sampah yang memadai.
- h. Berantas lalat agar tidak menghinggapi makanan.
- i. Lingkungan hidup yang sehat sesuai PHBS.

Diare pada anak dapat menyebabkan kematian dan gizi kurang. Kematian dapat di cegah dengan mencegah dan mengatasi dehidrasi dengan pemberian oralit. Gizi kurang dapat dicegah dengan pemberian makanan yang memadai selama berlangsungnya diare. Peran obat-obatan tidak begitu penting dalam menangani anak dengan diare. Pencegahan dan pengobatan diare harus dimulai dari perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (Indah Wasliah, Syamdarniati, 2020

C. Tanda bahaya Diare

Seberapa berbahaya suatu diare ditentukan dari derajat keparahan gejala yang dikeluarkan pasien dan juga penyebab dari diare tersebut. Diare dengan gejala dehidrasi yang berat dapat mengancam nyawa sehingga memerlukan penanganan segera

Tanda bahaya diare yang memerlukan penanganan medis segera (IGD) meliputi dehidrasi berat (mulut kering, tidak kencing >6 jam, mata cekung), diare berdarah/hitam, demam tinggi >39°C, muntah terus-menerus, dan nyeri perut hebat. Penanganan cepat penting untuk mencegah syok dan komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak.

Berikut adalah rincian tanda bahaya diare yang harus diwaspadai:

1. Tanda Dehidrasi Berat:

- a. Mulut dan bibir terasa sangat kering.
- b. Sangat haus atau tidak bisa minum sama sekali.
- c. Frekuensi buang air kecil berkurang drastis atau tidak kencing lebih dari 6 jam.
- d. Urine berwarna gelap.
- e. Mata terlihat cekung.
- f. Kulit tidak elastis (kembali lambat saat dicubit).
- g. Pada anak: Menangis tanpa air mata, ubun-ubun cekung.

2. Karakteristik Tinja dan Gejala Fisik:

- a. Tinja bercampur darah, berlendir, atau berwarna hitam.
- b. Diare berlangsung lebih dari 2 hari pada orang dewasa, atau >24 jam pada anak-anak.
- c. Muntah berulang atau muntah terus-menerus.
- d. Nyeri hebat pada perut atau dubur.
- e. Demam tinggi (di atas 39°C)

3. Penurunan Kesadaran dan Kondisi Umum:

- a. Tubuh sangat lemas, lesu, atau pusing berputar.
- b. Mengantuk berlebihan, kebingungan, atau sulit dibangunkan.
- c. Detak jantung meningkat dan sesak napas.
- d. Kejang.

Segera ke rumah sakit jika tanda-tanda diatas muncul, khususnya jika dialami oleh bayi, anak-anak atau individu dengan sistem imun lemah.

Berdasarkan Buku Saku Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) Kemenkes RI (2011), diare pada bayi dan anak dianggap darurat dan memerlukan penanganan intensif (IGD/Dokter) jika menunjukkan tanda bahaya berikut, terutama terkait dehidrasi berat.

Tanda Bahaya Diare (Red Flags) Harus ke IGD/Dokter

1. Dehidrasi Berat:

- a. Mata terlihat sangat cekung.
- b. Anak tampak sangat lemas, tidak sadar, atau tertidur terus-menerus (letargi).
- c. Anak tidak mampu minum atau malas menyusu.
- d. Turgor kulit perut melambat atau sangat lambat kembali saat dicubit.

2. Kondisi Fisik Anak/Dewasa:

- a. Tanda-tanda syok: tangan dan kaki terasa dingin, kulit pucat atau kebiruan, nadi cepat.
- b. Tidak buang air kecil atau jarang buang air kecil selama lebih dari 6 jam.
- c. Menangis tanpa air mata.
- d. Mulut, bibir, atau lidah sangat kering.

3. Karakteristik Diare & Gejala Penyerta:

- a. Diare berlangsung lebih dari 2 hari pada orang dewasa, atau lebih dari 24 jam pada anak-anak.
- b. Tinja disertai darah atau lendir (diare berdarah).
- c. Muntah terus-menerus sehingga cairan/makanan tidak bisa masuk.
- d. Demam tinggi (di atas 39°C - 40°C).
- e. Nyeri perut hebat atau kram perut yang ekstrem.

Diare yang tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan dehidrasi berat yang memicu:

- a. Syok hipovolemik (kekurangan cairan tubuh secara drastis).
- b. Gangguan elektrolit (seperti hiponatremia) yang menyebabkan kejang.
- c. Kegagalan organ tubuh.
- d. Kematian, terutama pada balita.

Tindakan Sementara: Sambil menuju fasilitas kesehatan, berikan cairan rehidrasi seperti oralit atau ASI secara terus-menerus untuk mencegah dehidrasi bertambah parah.

D. Perawatan anak dengan diare

Berdasarkan Buku Saku Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) Kemenkes RI (2011), Perawatan bayi / anak dengan diare bisa dilakukan mulai dari sejak di rumah dan atau di rumah sakit tergantung tingkat keparahannya:

1. Diare tanpa dehidrasi: Rencana Terapi A
2. Diare dengan dehidrasi ringan / sedang: Rencana Terapi B
3. Diare dengan dehidrasi berat: Rencana Terapi C

Rincian perawatan anak dengan diare adalah sebagai berikut:

1. Diare tanpa dehidrasi: Rencana Terapi A

- a. Bila terdapat dua tanda atau lebih

- 1) Keadaan Umum baik, sadar
- 2) Mata tidak cekung
- 3) minum biasa, tidak haus
- 4) Cubitan kulit perut / turgor kembali segera

Rencana Terapi A

Menerangkan 5 Langkah Terapi Diare Di Rumah

- 1) Beri Cairan Lebih Banyak Dari Biasanya

- a) Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama
- b) Anak yang mendapat ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan

- c) Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif, beri susu yang biasa diminum dan oralit atau cairan rumah tangga sebagai tambahan (kuah sayur, air tajin, air matang, dsb)
 - d) Beri Oralit sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit.
 - Umur < 1 tahun diberi 50-100 ml setiap kali berak
 - Umur > 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali berak.
 - e) Anak harus diberi 6 bungkus oralit (200 ml) di rumah bila:
 - Telah diobati dengan Rencana Terapi B atau C.
 - Tidak dapat kembali kepada petugas kesehatan jika diare memburuk.
 - f) Ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit.
- 2) Beri Obat Zinc
- Beri Zinc 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti. Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI.
- a) Umur < 6 bulan diberi 10 mg (1/2 tablet) per hari
 - b) Umur > 6 bulan diberi 20 mg (1 tablet) per hari.
- 3) BERI ANAK MAKANAN UNTUK MENCEGAH KURANG GIZI
- a) Beri makan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat
 - b) Tambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan
 - c) Beri makanan kaya Kalium seperti sari buah segar, pisang, air kelapa hijau.
 - d) Beri makan lebih sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil (setiap 3-4 jam)
 - e) Setelah diare berhenti, beri makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu
- 4) Antibiotik Hanya Diberikan Sesuai Indikasi. Misal: Disenteri, Kolera Dll
- 5) Nasihati Ibu/ Pengasuh: Untuk membawa anak kembali ke petugas kesehatan bila :
- a) Berak cair lebih sering
 - b) Muntah berulang
 - c) Sangat haus
 - d) Makan dan minum sangat sedikit
 - e) Timbul demam
 - f) Berak berdarah
 - g) Tidak membaik dalam 3 hari

2. Diare dengan dehidrasi ringan / sedang: Rencana Terapi B

- a. Bila terdapat dua tanda atau lebih

- 1) Gelisah, rewel
- 2) Mata cekung
- 3) Ingin minum terus, ada rasa haus
- 4) Cubitan kulit perut / turgor kembali lambat

RENCANA TERAPI B

Berikan oralit dalam 3 jam pertama di sarana kesehatan: oralit yang diberikan = 75 ml x berat badan anak.

Bila BB tidak diketahui berikan oralit sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Pemberian oralit

Umur Sampai	4 bulan	4 -12 bulan	12-24 bulan	2-5 tahun
Berat Badan	< 6 kg	6-10 kg	10-12 kg	12-19 kg
Jumlah cairan	200-400 ml	400-700 ml	700-900 ml	900-1400 ml

- 1) Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah.
- 2) Beritahu ibu untuk meneruskan pemberian ASI.
- 3) Untuk bayi < 6 bulan yang tidak mendapat ASI berikan juga 100-200 ml air masak selama masa ini.
- 4) Untuk anak > 6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam kecuali ASI dan oralit
- 5) Beri obat Zinc selama 10 hari berturut-turut

Amati anak dengan seksama dan bantu ibu memberikan oralit:

- 1) Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan.
 - 2) Berikan sedikit demi sedikit tapi sering dari gelas.
 - 3) Periksa dari waktu ke waktu bila ada masalah.
 - 4) Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI.
 - 5) Beri oralit sesuai Rencana Terapi A bila pembengkakan telah hilang.
- Setelah 3-4 jam, nilai kembali anak menggunakan bagan penilaian, kemudian pilih rencana terapi A, B atau C untuk melanjutkan terapi
- 1) Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke Rencana Terapi A. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing kemudian mengantuk dan tidur.
 - 2) Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan/ sedang, ulangi Rencana Terapi B
 - 3) Anak mulai diberi makanan, susu dan sari buah.
 - 4) Bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti dengan Rencana Terapi C

Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana terapi B

- 1) Tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam Terapi 3 jam di rumah.
- 2) Berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah

3) Jelaskan 5 langkah Rencana Terapi A untuk mengobati anak di rumah

3. Diare dengan dehidrasi berat : Rencana Terapi C

Bila terdapat dua tanda atau lebih

- Lesu, lunglai / tidak sadar
- Mata cekung
- Malas minum
- Cubitan kulit perut / turgor kembali sangat lambat

Rencana Terapi C (Untuk Terapi Diare Dehidrasi Berat Di Sarana Kesehatan)

- Beri cairan Intravena segera: Ringer Laktat atau NaCl 0,9% (bila RL tidak tersedia) 100 ml/kg BB, dibagi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pemberian cairan intra vena

UMUR	Pemberian I	Kemudian
	30ml/kg BB	70ml/kg BB
Bayi < 1 tahun	1 jam*	5 jam
Anak ≥1 tahun	30 menit*	2 1/2 jam

- Diulangi lagi bila denyut nadi masih lemah atau tidak teraba
- Nilai kembali tiap 15-30 menit. Bila nadi belum teraba, beri tetesan lebih cepat.
- Juga beri oralit (5 ml/kg/jam) bila penderita bisa minum; biasanya setelah 3-4 jam (bayi) atau 1-2 jam (anak).
- Berikan obat Zinc selama 10 hari berturut-turut

Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (anak) nilai lagi derajat dehidrasi.

Kemudian pilihlah rencana terapi yang sesuai (A, B atau C) untuk melanjutkan terapi

Rujuk penderita untuk terapi Intravena.

- Bila penderita bisa minum, sediakan oralit dan tunjukkan cara memberikannya selama di perjalanan
- Mulai rehidrasi dengan oralit melalui Nasogastrik/ Orogastrik. Berikan sedikit demi sedikit, 20 ml/kg BB/jam selama 6 jam
- Nilai setiap 1-2 jam:
 - Bila muntah atau perut kembung berikan cairan lebih lambat.
 - Bila rehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam rujuk untuk terapi Intravena.
- Setelah 6 jam nilai kembali dan pilih rencana terapi yang sesuai (A, B atau C)

- 5) Mulai rehidrasi dengan oralit melalui mulut. Berikan sedikit demi sedikit, 20 ml/kg BB/jam selama 6 jam
- 6) Nilai setiap 1-2 jam:
 - a) Bila muntah atau perut kembung berikan cairan lebih lambat.
 - b) Bila rehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam, rujuk untuk terapi Intravena.
- 7) Setelah 6 jam nilai kembali dan pilih rencana terapi yang sesuai.

Catatan:

- 1) Bila mungkin amati penderita sedikitnya 6 jam setelah rehidrasi untuk memastikan bahwa ibu dapat menjaga mengembalikan cairan yang hilang dengan memberi oralit.
- 2) Bila umur anak di atas 2 tahun dan kolera baru saja berjangkit di daerah Saudara, pikirkan kemungkinan kolera dan beri antibiotika yang tepat secara oral begitu anak sadar.

E. Peran Perawat

Peran perawat dalam upaya pencegahan dan penanganan diare pada balita yaitu memiliki peran preventif dan kuratif. Peran preventif mencakup upaya perawat dalam mencegah terjadinya diare pada balita. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi kepada ibu mengenai pengelolaan makanan balita yang bersih, sehat, dan aman. Peran kuratif melibatkan tindakan perawat dalam menangani balita yang sudah mengalami diare. Ini meliputi deteksi dini gejala diare, pemberian terapi baik secara mandiri maupun kolaboratif, serta penyusunan asuhan keperawatan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan mendukung pemulihan kesehatan balita secara optimal (Sari & Kusyanti, 2023).

Upaya untuk menurunkan angka kematian karena diare dengan melakukan tatalaksana secara tepat dan akurat. Perawat sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan diare sesuai dengan perannya. Peran perawat adalah sebagai pemberi pelayanan yang mencakup pemberi rasa nyaman, pelindung, komunikator, mediator dan rehabilitator. Setelah terjadi peningkatan penyakit diare peran perawat sebagai pendidik sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada individu, keluarga ataupun masyarakat di semua lingkup pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan kepada pasien bertujuan untuk mempertahankan kondisi sehat pasien, meningkatkan kesehatan, dan mencegah terjadinya suatu penyakit dan komplikasi. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat erat kaitannya dengan lingkungan sarana kesehatan misalnya puskesmas, dan posyandu. Di lingkungan puskesmas perawat berinteraksi dengan anggota keluarga yang memerlukan informasi kesehatan. Upaya penyuluhan

kesehatan dalam hal ini pendidikan kesehatan sangat bermanfaat untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan keluarga (Depkes RI, 2014).

Peran perawat anak menurut Erita et al. (2019), perawat merupakan anggota dari tim pemberi asuhan keperawatan anak dan orang tuanya dapat dilakukan dengan cara diantaranya memantau asupan dan pengeluaran cairan. Anak yang mendapatkan terapi cairan intravena perlu pengawasan untuk asupan cairan, kecepatan tetesan harus diatur untuk memberikan cairan dengan volume yang dikehendaki dalam waktu tertentu dan lokasi pemberian infus harus dijaga, menganjurkan makan sedikit tapi sering pada anak dan memantau status tanda-tanda vital (PPNI, 2017).

Perawat memiliki fungsi dan peran sebagai perawat anak diantaranya sebagai edukator, peranannya dalam memberi pendidikan kesehatan, baik secara langsung dengan pemberian pendidikan/penyuluhan kesehatan pada orang tua pasien maupun secara tidak langsung dengan menolong anak/orang tua untuk paham terhadap perawatan dan pengobatan sang anak.

Sebagai konselor, apabila sewaktu anak maupun keluarga memiliki kebutuhan psikologis seperti dorongan/dukungan mental, perawat dapat melakukan konseling keperawatan pada saat anak maupun keluarganya membutuhkannya.

Sebagai kolaborator atau koordinator melalui pendekatan interdisiplin, perawat menjalankan kolaborasi dan koordinasi bersama tim kesehatan lainnya untuk tujuannya dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang komprehensif dan holistik. Karena berada disamping pasien seharian penuh, perawat menjadi posisi kunci dalam menjadi koordinator pada pelayanan kesehatan.

Sebagai peneliti, dalam pemberian asuhan anak, perawat perlu untuk menjalankan keterlibatan penuh dalam usaha menemukan masalah-masalah keperawatan sang anak yang patut diteliti, Menjalankan penelitian langsung juga memakai hasil penelitian keperawatan / kesehatan anak dalam tujuannya meningkatkan kualitas asuhan / praktik keperawatan pada anak.

Sebagai pembuat keputusan etik, Perawat memiliki tuntutan dalam berperan menjadi pembuat keputusan etik berdasar keyakinan pada nilai norma dengan menekankan hak-hak yang perlu didapatkan pasien, Menghindari sesuatu yang dapat merugikan pasien dan memastikan peningkatan pada kesejahteraan pasien

F. Simpulan

diare masih menjadi masalah kesehatan penting secara global dan di Indonesia, terutama pada bayi dan balita, karena angka kejadiannya tinggi serta berisiko menimbulkan kematian bila tidak ditangani cepat dan tepat. Diare didefinisikan sebagai buang air besar cair ≥ 3 kali per hari, yang umumnya

menandakan adanya gangguan/infeksi pada saluran cerna. Penyebabnya beragam, paling sering infeksi (virus, bakteri, parasit) dan dapat dipengaruhi faktor noninfeksi seperti malabsorpsi, makanan yang tidak aman, serta faktor perilaku dan lingkungan (air bersih, sanitasi, kebiasaan cuci tangan, penggunaan botol susu, dan pemberian ASI yang tidak optimal).

Diare dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi (akut, persisten, kronik) dan tingkat dehidrasi (tanpa, ringan–sedang, berat). Manifestasi klinis yang muncul tidak hanya berupa peningkatan frekuensi BAB cair, tetapi juga dapat disertai muntah, penurunan nafsu makan, perubahan warna tinja, iritasi daerah anus, hingga tanda dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit/asam-basa yang dapat mengarah pada syok hipovolemik. Karena itu, penilaian derajat dehidrasi menjadi kunci dalam menentukan rencana terapi dan kebutuhan rujukan.

Penatalaksanaan diare pada anak menekankan “lima langkah tuntaskan diare”, yaitu rehidrasi (utamanya dengan oralit osmolaritas rendah atau cairan intravena pada dehidrasi berat), pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut, melanjutkan ASI dan pemberian makan sesuai umur untuk mencegah gizi kurang, pemberian antibiotik secara selektif hanya pada indikasi tertentu (misalnya disentri/kolera), serta nasihat/edukasi kepada orang tua atau pengasuh. Penerapan rencana terapi A, B, dan C (dari tanpa dehidrasi hingga dehidrasi berat) membantu memastikan penanganan dilakukan sesuai tingkat keparahan, baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Selain terapi, pencegahan tetap menjadi strategi utama melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemutusan rantai penularan “4F” (food, feces, fly, finger).

Tanda bahaya seperti dehidrasi berat, tinja berdarah/hitam, demam tinggi, muntah terus-menerus, nyeri perut hebat, penurunan kesadaran, atau tanda syok harus dikenali sedini mungkin karena membutuhkan pertolongan medis segera. Dalam keseluruhan upaya pencegahan dan penanganan, perawat memiliki peran vital baik preventif maupun kuratif: melakukan edukasi keluarga, deteksi dini dan pemantauan cairan-elektrolit, pengawasan terapi (oral/intravena), pemantauan tanda vital, dukungan psikologis melalui konseling, kolaborasi dengan tim kesehatan, serta pengambilan keputusan etik untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak.

G. Referensi

- Amin huda nurarif, & Hardhi kusuma, (2015). aplikasi asuhan keperawatan berdasarkan diagnosa medis dan nanda nic noc (jilid 3). penerbit mediacion jogja
- Andayani, R.P. (2020). Madu sebagai Terapi Komplementer Mengatasi Diare pada Anak Balita. *Jurnal Kesehatan Perintis* Vol.7 No.1, 64-68.
- Ariani, A. P. (2016). *Diare Pencegahan Dan Pengobatannya*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Debie Anggraini, Olivitari Kumala (2022), Diare pada Anak, *Scientific Journal SCIENA*, Vol I No 4 July 2022, eISSN : 2810 – 0204, Available Online at :
- Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (2011), *Buku Saku Petugas Kesehatan Lintas Diare*.
- Depkes RI, (2014) *Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare*, Edisi 4. Ditjen PPM dan PL, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan. (2011). *Panduan Sosialisasi Tatalaksana Diare Balita*. Jakarta.
- Erita, Hununwidiastuti, S., & Leniwita, H. (2019). *Buku Materi Pembelajaran Keperawatan Jiwa*. Universitas Kristen Indonesia, 202. <http://repository.uki.ac.id/2703/1/BMPKEPERAWATANJIWA.pdf>
- Heryanto, E., Sarwoko, S., & Meliyanti, F. (2022). Faktor risiko kejadian diare pada balita di UPTD Puskesmas Sukaraya Kabupaten Oku Tahun 2021. *Indonesian Journal of Health and Medical*, 2(1), 10–21.
- <http://journal.scientic.id/index.php/sciena/issue/view/4>
- Indah Waslihah, Syamdarniati, D. A. (2020). Pemberian Edukasi Kesehatan tentang Pencegahan Diare pada Anak Di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram, NTB. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, 2(1), 13–16. <https://jurnal.stikesperintis.ac.id/index.php/JAKP/article/download/431/250/>
- Juffrie, M.M. 2009. *Buku Ajar Gastroenterologi Hepatologi*. Jakarta : Ikatan Dokter Anak Indonesia ; Volume 1.
- Kusumawardani, Y., & Ilmu Kesehatan, F. (2021). PEMBERIAN TABLET ZINC DENGAN DURASI DIARE PADA BALITA. In *Indonesian Jurnal of Health Development* (Vol. 3, Issue 2).
- Nagabushana D, Rao D, Pushpalatha S. (2014). A Clinical and Epidemiological Study of Enterovirus Associated Diarrhea in Hospitalized Children. *Artikel. J Pediatr Sci*. 6(212).

- Pramana, K. D., Arjita, I. P. D., Rozikin, Anulus, A., Adnyana, I. G. A., & Wulandhari, S. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Wisatawan: A Systematic Review. *Jurnal Keperawatan*, 15(1), 127–132.
- Riset Kesehatan Dasar. (2023). LAPORAN KINERJA DIREKTORAT P2PM TAHUN 2023. <https://p2pm.kemkes.go.id/storage/informasipublik/content/PO8qGjgRp5NpWnHhbxXXGKKj3YlwVymetaTGFwa2luIDIwMjMgUDJQTV8xNjAyMjAyNC5wZGY=-.pdf>
- Sari, G. M., Prawito, & Kusyanti, A. (2023). The Influence Of Giving Education About Diarrhea On Mother Level Of Knowledge In Diarrhea Prevention In Children. *Journal of Nursing and Midwifery Sciences*, 2(2), 23–32. <https://doi.org/10.54771/jnms.v2i2.1152>
- Sattar, S. B. A., & Singh, S. (2022). Bacterial Gastroenteritis. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513295/>
- Sodikin. Asuhan Keperawatan anak Gangguan Sistem Gastrointestinal dan Hepatobilier. 2011. Jakarta: Salemba Medika.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- Wenzl HH. (2012). Diarrhea in chronic inflammatory bowel diseases. *Gastroenterol Clin North Am*. 41(3):651-675.
- WHO (2022). Child mortality (under 5 years). World Health Organization. 2022. <https://www.who.int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Levels-AndTrends-In-Child-Under-5-Mortality-In-2020>. Diakses Feb 2022.
- Wijayaningsih K. S. (2013). ***Asuhan Keperawatan Anak***. Jakarta: CV. Trans Info Media (TIM).
- World Health Organization*. (2013). Penyakit Diare. Diakses dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/>
- World Health Organization*. (2024). Diarrhoea. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>

H. Glosarium

4F (Food, Feces, Fly, Finger): Jalur penularan diare melalui makanan, tinja, lalat, dan tangan/jari yang terkontaminasi.

Air Bersih: Air yang aman untuk diminum dan digunakan sehari-hari, bebas dari kuman penyebab penyakit.

Bronkopneumonia: Infeksi paru dan bronkus yang dapat menjadi infeksi parenteral pemicu diare.

Campylobacter: Bakteri penyebab diare, sering dari makanan/minuman terkontaminasi.

Dehidrasi Berat: Dehidrasi dengan kehilangan cairan signifikan yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan cepat.

Dehidrasi Ringan–Sedang: Kehilangan cairan tingkat sedang yang memerlukan rehidrasi oral terukur.

Diare Terkait Antibiotika: Diare yang muncul akibat penggunaan antibiotik, terutama spektrum luas.

E. coli (Escherichia coli): Bakteri yang dapat menyebabkan diare, terutama bila mencemari makanan/minuman.

Faktor Psikologis: Keadaan mental seperti cemas/takut yang dapat memengaruhi sistem pencernaan (lebih jarang pada anak besar).

Gagal Organ: Kondisi ketika organ tidak berfungsi normal akibat komplikasi berat, misalnya dehidrasi parah.

Hipovolemik: Keadaan kekurangan volume cairan darah yang dapat menyebabkan syok.

IGD (Instalasi Gawat Darurat): Unit layanan rumah sakit untuk kondisi yang memerlukan penanganan segera.

Kuratif: Upaya penanganan/penyembuhan saat penyakit sudah terjadi.

Letargi: Kondisi sangat lemah, mengantuk berat, sulit dibangunkan; tanda dehidrasi berat.

Malabsorpsi: Gangguan penyerapan zat gizi (karbohidrat/lemak/protein) di usus yang dapat menyebabkan diare.

CHAPTER 3

PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK: CONTOH KASUS SEDERHANA DAN PENYELESAIAN ASUHAN

Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

A. Pendahuluan / Prolog

Praktik keperawatan merupakan inti dari proses pendidikan keperawatan, khususnya pada jenjang pendidikan vokasi D3 Keperawatan, karena menjadi wahana utama bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis, keterampilan klinik, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Pembelajaran praktik keperawatan yang efektif tidak hanya menekankan penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinik dalam menghadapi berbagai situasi pasien. Oleh karena itu, pembelajaran praktik keperawatan berbasis kasus klinik dipandang sebagai pendekatan yang relevan dan kontekstual karena mampu membantu mahasiswa memahami kondisi pasien secara holistik serta menerapkan proses keperawatan secara sistematis sesuai dengan situasi klinik yang nyata (Potter et al., 2021).

Pendekatan pembelajaran berbasis kasus klinik menjadi semakin penting mengingat praktik keperawatan di lapangan sering kali dihadapkan pada permasalahan kesehatan yang kompleks dan dinamis. Melalui penyajian kasus klinik sederhana yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi mahasiswa, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih bermakna dan aplikatif. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep penyakit secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk mengidentifikasi masalah keperawatan, menentukan prioritas asuhan, serta merencanakan intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Pembelajaran berbasis kasus terbukti mampu meningkatkan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi praktik klinik (Billings & Halstead, 2020).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara teori keperawatan yang dipelajari di institusi pendidikan dengan praktik keperawatan di lapangan. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mengaitkan konsep teoretis dengan kondisi klinik nyata, terutama pada tahap analisis data, penetapan diagnosis keperawatan, serta penyusunan rencana asuhan keperawatan yang logis dan terstruktur. Kesenjangan ini dapat berdampak pada

rendahnya kepercayaan diri mahasiswa saat menjalani praktik klinik dan berpotensi memengaruhi mutu asuhan keperawatan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui penyajian contoh kasus klinik yang realistis, sederhana, dan sesuai dengan kewenangan perawat vokasi (Herdman & Kamitsuru, 2021).

Perawat vokasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan klinik sederhana yang berkaitan dengan pemantauan kondisi pasien, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian edukasi kesehatan, serta upaya pencegahan komplikasi. Pengambilan keputusan klinik tersebut harus didasarkan pada proses keperawatan yang sistematis dan mengacu pada standar praktik keperawatan yang berlaku. Penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) menjadi landasan penting dalam menjamin mutu dan keselamatan asuhan keperawatan yang diberikan. Dengan demikian, chapter ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara teori dan praktik keperawatan melalui pembelajaran berbasis kasus klinik sederhana yang disajikan secara sistematis dan aplikatif, sehingga dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi praktik klinik dan dunia kerja sebagai perawat vokasi profesional (PPNI, 2022).

B. Tujuan Pembelajaran Chapter

1. Setelah mempelajari chapter ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan proses keperawatan pada berbagai situasi klinik yang sering dijumpai dalam praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis standar praktik keperawatan.
2. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah keperawatan berdasarkan data pengkajian yang diperoleh dari kasus klinik sederhana secara tepat dan rasional. Selain itu,
3. Mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan secara sistematis dan logis melalui tahapan pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup Pembahasan

1. Ruang lingkup pembahasan dalam chapter ini mencakup praktik keperawatan pada berbagai kasus klinik sederhana yang sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Pembahasan

difokuskan pada bidang keperawatan medikal-bedah, keperawatan komunitas, serta situasi kegawatdaruratan sederhana yang berada dalam kewenangan perawat vokasi. Kasus-kasus klinik yang disajikan dipilih berdasarkan permasalahan kesehatan yang umum ditemukan di lapangan, sehingga relevan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan klinik mahasiswa dalam konteks praktik keperawatan sehari-hari (Potter et al., 2021).

2. Fokus pembahasan diarahkan pada pasien dewasa dan lansia, mengingat kedua kelompok ini merupakan populasi yang paling banyak menerima pelayanan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Pasien dewasa dan lansia memiliki karakteristik fisiologis dan psikososial yang khas, sehingga memerlukan pendekatan asuhan keperawatan yang tepat dan berkesinambungan. Dengan menitikberatkan pada kelompok ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami variasi respons pasien terhadap masalah kesehatan serta menyesuaikan intervensi keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu dan tahap perkembangan pasien (Stanhope & Lancaster, 2020).
3. Seluruh pembahasan dan penyelesaian kasus dalam chapter ini menggunakan pendekatan proses keperawatan yang mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) sebagai pedoman nasional dalam penyusunan asuhan keperawatan. Penggunaan standar ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa menerapkan asuhan keperawatan secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik, serta sejalan dengan praktik profesional keperawatan di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan penalaran klinik dan memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sesuai standar yang berlaku (PPNI, 2022).

D. Konsep Dasar Praktik Keperawatan Klinik

1. Pengertian Praktik Keperawatan Klinik

Praktik keperawatan klinik merupakan proses penerapan ilmu keperawatan, keterampilan klinik, dan sikap profesional secara langsung kepada pasien, keluarga, dan masyarakat dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Praktik ini dilakukan berdasarkan proses keperawatan yang sistematis, meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Pada pendidikan vokasi D3 Keperawatan, praktik keperawatan klinik berfungsi sebagai sarana utama untuk melatih mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktik nyata di lapangan sesuai dengan kewenangan perawat vokasi (Potter et al., 2021).

Praktik keperawatan klinik tidak hanya menekankan pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, penalaran klinik, serta pengambilan keputusan keperawatan sederhana yang aman dan bertanggung jawab. Melalui praktik klinik, mahasiswa dibimbing untuk memahami respon pasien terhadap masalah kesehatan dan memberikan asuhan keperawatan yang berfokus pada kebutuhan dasar pasien secara holistik (Billings & Halstead, 2020).

2. Prinsip Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan prinsip fundamental dalam praktik keperawatan klinik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera, kesalahan, dan kejadian tidak diharapkan selama pemberian asuhan keperawatan. Keselamatan pasien dilaksanakan melalui penerapan sistem pelayanan yang aman, termasuk identifikasi pasien yang tepat, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, pencegahan infeksi, serta pengelolaan risiko klinik secara berkelanjutan (World Health Organization, 2021).

Perawat memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan pasien karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien. Dalam praktik keperawatan klinik, perawat bertanggung jawab memastikan setiap tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar prosedur operasional, memantau perubahan kondisi pasien, serta melaporkan kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Penerapan prinsip keselamatan pasien secara konsisten terbukti meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan angka kejadian tidak diharapkan di fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

3. Etika dan Tanggung Jawab Perawat dalam Pengelolaan Kasus

Etika keperawatan merupakan pedoman perilaku profesional yang mengatur hubungan perawat dengan pasien, keluarga, sesama tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dalam praktik keperawatan klinik, perawat wajib menjunjung tinggi prinsip etika, seperti menghormati martabat dan hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, bersikap jujur, serta memberikan asuhan keperawatan tanpa diskriminasi. Penerapan etika keperawatan menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan keperawatan (American Nurses Association, 2022).

Selain etika, perawat juga memiliki tanggung jawab profesional dan hukum dalam pengelolaan kasus klinik sederhana. Perawat vokasi bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar profesi, kewenangan, dan kebijakan institusi pelayanan kesehatan. Dalam praktik klinik, perawat harus mampu bekerja sama dengan tim kesehatan, melaporkan kondisi pasien secara akurat, serta mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung

jawab ini penting untuk menjamin keselamatan pasien dan akuntabilitas praktik keperawatan (PPNI, 2022).

4. Dokumentasi Asuhan Keperawatan Sederhana

Dokumentasi asuhan keperawatan merupakan catatan tertulis yang sistematis dan berkesinambungan tentang seluruh proses keperawatan yang diberikan kepada pasien. Dokumentasi ini mencerminkan pelaksanaan proses keperawatan secara utuh, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi tindakan, hingga evaluasi hasil asuhan keperawatan. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan perawat, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan klinis dalam asuhan keperawatan.

Dalam praktik keperawatan klinik, dokumentasi memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti legal dan akuntabilitas profesional, serta indikator mutu pelayanan keperawatan. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu memungkinkan kesinambungan asuhan keperawatan, meminimalkan kesalahan tindakan, serta melindungi perawat secara hukum apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan (Potter et al., 2021).

Pada tingkat pendidikan vokasi, mahasiswa keperawatan dibiasakan menyusun dokumentasi asuhan keperawatan sederhana dengan mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Penggunaan standar ini bertujuan agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis dalam mengidentifikasi masalah keperawatan, menetapkan tujuan yang terukur, serta memilih intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien.

Dokumentasi asuhan keperawatan sederhana bagi mahasiswa disusun dengan prinsip jelas, ringkas, logis, dan sesuai kewenangan, serta disesuaikan dengan kondisi lahan praktik seperti puskesmas atau klinik pelayanan primer. Melalui latihan dokumentasi yang terstandar, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan ketelitian, tanggung jawab, dan sikap profesional sebagai perawat vokasi, sehingga lebih siap menghadapi praktik klinik lanjutan maupun dunia kerja setelah lulus (PPNI, 2022).

E. Kerangka Penyelesaian Kasus Keperawatan

Penyelesaian kasus keperawatan dalam chapter ini disusun menggunakan kerangka proses keperawatan sebagai berikut:

1. Pengkajian Keperawatan
2. Analisis Data

3. Diagnosis Keperawatan (SDKI)
4. Perencanaan Keperawatan (SLKI dan SIKI)
5. Implementasi Keperawatan
6. Evaluasi Keperawatan

Kerangka ini digunakan secara konsisten untuk membiasakan mahasiswa berpikir kritis, sistematis, dan logis dalam menyelesaikan masalah keperawatan pada pasien di lahan praktik, khususnya di pelayanan kesehatan tingkat pertama.

F. Contoh Kasus Klinis dan Penyelesaian Asuhan Keperawatan

Kasus Klinik: Pasien Hipertensi di Puskesmas

1. Deskripsi Kasus

Tn. A, usia 55 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan sakit kepala bagian belakang, mudah lelah, dan tengkuk terasa berat sejak beberapa minggu terakhir. Pasien mengatakan sering mengonsumsi makanan asin dan jarang berolahraga. Hasil pemeriksaan tekanan darah menunjukkan 150/95 mmHg. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu dan mengaku tidak rutin mengonsumsi obat antihipertensi.

2. Kerangka Penyelesaian Kasus Keperawatan

(Pola Baku untuk Semua Contoh Kasus)

Kerangka penyelesaian kasus keperawatan disusun berdasarkan proses keperawatan sebagai pendekatan ilmiah dan sistematis dalam pemecahan masalah kesehatan pasien. Kerangka ini digunakan secara konsisten dalam setiap contoh kasus agar mahasiswa terbiasa berpikir kritis, logis, dan terstruktur dalam memberikan asuhan keperawatan, khususnya di lahan praktik pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

3. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal proses keperawatan yang bertujuan mengumpulkan data secara menyeluruh dan sistematis tentang kondisi pasien. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menetapkan diagnosis dan perencanaan asuhan keperawatan.

Komponen pengkajian keperawatan meliputi:

a. Identitas Pasien

Meliputi nama/inisial pasien, usia, jenis kelamin, alamat, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan tanggal masuk pelayanan. Identitas pasien penting untuk memastikan ketepatan asuhan serta mencegah kesalahan dalam tindakan keperawatan.

b. Keluhan Utama

Keluhan utama merupakan alasan utama pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, yang dinyatakan langsung oleh pasien atau keluarga. Keluhan ini menjadi fokus awal dalam pengkajian masalah keperawatan.

c. Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan mencakup:

- 1) Riwayat penyakit sekarang
- 2) Riwayat penyakit dahulu
- 3) Riwayat penyakit keluarga
- 4) Riwayat pengobatan dan kepatuhan minum obat

Data ini membantu perawat memahami faktor risiko dan perjalanan penyakit pasien.

d. Pemeriksaan Fisik (Head to Toe Sederhana)

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dari kepala hingga kaki, meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital, kondisi umum, dan sistem tubuh utama. Pada tingkat vokasi, pemeriksaan difokuskan pada temuan yang relevan dengan keluhan pasien dan kondisi klinis yang ada.

e. Data Penunjang (Jika Ada)

Data penunjang meliputi hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan penunjang sederhana, atau catatan medis lain yang mendukung penegakan masalah keperawatan.

(Potter et al., 2021)

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengelompokkan dan menafsirkan data subjektif dan objektif hasil pengkajian untuk mengidentifikasi masalah keperawatan. Pada tahap ini, mahasiswa dilatih untuk:

- a. Mengelompokkan data yang saling berhubungan
- b. Mengidentifikasi data normal dan tidak normal
- c. Menentukan masalah keperawatan yang paling prioritas

Analisis data yang baik akan menghasilkan diagnosis keperawatan yang akurat dan sesuai dengan kondisi pasien.

5. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap respons pasien terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial yang ditetapkan berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Diagnosis keperawatan dituliskan dalam format yang sesuai standar, mencakup masalah keperawatan dan faktor yang berhubungan.

Penggunaan SDKI bertujuan untuk menyeragamkan bahasa diagnosis keperawatan serta meningkatkan kualitas dan keselamatan asuhan keperawatan (PPNI, 2022).

6. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan merupakan tahap penyusunan rencana tindakan keperawatan berdasarkan diagnosis yang telah ditetapkan.

a. Tujuan dan Kriteria Hasil (SLKI)

Tujuan keperawatan disusun berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan menggambarkan kondisi yang diharapkan setelah dilakukan asuhan keperawatan. Kriteria hasil harus spesifik, terukur, dan realistis sesuai kondisi pasien.

b. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan disusun mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan disesuaikan dengan kewenangan perawat vokasi. Intervensi mencakup tindakan mandiri, edukatif, dan kolaboratif yang bertujuan mencapai luaran yang telah ditetapkan.

7. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah direncanakan. Pada tahap ini, perawat atau mahasiswa keperawatan melaksanakan intervensi dengan memperhatikan keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, dan prinsip etika keperawatan.

Setiap tindakan keperawatan yang dilakukan harus dicatat secara tepat dan sesuai standar dokumentasi keperawatan.

8. Evaluasi Keperawatan (SOAP/DARE)

Evaluasi keperawatan merupakan tahap penilaian terhadap respons pasien setelah diberikan asuhan keperawatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan.

Pendokumentasian evaluasi dapat menggunakan format:

a. SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), atau

b. DARE (Data, Action, Response, Evaluation)

Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah asuhan keperawatan dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sesuai perkembangan kondisi pasien.

G. Contoh Kasus Klinis dan Penyelesaian Asuhan Keperawatan

Kasus 1: Pasien Hipertensi di Puskesmas

1. Deskripsi Kasus Sederhana

Tn. A, usia 55 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan sakit kepala bagian belakang, tengkuk terasa berat, dan mudah lelah sejak kurang lebih satu bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu, namun mengaku tidak rutin mengonsumsi obat antihipertensi. Pasien juga menyatakan sering mengonsumsi makanan asin dan jarang melakukan aktivitas fisik. Hasil pemeriksaan tekanan darah menunjukkan 150/95 mmHg.

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sering ditemukan di pelayanan kesehatan primer dan memerlukan pengelolaan berkelanjutan melalui asuhan keperawatan dan edukasi kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

2. Data Pengkajian

a. Data Subjektif

- 1) Pasien mengeluh sakit kepala dan leher terasa kaku
- 2) Pasien cepat lelah saat beraktivitas
- 3) Pasien mengaku jarang berolahraga
- 4) Pasien tidak rutin minum obat karena merasa "sudah baik"

b. Data Objektif

- 1) Tekanan darah: 150/95 mmHg
- 2) Nadi: 86 x/menit
- 3) Pernapasan: 20 x/menit
- 4) Suhu: 36,6°C
- 5) Indeks massa tubuh menunjukkan kelebihan berat badan
- 6) Pasien tampak kurang memahami pengelolaan hipertensi

Pengkajian yang sistematis sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko dan respons pasien terhadap penyakit hipertensi (Potter et al., 2021).

3. Diagnosis Keperawatan Utama (SDKI)

Berdasarkan analisis data, diagnosis keperawatan utama yang ditegakkan adalah:

Manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang pengelolaan hipertensi dibuktikan dengan ketidakpatuhan minum obat, pola makan tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik.

Diagnosis ini sesuai dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) untuk pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang (PPNI, 2022).

4. Rencana Asuhan Keperawatan

a. Tujuan dan Kriteria Hasil (SLKI)

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama periode perawatan, diharapkan:

- 1) Pasien menunjukkan peningkatan kemampuan mengelola kesehatannya
- 2) Pasien mampu menjelaskan kembali prinsip pengelolaan hipertensi
- 3) Pasien menunjukkan kepatuhan terhadap pengobatan dan anjuran gaya hidup sehat

Luaran keperawatan mengacu pada SLKI: Manajemen Kesehatan (PPNI, 2022).

b. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan yang direncanakan meliputi:

- 1) Edukasi tentang penyakit hipertensi dan faktor risikonya
- 2) Edukasi kepatuhan minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan
- 3) Edukasi diet rendah garam dan pola makan sehat
- 4) Anjuran aktivitas fisik ringan dan teratur sesuai kemampuan pasien
- 5) Monitoring tekanan darah secara berkala

Intervensi tersebut mengacu pada SIKI: Edukasi Kesehatan dan Manajemen Penyakit Kronis (PPNI, 2022).

5. Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan diberikan secara bertahap dan menggunakan bahasa sederhana, meliputi:

- a. Diet: Mengurangi konsumsi garam, makanan berlemak, dan makanan olahan
- b. Aktivitas fisik: Melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki minimal 30 menit, 3–5 kali per minggu
- c. Kepatuhan obat: Menjelaskan pentingnya minum obat secara teratur meskipun tidak ada keluhan

Edukasi kesehatan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi dan mencegah komplikasi (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2023).

6. Evaluasi Hasil Asuhan Keperawatan (SOAP)

S (Subjective)

Pasien mengatakan sakit kepala berkurang dan mulai memahami pentingnya minum obat secara teratur.

O (Objective)

Tekanan darah: 140/90 mmHg Pasien mampu menyebutkan kembali diet yang dianjurkan dan jadwal minum obat.

A (Assessment)

Masalah manajemen kesehatan menunjukkan perbaikan.

P (Plan)

Asuhan keperawatan dilanjutkan dengan penguatan edukasi dan monitoring tekanan darah pada kunjungan berikutnya.

Evaluasi secara berkesinambungan diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengelolaan hipertensi jangka panjang (Potter et al., 2021).

Kasus 2: Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2

1. Gambaran Klinis Singkat

Ny. B, usia 50 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan sering merasa haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah sejak beberapa bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus Tipe 2 sejak 3 tahun yang lalu dan mengaku tidak teratur mengontrol kadar gula darah serta tidak konsisten menjalani diet diabetes. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah sewaktu 260 mg/dL. Pasien memiliki indeks massa tubuh berlebih dan aktivitas fisik yang rendah.

Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang melalui kombinasi terapi medis, asuhan keperawatan, dan edukasi perawatan mandiri untuk mencegah terjadinya komplikasi (ADA, 2024; Kemenkes RI, 2023).

2. Masalah Keperawatan Prioritas (SDKI)

Berdasarkan gambaran klinis dan hasil pengkajian, masalah keperawatan prioritas yang dapat ditegakkan adalah:

- a. Manajemen kesehatan tidak efektif
berhubungan dengan kurang pengetahuan dan ketidakpatuhan terhadap regimen perawatan diabetes
- b. Risiko kadar glukosa darah tidak stabil
berhubungan dengan pola makan tidak terkontrol dan aktivitas fisik rendah

Masalah keperawatan tersebut sesuai dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) pada pasien dengan penyakit kronis metabolik (PPNI, 2022).

3. Intervensi Keperawatan Mandiri dan Kolaboratif

- a. Intervensi Keperawatan Mandiri (SIKI)

Intervensi keperawatan mandiri yang dapat dilakukan perawat meliputi:

- 1) Monitoring kadar gula darah sesuai jadwal
- 2) Observasi tanda dan gejala hiperglikemia dan hipoglikemia
- 3) Edukasi tentang pola makan sehat untuk pasien diabetes
- 4) Edukasi pentingnya aktivitas fisik teratur
- 5) Motivasi pasien untuk melakukan perawatan mandiri secara konsisten

Intervensi ini bertujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola penyakit secara mandiri (PPNI, 2022).

- b. Intervensi Keperawatan Kolaboratif

Intervensi kolaboratif meliputi:

- 1) Kolaborasi dengan dokter dalam pengaturan terapi obat antidiabetik
- 2) Kolaborasi dengan ahli gizi dalam penyusunan diet diabetes yang sesuai
- 3) Rujukan ke fasilitas lanjutan apabila ditemukan tanda komplikasi

Kolaborasi antar profesi sangat diperlukan untuk mencapai pengendalian glikemik yang optimal dan mencegah komplikasi jangka panjang (ADA, 2024).

4. Edukasi Perawatan Mandiri dan Pencegahan Komplikasi

Edukasi perawatan mandiri diberikan secara berkesinambungan dengan fokus pada:

- a. Pengaturan pola makan: Mengatur jadwal makan, porsi seimbang, dan menghindari makanan tinggi gula sederhana
- b. Aktivitas fisik: Melakukan aktivitas fisik sedang seperti jalan kaki minimal 30 menit per hari
- c. Kepatuhan obat: Minum obat atau insulin sesuai anjuran tenaga kesehatan
- d. Perawatan kaki: Menjaga kebersihan kaki, memeriksa luka, dan menggunakan alas kaki yang sesuai
- e. Pencegahan komplikasi: Mengontrol gula darah secara rutin dan mengenali tanda komplikasi seperti luka sulit sembuh, gangguan penglihatan, dan kesemutan

Edukasi yang efektif terbukti meningkatkan kontrol glikemik dan menurunkan risiko komplikasi pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 (ADA, 2024; WHO, 2022).

Kasus 3: Pasien Lansia dengan Risiko Jatuh

1. Gambaran Klinis Singkat

Ny. C, usia 72 tahun, datang ke Puskesmas untuk kontrol rutin. Pasien mengeluh sering merasa pusing saat berdiri, penglihatan mulai kabur, dan pernah hampir jatuh di rumah dalam satu bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan osteoarthritis lutut, serta menggunakan lebih dari satu jenis obat setiap hari. Saat berjalan, pasien tampak langkah tidak stabil dan membutuhkan pegangan.

Lansia merupakan kelompok rentan mengalami jatuh akibat perubahan fisiologis, penyakit kronis, serta faktor lingkungan, sehingga pencegahan jatuh menjadi bagian penting dalam keselamatan pasien (WHO, 2021).

2. Faktor Risiko Jatuh

Faktor risiko jatuh pada pasien lansia dalam kasus ini meliputi:

- a. Usia lanjut (>65 tahun)
- b. Gangguan keseimbangan dan gaya berjalan
- c. Penurunan penglihatan
- d. Riwayat hampir jatuh sebelumnya

- e. Penyakit kronis (hipertensi, osteoarthritis)
- f. Penggunaan banyak obat (polifarmasi)
- g. Lingkungan rumah yang kurang aman

Identifikasi faktor risiko merupakan langkah awal dalam pencegahan jatuh pada pasien lansia (Kemenkes RI, 2023).

3. Diagnosis Keperawatan Risiko (SDKI)

Berdasarkan faktor risiko yang ditemukan, diagnosis keperawatan yang ditegakkan adalah:

Risiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan, penurunan kekuatan otot, dan perubahan sensorik pada lansia.

Diagnosis ini sesuai dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) dan termasuk diagnosis risiko yang memerlukan tindakan pencegahan aktif (PPNI, 2022).

4. Intervensi Pencegahan Jatuh

a. Intervensi Keperawatan Mandiri (SIKI)

Intervensi keperawatan mandiri meliputi:

- 1) Mengkaji risiko jatuh secara berkala
- 2) Membantu pasien saat mobilisasi
- 3) Mengajarkan teknik bangun dan berdiri secara perlahan
- 4) Menganjurkan penggunaan alas kaki yang tidak licin
- 5) Edukasi penggunaan alat bantu jalan bila diperlukan

b. Intervensi Keperawatan Kolaboratif

Intervensi kolaboratif meliputi:

- 1) Kolaborasi dengan dokter terkait evaluasi obat yang berisiko menyebabkan pusing
- 2) Kolaborasi dengan fisioterapis untuk latihan keseimbangan dan penguatan otot
- 3) Kolaborasi dengan keluarga dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman

Intervensi pencegahan jatuh bertujuan menurunkan insiden cedera dan meningkatkan keselamatan pasien lansia (PPNI, 2022; WHO, 2021).

5. Evaluasi Keselamatan Pasien

Evaluasi keselamatan pasien dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan:

- a. Tidak terjadinya kejadian jatuh selama masa pemantauan
- b. Pasien mampu melakukan mobilisasi dengan lebih aman
- c. Pasien dan keluarga memahami langkah-langkah pencegahan jatuh
- d. Lingkungan rumah dan fasilitas pelayanan lebih aman bagi lansia

Evaluasi yang efektif membantu memastikan intervensi pencegahan jatuh berjalan optimal dan berkelanjutan (Kemenkes RI, 2023).

Kasus 4: Pasien dengan Nyeri Akut

1. Gambaran Klinis Singkat

Tn. D, usia 40 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri pada daerah pinggang sejak 2 hari terakhir setelah mengangkat beban berat. Pasien menyatakan nyeri terasa menusuk, memberat saat bergerak, dan berkurang saat istirahat. Pasien belum mengonsumsi obat pereda nyeri. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, namun pasien tampak meringis saat bergerak.

Nyeri akut merupakan respons fisiologis dan psikologis terhadap kerusakan jaringan atau rangsangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, sehingga memerlukan pengkajian dan penatalaksanaan keperawatan yang tepat (IASP, 2020; PPNI, 2022).

2. Pengkajian Nyeri

Pengkajian nyeri dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan PQRST, meliputi:

- a. P (Provocation/Palliation): Nyeri bertambah saat bergerak, berkurang saat istirahat
- b. Q (Quality): Nyeri menusuk
- c. R (Region/Radiation): Nyeri terlokalisasi di pinggang
- d. S (Severity): Skala nyeri 6 dari 10
- e. T (Time): Nyeri dirasakan terus-menerus sejak 2 hari terakhir

Pengkajian nyeri yang akurat membantu perawat menentukan intervensi keperawatan yang sesuai dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diberikan (Potter et al., 2021).

3. Manajemen Nyeri Nonfarmakologi

Berdasarkan diagnosis keperawatan Nyeri akut (SDKI), intervensi keperawatan nonfarmakologi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Posisi nyaman untuk mengurangi ketegangan otot
- b. Teknik relaksasi napas dalam
- c. Kompres hangat pada area nyeri
- d. Distraksi seperti mendengarkan musik atau berbincang ringan
- e. Edukasi postur tubuh yang benar saat beraktivitas

Manajemen nyeri nonfarmakologi efektif dalam menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien, serta aman dilakukan oleh perawat sesuai kewenangan (PPNI, 2022; IASP, 2020).

4. Evaluasi Respon Pasien

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah intervensi keperawatan, meliputi:

- Penurunan skala nyeri (misalnya dari 6 menjadi 3)
- Ekspresi wajah lebih rileks dan pasien tampak lebih nyaman
- Pasien mampu melakukan gerakan ringan dengan nyeri berkurang
- Pasien mampu menjelaskan kembali teknik nonfarmakologi yang diajarkan

Evaluasi yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan manajemen nyeri efektif dan menentukan kebutuhan intervensi lanjutan atau kolaborasi (Potter et al., 2021).

H. Tabel Ringkasan Asuhan Keperawatan

Tabel 3.1 Ringkasan Asuhan Keperawatan

Kasus 1: Pasien Hipertensi di Puskesmas

Komponen	Uraian
Masalah Keperawatan	Manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan
Tujuan	Pasien mampu mengelola hipertensi secara mandiri dan menunjukkan kepatuhan terhadap terapi
Intervensi	Edukasi hipertensi, diet rendah garam, anjuran aktivitas fisik ringan, monitoring tekanan darah
Evaluasi	Tekanan darah menurun, pasien mampu menjelaskan kembali cara pengelolaan hipertensi

Tabel 3.2 Ringkasan Asuhan Keperawatan

Kasus 2: Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2

Komponen	Uraian
Masalah Keperawatan	Manajemen kesehatan tidak efektif dan risiko kadar glukosa darah tidak stabil
Tujuan	Pasien mampu melakukan perawatan mandiri diabetes dan menjaga kadar glukosa darah
Intervensi	Monitoring gula darah, edukasi diet diabetes, aktivitas fisik teratur, kepatuhan obat, perawatan kaki
Evaluasi	Pasien memahami perawatan mandiri dan menunjukkan kontrol gula darah yang lebih baik

**Tabel 3.3 Ringkasan Asuhan Keperawatan
Kasus 3: Pasien Lansia dengan Risiko Jatuh**

Komponen	Uraian
Masalah Keperawatan	Risiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan dan perubahan fisik lansia
Tujuan	Tidak terjadi kejadian jatuh dan pasien mampu beraktivitas dengan aman
Intervensi	Edukasi pencegahan jatuh, bantuan mobilisasi, penggunaan alas kaki aman, modifikasi lingkungan
Evaluasi	Pasien lebih stabil saat berjalan dan keluarga memahami pencegahan jatuh

**Tabel 4. Ringkasan Asuhan Keperawatan
Kasus 4: Pasien dengan Nyeri Akut**

Komponen	Uraian
Masalah Keperawatan	Nyeri akut berhubungan dengan cedera jaringan
Tujuan	Intensitas nyeri menurun dan pasien merasa lebih nyaman
Intervensi	Pengaturan posisi, teknik relaksasi napas dalam, kompres hangat, distraksi
Evaluasi	Skala nyeri menurun dan pasien mampu melakukan aktivitas ringan

Catatan Pembelajaran untuk Mahasiswa

Tabel ringkasan ini membantu mahasiswa:

1. Mengidentifikasi hubungan antara masalah–tujuan–intervensi–evaluasi,
2. Memahami alur proses keperawatan secara ringkas,
3. Melatih kemampuan menyusun dokumentasi asuhan keperawatan sederhana.

I. Simpulan

1. Kesimpulan Utama

Chapter ini menegaskan bahwa penerapan konsep keperawatan secara sistematis dan berbasis bukti merupakan fondasi utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan bermutu. Melalui pembahasan kasus dan analisis klinik, mahasiswa memahami pentingnya keterpaduan antara pengkajian yang komprehensif, penetapan masalah keperawatan yang tepat, perencanaan intervensi yang rasional, serta evaluasi hasil asuhan secara berkelanjutan. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi profesional sebagai perawat vokasi.

2. Relevansi Chapter dengan Praktik Klinik Nyata

Materi dalam chapter ini memiliki keterkaitan langsung dengan praktik klinik di lapangan, khususnya dalam pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Konsep dan langkah-langkah asuhan keperawatan yang dibahas mencerminkan situasi klinik yang sering dijumpai oleh perawat vokasi, sehingga membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan realitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, chapter ini mendukung kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika praktik klinik serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan keperawatan secara tepat dan bertanggung jawab.

3. Penguatan Peran Perawat Vokasi

Chapter ini memperkuat peran perawat vokasi sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan asuhan keperawatan dasar hingga lanjutan sesuai kewenangan. Perawat vokasi dituntut untuk mampu melaksanakan tindakan keperawatan secara mandiri, bekerja sama dalam tim kesehatan, serta berperan aktif dalam edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit. Penguasaan materi dalam chapter ini diharapkan dapat membentuk perawat vokasi yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki sikap profesional, etika kerja yang baik, dan kepekaan terhadap kebutuhan pasien dalam praktik keperawatan sehari-hari.

J. Referensi

- American Diabetes Association. (2024). *Standards of care in diabetes—2024*. Diabetes Care, 47(Suppl. 1), S1–S350. <https://doi.org/10.2337/dc24-SINT>
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2022). *Nursing interventions classification (NIC)* (8th ed.). Elsevier.
- Carpenito-Moyet, L. J. (2021). *Handbook of nursing diagnosis* (16th ed.). Wolters Kluwer.
- Dinas Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan usia lanjut*. Kementerian Kesehatan RI.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023*. Thieme.
- Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L. (2021). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman teknis penemuan dan tatalaksana hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan primer*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Panduan praktik klinis bagi perawat di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Standar kompetensi perawat vokasi (Diploma III Keperawatan)*. Kemenkes RI.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2023). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- PPNI. (2019). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI)* (Edisi 2). Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI)* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2022). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (11th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2021). *WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in adults*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *Global report on hypertension: The race against a silent killer*. WHO Press.
- World Health Organization. (2023). *WHO consolidated guidelines on diabetes prevention and management*. WHO Press.

K. Glosarium

Analisis Data

Proses menelaah dan mengelompokkan data hasil pengkajian untuk mengidentifikasi masalah keperawatan yang dialami pasien.

Asuhan Keperawatan

Rangkaian kegiatan keperawatan yang diberikan kepada pasien secara sistematis meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kemampuan yang harus dimiliki lulusan program pendidikan keperawatan, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai standar nasional.

Diagnosis Keperawatan

Keputusan klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau risiko masalah kesehatan yang menjadi dasar intervensi keperawatan (SDKI).

Dokumentasi Asuhan Keperawatan

Catatan tertulis mengenai seluruh proses dan tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien sebagai alat komunikasi, bukti legal, dan indikator mutu pelayanan.

Edukasi Kesehatan

Proses pemberian informasi dan pembelajaran kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat.

Evaluasi Keperawatan

Proses menilai respons pasien terhadap intervensi keperawatan dan tingkat pencapaian tujuan asuhan keperawatan.

Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan sesuai kebutuhan pasien.

Intervensi Keperawatan

Tindakan keperawatan mandiri, kolaboratif, atau delegatif yang dilakukan untuk mencapai luaran keperawatan (SIKI).

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera atau kejadian tidak diharapkan pada pasien selama menerima pelayanan kesehatan.

Manajemen Nyeri

Upaya keperawatan untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri pasien melalui pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis.

Masalah Keperawatan

Kondisi atau respons pasien terhadap masalah kesehatan yang dapat ditangani oleh intervensi keperawatan.

Nyeri Akut

Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial, bersifat tiba-tiba dan berlangsung singkat.

Pasien Risiko Jatuh

Pasien yang memiliki faktor-faktor tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya jatuh, seperti usia lanjut, gangguan keseimbangan, atau kelemahan fisik.

Pengkajian Keperawatan

Proses pengumpulan data secara sistematis dan berkesinambungan tentang kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.

Perencanaan Keperawatan

Tahap proses keperawatan yang menetapkan tujuan, kriteria hasil (SLKI), dan intervensi keperawatan (SIKI) berdasarkan diagnosis keperawatan.

Perawat Vokasi

Perawat lulusan pendidikan Diploma III yang memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan dasar secara profesional, aman, dan etis.

Proses Keperawatan

Pendekatan sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan yang terdiri dari lima tahap: pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

SOAP

Format dokumentasi keperawatan yang terdiri dari Subjective, Objective, Assessment, dan Plan.

DARE

Format dokumentasi keperawatan yang terdiri dari Data, Action, Response, dan Evaluation.

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)

Standar nasional yang memuat daftar diagnosis keperawatan yang digunakan oleh perawat di Indonesia.

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)

Standar nasional yang berisi intervensi keperawatan untuk mengatasi diagnosis keperawatan.

Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)

Standar nasional yang memuat luaran dan indikator keberhasilan asuhan keperawatan.

CHAPTER 4

PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM BERBAGAI SITUASI KLINIK IBU POST PARTUM DENGAN NYERI LUKA SECTIO CAESAREA : PENDEKATAN KEPERAWATAN PRAKTIS

Ns. Nina Sunarti, M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Melahirkan adalah peristiwa besar dalam kehidupan seorang perempuan. Di balik tangis pertama bayi yang membawa haru dan bahagia, terdapat perjalanan fisik dan emosional yang tidak selalu mudah untuk dilalui. Namun, dalam perkembangan pelayanan kesehatan maternitas modern, persalinan tidak selalu berlangsung secara normal pervaginam. Sectio caesarea (SC) menjadi salah satu tindakan operatif yang semakin sering dilakukan, baik karena indikasi medis maupun pertimbangan tertentu lainnya.[1] Peningkatan angka persalinan melalui sectio caesarea secara global maupun nasional membawa implikasi klinis yang signifikan, khususnya pada periode post partum.[2]

Nyeri luka *sectio caesarea* bukan sekedar sensasi fisik dan cedera anatomis yang dirasakan diarea pembedahan. Nyeri ini timbul akibat respons inflamasi tubuh terhadap trauma jaringan dan keberadaan benda asing (benang jahitan) yang menjadi sumber ketidaknyamanan signifikan. Hal ini dapat membayangi hari-hari awal mereka sebagai orang tua.[3] Nyeri yang dirasakan tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, memberikan pengalaman menyeluruh yang mempengaruhi jika tidak dikelola dengan tepat beresiko menghambat dalam proses ikatan kasih sayang (*bonding attachment*) antara ibu dan bayi, mobilitas sehari-hari, kualitas istirahat, proses menyusui, hingga kondisi psikologis ibu dimasa nifas.[4]

Rasa nyeri dapat membuat ibu merasa rapuh disaat dirinya dituntut untuk kuat mengasuh, menyusui, dan beradaptasi dengan peran barunya.[4] Persepsi nyeri bersifat sangat subjektif, dipengaruhi oleh ambang batas nyeri individu, pengalaman persalinan sebelumnya, hingga dukungan sosial yang diterima. Sering kali, dalam kesibukan melakukan perawatan bayi baru lahir yang menuntut perhatian penuh, rasa sakit fisik yang dialami ibu menjadi terabaikan atau dianggap sebagai "konsekuensi wajar" dari persalinan.

Menurut data WHO dan penelitian global, sekitar 1 dari 5 kelahiran (21 %) dilakukan dengan tindakan Sectio Caesarea diseluruh dunia. Tren ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan beberapa dekade lalu, dan angka ini

diproyeksikan meningkat hingga sekitar 29% pada tahun 2030. [5] Berdasarkan analisis data survei (SKI/kelahiran nasional hingga 2023), prevalensi persalinan dengan Sectio Caesarea di Indonesia mencapai sekitar 25,9% dari seluruh persalinan. Data ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka 17,6% dari Riskesdas 2018, menunjukkan tren kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.[6] Indonesia kini berada diatas rata-rata global, dengan estimasi 25–26% persalinan melalui sectio caesarea. Tren global meningkat, terutama dinegara berpendapatan menengah dan tinggi, dengan faktor pendorong seperti usia ibu yang lebih tua, komplikasi kehamilan, dan preferensi personal/klinikal.[2][7] Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan, dari jutaan ibu nifas yang tercatat setiap tahunnya, mayoritas mengalami nyeri pasca persalinan akibat luka Sectio Caesarea yang jika tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat, dapat meningkatkan risiko infeksi masa nifas sebagai salah satu penyebab angka kematian ibu.[2][4] Fenomena ini menegaskan bahwa kebutuhan akan perawatan luka Sectio Caesarea yang praktis bukan sekedar prosedur klinis rutin melainkan intervensi penting bagi pemulihan fisik dan psikologis jutaan ibu di Indonesia.[4][3]

Pendekatan keperawatan praktis yang diusung dalam tulisan ini tidak hanya berfokus pada aspek farmakologis atau pembersihan luka secara teknis. Lebih dari itu, kita perlu mengintegrasikan elemen kemanusiaan, yaitu memandang ibu sebagai subjek yang utuh, bukan sekedar dengan keluhan fisik. Asuhan keperawatan menekankan pada empati, komunikasi terapeutik yang tulus, dan penghormatan terhadap martabat ibu. Etika seorang perawat menyapa dengan kehangatan, mendengarkan keluhan nyeri tanpa menghakimi, dan memberikan edukasi dengan bahasa yang menenangkan, perawat sedang melakukan intervensi penyembuhan yang jauh lebih kuat daripada sekedar memberikan obat analgesic.[4]

Dalam bab ini kita akan mengeksplorasi strategi-strategi praktis yang dapat diterapkan ditatanan klinis maupun dirumah untuk mengelola nyeri luka Sectio Caesarea. Pembahasan mencakup teknik non farmakologis seperti teknik relaksasi nafas dalam,[8] mobilisasi dini,[9] hingga pengaturan posisi yang ergonomis saat menyusui guna meminimalkan tekanan pada area luka.[10] Namun, benang merah dari seluruh teknik tersebut adalah bagaimana cara penyampaiannya. Asuhan keperawatan harus dilakukan dengan “sentuhan lembut” (*gentle care*) yang mengakui bahwa dibalik luka jahitan tersebut, ada seorang wanita yang sedang beradaptasi dengan identitas barunya., yang mungkin merasa rentan, lelah, dan membutuhkan penguatan moral.[4]

Penting juga untuk menyadari bahwa edukasi mandiri merupakan pilar utama dalam perawatan postpartum. Ibu perlu diberdayakan untuk memahami tanda-tanda infeksi, cara menjaga kebersihan area luka Sectio Caesarea secara mandiri,

serta kapan harus mencari bantuan medis. Dengan membekali ibu dengan pengetahuan yang memadai melalui cara-cara yang suportif, kita membantu membangun kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri ini adalah kunci utama agar ibu dapat pulih lebih cepat secara fisik dan mental sehingga ibu dapat menjalankan perannya dalam merawat buah hati dengan optimal.[1][7]

Dalam praktik klinik, peran keperawatan menjadi sangat bermakna, penatalaksanaan nyeri post sectio caesarea masih sering berfokus pada pendekatan farmakologis. Meskipun terapi farmakologis memiliki peran penting, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan asuhan keperawatan yang holistik. Intervensi keperawatan nonfarmakologis, seperti menyediakan pendamping yang memahami, mendengar, dan menguatkan. Pendekatan keperawatan yang praktis, empatik, dan berbasis kebutuhan ibu postpartum menjadi kunci untuk membantu proses pemulihan yang optimal, aman, dan bermartabat.[3] Beberapa tehnik untuk mengurangi nyeri dapat direkomendasikan seperti teknik relaksasi nafas dalam,[8] mobilisasi dini yang aman,[11] pengaturan posisi yang tepat,[10] serta sentuhan terapeutik berupa *foot massage*,[12][13] merupakan bagian integral dari praktik keperawatan yang berbasis kebutuhan pasien. Namun, dalam kenyataannya, intervensi tersebut belum selalu diterapkan secara sistematis dan optimal diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Peningkatan angka persalinan sectio caesarea menempatkan nyeri luka post partum sebagai masalah keperawatan yang sering dijumpai dan berdampak signifikan terhadap pemulihan fisik, psikologis, serta kualitas hidup ibu.[6][4] Pengelolaan nyeri yang masih dominan bersifat farmakologis, keterbatasan penerapan intervensi keperawatan nonfarmakologis, serta adanya kesenjangan antara hasil penelitian dan praktik klinik menunjukkan perlunya panduan keperawatan yang aplikatif dan berbasis bukti. Oleh karena itu, book chapter ini menjadi urgensi akademik dan klinik untuk memperkuat peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan post partum yang holistik, efektif, dan kontekstual pada ibu dengan nyeri luka sectio caesarea.

B. Konsep Teori

1. Anatomi dan Fisiologi luka Sectio caesarea

Sectio caesarea (SC) adalah tindakan pembedahan untuk melahirkan janin melalui sayatan pada dinding abdomen dan uterus. Luka SC melibatkan beberapa lapisan jaringan, yaitu kulit, jaringan subkutan (lemak), fascia (fascia rektus), otot dinding perut (muskulus rectus abdominis), peritoneum dan dinding uterus (miometrium dan endometrium). Secara fisiologis, masing-masing lapisan memiliki fungsi yaitu kulit dan subkutan berfungsi sebagai proteksi dan regulasi

suhu. Fascia dan otot berfungsi sebagai penopang struktur abdomen. Peritoneum berfungsi sebagai pelindung organ intra abdomen dan uterus berfungsi sebagai kontraksi involusi dan hemostasis pasca persalinan.

a. Mekanisme terjadinya luka[14]

Luka sectio caesarea terjadi melalui tindakan pembedahan terencana atau emergensi dengan mekanisme sebagai berikut, sayatan kulit dan jaringan bawahnya menggunakan pisau bedah. Pembukaan lapisan dinding abdomen secara berurutan hingga mencapai uterus. Insisi uterus (biasanya transversal segmen bawah) untuk mengeluarkan janin dan plasenta. Penjahitan kembali lapisan jaringan setelah tindakan selesai. Luka bersifat luka bersih (*clean wound*) namun berisiko infeksi karena perdarahan, kelembaban area luka dan penurunan imunitas ibu pasca persalinan

b. Fase penyembuhan jaringan[14]

- 1) Fase Inflamasi (0–3 hari) : Terjadi vasodilatasi dan respon inflamasi. Ditandai nyeri, edema, kemerahan di area insisi. Leukosit membersihkan jaringan rusak dan mikroorganisme. Dan kontraksi uterus membantu hemostasis pada luka uterus
- 2) Fase Proliferasi (3–21 hari) : Fibroblas membentuk kolagen. Terjadi angiogenesis dan epitelisasi luka kulit. Luka uterus mengalami proses involusi. Kekuatan luka meningkat, nyeri berkurang.
- 3) Fase Pematangan/*Remodelling* (3 minggu–6 bulan) : Kolagen tipe III digantikan kolagen tipe I. Jaringan parut menjadi lebih kuat dan elastis. Warna luka memucat dan permukaan lebih rata. Kekuatan jaringan mencapai $\pm 70\text{--}80\%$ dari normal.

2. Dimensi nyeri postpartum dengan Sectio Caesarea

Nyeri postpartum merupakan pengalaman multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, psikologis, dan sosial budaya. Pemahaman terhadap dimensi nyeri sangat penting bagi perawat agar dapat memberikan asuhan yang komprehensif dan berpusat pada ibu.[14]

a. Faktor fisik[3]

Faktor fisik merupakan penyebab utama nyeri pada masa postpartum, antara lain:

- 1) Nyeri luka operasi section caesarea, kerusakan jaringan akibat sayatan dan penjahitan menimbulkan nyeri inflamasi, terutama saat bergerak, duduk, atau batuk.
- 2) Kontraksi uterus (*afterpains*), terutama saat menyusui, dapat menimbulkan nyeri seperti kram perut.

- 3) Edema dan inflamasi jaringan, memperberat rasa nyeri dan ketidaknyamanan.
 - 4) Kelelahan fisik, karena proses persalinan, kurang tidur, dan aktivitas merawat bayi meningkatkan persepsi nyeri.
 - 5) Perubahan hormonal, estrogen dan progesteron mempengaruhi ambang nyeri dan respon tubuh terhadap nyeri.
- b. Faktor psikologis dan budaya[3][4]
- Nyeri postpartum tidak hanya bersumber dari kerusakan jaringan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan latar belakang budaya.
- 1) Faktor Psikologis: kecemasan, ketakutan terhadap luka, nyeri, atau proses pemulihan, stres, kelelahan emosional, pengalaman persalinan sebelumnya, terutama yang traumatis, dan dukungan sosial yang kurang dari pasangan atau keluarga.
 - 2) Faktor Budaya: keyakinan bahwa nyeri adalah hal yang harus ditahan. Pantangan bergerak setelah melahirkan yang dapat memperlambat pemulihan. Kepercayaan tradisional terkait perawatan luka dan nyeri. Budaya dapat mempengaruhi cara ibu mengekspresikan nyeri dan kesediaannya menerima intervensi keperawatan.
- c. Dampak nyeri terhadap kualitas hidup[4]
- Nyeri postpartum yang tidak tertangani dengan baik dapat berdampak luas terhadap kualitas hidup ibu, antara lain:
- 1) Gangguan aktivitas sehari-hari, ibu kesulitan duduk, berjalan, atau merawat bayi.
 - 2) Gangguan istirahat dan tidur, nyeri menghambat kualitas tidur sehingga memperlambat proses pemulihan.
 - 3) Hambatan dalam menyusui, posisi menyusui menjadi tidak nyaman akibat nyeri.
 - 4) Penurunan kesejahteraan psikologis, nyeri berkepanjangan dapat memicu stres, *baby blues*, bahkan depresi postpartum.
 - 5) Penurunan peran dan fungsi sosial, ibu merasa terbatas dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan anggota keluarga.

3. Komunikasi dan pengkajian nyeri

Komunikasi terapeutik merupakan dasar dalam pengkajian nyeri, terutama pada ibu postpartum yang berada dalam kondisi fisik dan emosional yang sensitif. Cara perawat berkomunikasi dapat mempengaruhi kepercayaan, kenyamanan, serta keakuratan informasi nyeri yang disampaikan oleh ibu.

a. Teknik pengkajian PQRST dengan empati

Metode PQRST digunakan untuk mengkaji nyeri secara sistematis, namun harus disampaikan dengan pendekatan empatik agar ibu merasa didengar dan dipahami. Penggunaan bahasa lembut dan nada suara tenang membantu ibu lebih terbuka dalam mengungkapkan pengalaman nyerinya.

1) P (*Provocation/Palliation*)

"Apa yang biasanya membuat nyeri ini muncul atau bertambah, Bu? Apakah ada posisi yang membantu mengurangnya?"

2) Q (*Quality*)

"Bisa Ibu ceritakan seperti apa rasa nyerinya? Apakah seperti ditarik, perih, atau berdenyut?"

3) R (*Region/Radiation*)

"Nyeri ini dirasakan dibagian mana? Apakah menjalar ke area lain?"

4) S (*Severity*)

"Jika dinilai dari skala 0 sampai 10, seberapa kuat nyeri yang Ibu rasakan saat ini?"

5) T (*Time*)

"Sejak kapan nyeri ini dirasakan dan apakah datangnya terus-menerus atau hilang timbul?"

b. Menggunakan kata-kata yang menenangkan

Pemilihan kata sangat berpengaruh terhadap respon emosional ibu postpartum. Perawat perlu menggunakan kata-kata yang menenangkan dan memberi rasa aman, seperti:

1) *"Saya mengerti nyeri ini membuat Ibu tidak nyaman."*

2) *"Nyeri yang Ibu rasakan adalah hal yang sering terjadi, dan kami akan membantu mengurangnya."*

3) *"Ibu tidak sendirian, saya ada di sini untuk membantu."*

4) *"Silakan beri tahu saya jika nyeri bertambah atau terasa berbeda."*

Hindari kalimat yang meremehkan nyeri, seperti *"Ini biasa saja"* atau *"Harus ditahan"*, karena dapat menurunkan kepercayaan ibu.

c. Menghargai privasi dan martabat

Pengkajian nyeri, khususnya pada ibu postpartum, sering melibatkan area tubuh yang sensitif. Oleh karena itu, perawat wajib menjaga privasi dan martabat ibu. Sikap menghargai martabat akan meningkatkan rasa aman dan kerja sama ibu dalam proses pengkajian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1) Menutup tirai atau pintu sebelum pemeriksaan

2) Meminta izin sebelum menyentuh area luka

- 3) Menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan
- 4) Menggunakan bahasa sopan dan tidak menghakimi
- 5) Memberi kesempatan ibu untuk menolak atau menunda pemeriksaan jika belum siap

4. Manajemen keperawatan praktis non farmakologis

a. Tehnik nafas dalam (*Deep Breathing*)[8]

Teknik ini merupakan pendekatan nonfarmakologis untuk menurunkan nyeri dan relaksasi otot.

Langkah-langkah: pasien duduk atau berbaring nyaman, instruksikan pasien menarik napas perlahan melalui hidung sampai perut mengembang, tahan napas selama 2–3 detik, hembuskan perlahan melalui mulut, dan ulangi 5–10 kali, 2–3 kali sehari

Manfaat: menurunkan intensitas nyeri dengan relaksasi otot, meningkatkan oksigenasi dan ventilasi paru dan mengurangi kecemasan akibat rasa sakit

b. Mobilisasi bertahap[16][11][9][14]

Mobilisasi bertahap sangat penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, mencegah trombosis, dan mempercepat proses pemulihan.

Tahapan: Hari 0–1: Duduk di tepi ranjang dengan bantuan. Hari 1–2: Berdiri dan berjalan beberapa meter dikamar. Dan Hari 2–3: Jalan lebih jauh di lorong dengan bantuan jika perlu.

c. Pengaturan Posisi Nyaman[10]

Posisi istirahat juga berpengaruh pada tingkat kenyamanan dan nyeri.

Rekomendasi: Gunakan posisi semi-Fowler (kepala terangkat 30–45°) untuk mengurangi ketegangan pada luka. Gunakan bantal dibawah lutut atau pinggang untuk dukungan. Saat batuk atau bergerak, tempatkan bantal menekan diatas luka sebagai “support” untuk mengurangi nyeri.

Manfaat: Mengurangi tekanan pada luka operasi dan meningkatkan kenyamanan saat beristirahat

d. *Foot Massage*[12][13]

Foot massage adalah pendekatan nonfarmakologis yang efektif untuk meredakan nyeri pasca operasi.

Prosedur: gunakan minyak atau lotion pijat yang nyaman. Pijat lembut telapak kaki, tumit, dan area betis selama 15–30 menit. Lakukan 1–2 kali sehari sesuai tolak ukur kenyamanan pasien.

Efek/Manfaat: mengalihkan fokus dari sensasi nyeri dilokasi luka, merangsang peredaran darah, dan memberikan rasa relaksasi.

5. Nutrisi dan hidrasi untuk regenerasi jaringan

Nutrisi dan hidrasi yang adekuat berperan penting dalam proses penyembuhan luka postpartum. Asupan gizi yang tepat membantu regenerasi jaringan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah komplikasi yang dapat memperlambat pemulihan ibu.

a. Peran protein tinggi

Protein merupakan komponen utama dalam proses pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, khususnya pada luka jahitan. Peran protein dalam regenerasi jaringan: membentuk kolagen dan jaringan baru pada luka, mempercepat fase proliferasi dan maturasi luka, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, membantu kontraksi uterus dan pemulihan jaringan otot.

Sumber protein yang dianjurkan: Protein hewani: telur, ikan, ayam, daging tanpa lemak, susu. Protein nabati: tahu, tempe, kacang-kacangan. Kombinasi protein hewani dan nabati untuk hasil optimal. Pada ibu post Sectio Caesarea, kebutuhan protein meningkat untuk mendukung penyembuhan luka operasi dan produksi ASI.

b. Pencegahan konstipasi

Konstipasi merupakan masalah yang sering dialami ibu postpartum, terutama setelah operasi Sectio Caesarea, dan dapat meningkatkan nyeri akibat tekanan saat mengejan. Faktor penyebab konstipasi: penurunan aktivitas fisik, efek anestesi dan obat pasca operasi, asupan cairan dan serat yang kurang, rasa takut mengejan karena nyeri luka. Upaya pencegahan konstipasi: cukup cairan ($\pm 2-3$ liter/hari sesuai kondisi), konsumsi serat dari sayur, buah, dan biji-bijian, mobilisasi dini bertahap, pola BAB teratur, tidak menahan keinginan BAB, edukasi teknik mengejan yang aman dan relaks.

Manfaat pencegahan konstipasi: mengurangi tekanan pada luka Sectio Caesarea, menurunkan risiko nyeri, mendukung kenyamanan dan kualitas hidup ibu.

6. Peran Pendamping (suami/keluarga) dalam dukungan psikososial

Dukungan psikososial dari suami dan keluarga memiliki peran penting dalam proses pemulihan ibu postpartum. Kehadiran pendamping yang suportif dapat membantu menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa aman, serta mempercepat adaptasi ibu terhadap peran barunya.

a. Edukasi bagi suami

Edukasi kepada suami merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan keluarga. Pengetahuan yang baik akan membantu suami memberikan dukungan yang tepat dan bermakna.[19] Bentuk edukasi yang perlu diberikan:

pemahaman kondisi ibu postpartum, termasuk nyeri luka, perubahan emosi, dan kelelahan, cara membantu aktivitas harian ibu, seperti membantu mobilisasi, perawatan bayi, dan pekerjaan rumah, tanda bahaya pasca persalinan yang perlu segera dilaporkan, teknik dukungan emosional, seperti mendengarkan tanpa menghakimi dan memberi kata-kata positif. Peran suami dalam keberhasilan menyusui, termasuk membantu posisi ibu agar nyaman. Dampak edukasi bagi suami: meningkatkan empati dan keterlibatan suami, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam masa pemulihan.

b. Menciptakan lingkungan yang suportif

Lingkungan yang suportif berperan besar dalam menjaga kesejahteraan psikologis ibu postpartum. Upaya menciptakan lingkungan yang suportif: memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu, baik secara fisik maupun emosional, menghargai perasaan dan pengalaman nyeri ibu, mengurangi tekanan dan tuntutan, termasuk membatasi tamu berlebihan, menjaga komunikasi yang positif didalam keluarga, mendukung waktu istirahat ibu dengan membantu perawatan bayi.

Manfaat lingkungan suportif: menurunkan tingkat stres dan kecemasan, membantu adaptasi peran ibu, meningkatkan kualitas tidur dan pemulihan, mengurangi risiko baby blues dan depresi postpartum.

7. Kapan harus mencari bantuan medis

Pemantauan kondisi ibu postpartum, khususnya setelah tindakan pembedahan adanya luka Sectio Caesarea, sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Mengenali tanda bahaya sejak dini membantu ibu dan keluarga segera mencari bantuan medis yang tepat.

a. Indikator infeksi

Infeksi merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada luka jahitan postpartum, termasuk luka sectio caesarea. Tanda dan gejala infeksi: kemerahan meluas disekitar luka, pembengkakan dan nyeri bertambah yang tidak membaik, keluar cairan bernanah atau berbau dari luka, demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, luka terasa panas saat diraba, lemas dan tidak enak badan.

Tindakan yang perlu dilakukan: segera melaporkan kepada tenaga kesehatan, jangan mengoleskan bahan atau obat tanpa anjuran medis, menjaga kebersihan luka sambil menunggu pemeriksaan.

b. Dehisensi luka

Dehisensi luka adalah terbukanya kembali luka operasi sebagian atau seluruhnya, yang memerlukan penanganan medis segera. Tanda dan gejala dehisensi luka: luka tampak terbuka atau menganga, jahitan terlepas, keluar

darah atau cairan berlebihan, nyeri mendadak dan hebat, terlihat jaringan di dalam luka.

Faktor risiko dehisensi: infeksi luka, aktivitas berlebihan terlalu dini, batuk keras atau mengejan berlebihan, nutrisi dan hidrasi yang tidak adekuat.

Tindakan segera: menutup luka dengan kasa bersih, mengurangi gerakan, segera mencari bantuan medis.

8. Konsep teori dalam manajemen nyeri non farmakologis

a. Teori nyeri *gate control* yang dikemukakan oleh *Melzack* dan *Wall*

Teori *Gate Control of Pain* dikemukakan oleh *Ronald Melzack* dan *Patrick Wall* pada tahun 1965. Teori ini menjelaskan bahwa nyeri tidak hanya ditentukan oleh rangsangan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme saraf disistem saraf pusat serta faktor psikologis. Menurut teori ini, terdapat suatu "gerbang" (gate) pada kornu dorsalis medula spinalis yang berfungsi mengatur impuls nyeri sebelum diteruskan ke otak.

Impuls nyeri yang dibawa oleh serabut saraf kecil (A-delta dan C) akan membuka gerbang sehingga nyeri dirasakan. Sebaliknya, stimulasi pada serabut saraf besar (A-beta), seperti sentuhan, tekanan, atau pijatan, dapat menutup gerbang, sehingga transmisi impuls nyeri ke otak berkurang. Selain rangsangan perifer, faktor psikologis seperti perhatian, emosi, kecemasan, dan pengalaman sebelumnya juga memengaruhi buka-tutupnya gerbang nyeri melalui mekanisme kontrol desenden dari otak.

Dengan demikian, teori *Gate Control* menjelaskan bahwa nyeri dapat dikurangi melalui stimulasi nonfarmakologis, seperti teknik relaksasi, napas dalam, perubahan posisi, mobilisasi dini, dan pijatan, yang bekerja dengan cara menutup gerbang nyeri pada medula spinalis.

b. Teori Relaksasi Benson

Teori Relaksasi Benson dikemukakan oleh Herbert Benson dan menjelaskan bahwa relaksasi merupakan respon fisiologis tubuh yang berlawanan dengan respon stres (relaxation response). Respon ini ditandai dengan penurunan aktivitas sistem saraf simpatis, seperti penurunan frekuensi nadi, tekanan darah, frekuensi napas, dan ketegangan otot. Relaksasi Benson dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada satu kata, kalimat, atau doa yang diulang secara ritmis, disertai pernapasan teratur dan sikap pasrah. Mekanisme ini membantu menekan rangsangan stres, meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis, serta merangsang pelepasan endorfin yang berperan dalam menurunkan persepsi nyeri.

c. Teori Recovery Enhancement

Teori *Recovery Enhancement* menjelaskan bahwa proses pemulihan pasien dapat dipercepat dan dioptimalkan melalui intervensi yang berfokus pada peningkatan kemampuan adaptasi fisik, psikologis, dan sosial. Teori ini menekankan bahwa pemulihan bukan hanya penyembuhan jaringan, tetapi juga melibatkan penguatan kontrol diri, kenyamanan, dan rasa aman pasien. *Recovery enhancement* dilakukan dengan cara mengurangi stres, meningkatkan relaksasi, mendukung mobilisasi dini, mengoptimalkan posisi tubuh, serta memberikan stimulasi terapeutik yang sesuai dengan kondisi pasien. Intervensi ini membantu menurunkan respon stres, meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi jaringan, serta memperbaiki persepsi nyeri.

d. Teori Self-efficacy

Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menyatakan bahwa tingkat *self-efficacy* memengaruhi cara individu berpikir, merasa, memotivasi diri, dan berperilaku. Individu dengan *self-efficacy* tinggi cenderung lebih percaya diri, aktif berpartisipasi dalam perawatan, mampu mengelola stres dan nyeri, serta lebih cepat beradaptasi dalam proses pemulihan. Sebaliknya, *self-efficacy* rendah dapat menyebabkan keraguan diri, kecemasan, dan ketergantungan pada orang lain. Dalam keperawatan, peningkatan *self-efficacy* dapat dilakukan melalui edukasi, dukungan verbal, pengalaman keberhasilan, dan pendampingan, sehingga membantu pasien meningkatkan kemandirian dan keberhasilan dalam proses penyembuhan.

e. Konsep Caring Theory

Caring Theory dikemukakan oleh Jean Watson, yang menekankan bahwa inti praktik keperawatan adalah caring sebagai hubungan humanistik dan transpersonal antara perawat dan pasien. Caring tidak hanya berfokus pada tindakan teknis, tetapi juga pada kehadiran penuh, empati, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Watson menjelaskan bahwa caring diwujudkan melalui *carative factors* (kemudian berkembang menjadi *caritas processes*), seperti membangun hubungan saling percaya, memberikan dukungan emosional, meningkatkan harapan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan. Hubungan caring ini dapat membantu menurunkan kecemasan, meningkatkan kenyamanan, dan mempercepat proses pemulihan.

f. Model Adaptasi Roy

Model Adaptasi Roy dikemukakan oleh Sister Callista Roy, yang memandang manusia sebagai sistem adaptif biopsikososial yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Individu merespons berbagai stimulus internal dan eksternal melalui mekanisme koping untuk mempertahankan keseimbangan dan integritas diri. Menurut Roy, respon adaptasi muncul dalam empat mode adaptasi, yaitu fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Respon adaptif yang efektif ditandai dengan kemampuan individu dalam mengelola stres, nyeri, dan perubahan kondisi kesehatan, sehingga mendukung proses pemulihan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan yang berfokus pada pemberian perlakuan (intervensi: Tarik nafas dalam, mobilisasi dini, pemberian posisi, foot massage) keperawatan pada beberapa ibu post partum dengan nyeri luka sectio caesarea. Desain studi kasus dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam dan komprehensif mengenai respons individu terhadap intervensi keperawatan yang diberikan dalam konteks klinik nyata. Subjek dalam studi kasus ini adalah ibu post partum dengan luka sectio caesarea yang mengalami nyeri pada area insisi. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, antara lain ibu post partum hari pertama hingga ketiga pasca sectio caesarea, kondisi umum stabil, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian asuhan keperawatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian keperawatan komprehensif yang meliputi data subjektif dan objektif. Data subjektif diperoleh melalui wawancara terkait intensitas nyeri, lokasi, karakteristik nyeri, serta faktor yang memperberat atau mengurangi nyeri. Data objektif meliputi tanda-tanda vital, kondisi luka operasi, kemampuan mobilisasi, serta ekspresi nonverbal yang menunjukkan respons nyeri. Intensitas nyeri diukur menggunakan skala nyeri numerik (Numeric Rating Scale/NRS) sebelum dan sesudah pemberian perlakuan.

Skala Nyeri Numerik (Numeric Rating Scale/NRS) merupakan alat ukur subjektif untuk menilai intensitas nyeri dengan menggunakan angka 0–10, di mana 0 menunjukkan tidak nyeri dan 10 menunjukkan nyeri paling berat. Pasien diminta memilih angka yang paling menggambarkan tingkat nyeri yang dirasakan. Skala ini mudah digunakan, cepat, dan efektif untuk mengevaluasi perubahan intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi keperawatan. NRS banyak digunakan pada pasien dewasa yang mampu berkomunikasi secara verbal, termasuk pada kondisi post operasi.[24]

Menyiapkan lembar observasi untuk mencatat semua hasil yang didapatkan sebelum dan setelah pemberian intervensi. Serta menggunakan dokumen-dokumen pendukung lain untuk mendapatkan informasi data terkait ibu post partum (data terapi pasien seperti: obat dan data laboratorium sebagai penunjang diagnosa keperawatan yang ditegakkan). Tak lupa melibatkan keluarga dan perawat yang merawat ibu post partum, dalam menambahkan sumber data pendukung lainnya agar data yang diperoleh lebih akurat.

Perlakuan yang diberikan berupa intervensi keperawatan nonfarmakologis yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan. Intervensi ini ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kepada pasien, yaitu meliputi teknik nafas dalam sebagai metode relaksasi, mobilisasi dini secara bertahap sesuai toleransi pasien, pengaturan posisi yang nyaman dan aman untuk mengurangi tekanan pada area luka, serta foot massage sebagai bentuk sentuhan terapeutik. Setiap intervensi dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional keperawatan yang telah dibuat dan disesuaikan dengan kondisi serta respon pasien.

Pelaksanaan perlakuan dilakukan dalam periode tertentu dengan frekuensi yang telah ditentukan. Selama intervensi berlangsung, perawat memberikan edukasi kepada pasien mengenai tujuan, manfaat, dan cara melakukan teknik yang diajarkan, sehingga pasien dapat berpartisipasi aktif dalam proses perawatan (memandirikan pasien). Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan disetiap setelah diberikan perlakuan (dengan menggunakan lembar observasi dan dituangkan dalam bentuk SOAP) untuk menilai perubahan intensitas nyeri, kemampuan mobilisasi, serta kenyamanan pasien setelah intervensi diberikan.

Analisis data pada studi kasus ini dilakukan secara deskriptif naratif dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk uraian perkembangan kondisi pasien yang menggambarkan efektivitas intervensi keperawatan dalam menurunkan nyeri luka sectio caesarea dan mendukung proses pemulihan ibu post partum.

D. Hasil Penelitian

Hasil studi kasus ini menggambarkan respons ibu post partum dengan nyeri luka sectio caesarea terhadap pemberian intervensi keperawatan nonfarmakologis yang dilaksanakan secara terstruktur. Pada tahap awal pengkajian, pasien melaporkan nyeri pada area luka operasi dengan intensitas sedang hingga berat, terutama saat bergerak, batuk, atau mengubah posisi. Nyeri dirasakan sebagai rasa perih dan tertarik pada area insisi, disertai keterbatasan mobilisasi dan ketergantungan pada bantuan perawat dalam aktivitas sehari-hari.

Setelah dilakukan pemberian perlakuan keperawatan berupa teknik nafas dalam, mobilisasi dini bertahap, pengaturan posisi yang nyaman, serta *foot massage* secara berkesinambungan, terjadi perubahan yang bermakna pada respons nyeri pasien. Intensitas nyeri yang diukur menggunakan skala nyeri numerik (*Numeric Rating Scale*) menunjukkan penurunan secara bertahap setelah intervensi diberikan. Pasien melaporkan rasa lebih rileks, berkurangnya ketegangan otot, dan peningkatan toleransi terhadap nyeri, khususnya setelah dilakukan teknik relaksasi dan *foot massage*.

Selain penurunan intensitas nyeri, hasil studi kasus juga menunjukkan peningkatan kemampuan mobilisasi pasien. Pasien mulai mampu melakukan perubahan posisi secara mandiri, duduk, dan berjalan secara bertahap dengan rasa nyeri yang lebih terkendali. Pengaturan posisi yang tepat membantu mengurangi tekanan pada area luka operasi, sehingga memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri pasien untuk bergerak.

Dari aspek fisiologis, tanda-tanda vital pasien berada dalam batas normal selama periode intervensi, serta tidak ditemukan tanda-tanda komplikasi pada luka operasi. Kondisi luka tampak bersih, kering, dan tidak menunjukkan tanda infeksi. Secara subjektif, pasien menyatakan merasa lebih nyaman, lebih percaya diri dalam merawat diri, serta lebih siap untuk melakukan aktivitas perawatan bayi, termasuk menyusui.

Hasil observasi juga menunjukkan adanya perubahan positif pada respon psikologis pasien. Pasien tampak lebih tenang, kooperatif, dan mampu mengungkapkan perasaannya terkait pengalaman nyeri pasca operasi. Edukasi yang diberikan selama intervensi meningkatkan pemahaman pasien mengenai pentingnya mobilisasi dini dan teknik relaksasi sebagai bagian dari proses pemulihan.

Secara keseluruhan, hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keperawatan praktis melalui intervensi nonfarmakologis efektif dalam menurunkan intensitas nyeri luka sectio caesarea, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung proses pemulihan ibu post partum. Temuan ini menegaskan pentingnya peran perawat dalam mengintegrasikan intervensi keperawatan berbasis bukti ke dalam praktik klinik sehari-hari.

E. Pembahasan

Nyeri luka sectio caesarea merupakan respon fisiologis dan psikologis akibat tindakan pembedahan yang melibatkan insisi jaringan kulit, otot, dan uterus. Nyeri ini muncul sebagai akibat aktivasi nosireseptor perifer yang dipicu oleh kerusakan jaringan, inflamasi, dan pelepasan mediator nyeri seperti prostaglandin dan

bradikinin. Menurut teori nyeri gate control yang dikemukakan oleh Melzack dan Wall, persepsi nyeri tidak hanya ditentukan oleh stimulus fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, dan mekanisme modulasi saraf pusat.[20] Hal ini menjadi dasar penting dalam penerapan intervensi keperawatan nonfarmakologis pada ibu post partum dengan luka sectio caesarea.

Hasil studi kasus menunjukkan adanya penurunan intensitas nyeri setelah diberikan intervensi keperawatan praktis berupa teknik nafas dalam, mobilisasi dini, pengaturan posisi, dan foot massage. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa intervensi nonfarmakologis dapat menstimulasi serabut saraf besar (A-beta) yang berperan dalam menutup "gerbang nyeri" di medula spinalis, sehingga impuls nyeri yang dihantarkan oleh serabut kecil (A-delta dan C) dapat dihambat.[20]

Teknik nafas dalam merupakan bentuk relaksasi yang bertujuan untuk menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis dan meningkatkan aktivitas parasimpatis. Menurut teori relaksasi Benson, pernapasan terkontrol mampu menurunkan ketegangan otot, frekuensi denyut jantung, serta konsumsi oksigen, sehingga memberikan efek menenangkan pada tubuh. Pada ibu post partum pasca sectio caesarea, teknik nafas dalam membantu mengurangi kecemasan dan ketegangan yang dapat memperberat persepsi nyeri. Penurunan nyeri yang dirasakan pasien dalam studi kasus ini mendukung teori bahwa relaksasi pernapasan efektif dalam menurunkan intensitas nyeri akut pasca operasi.[21]

Mobilisasi dini merupakan salah satu prinsip penting dalam perawatan post operasi. Menurut teori recovery enhancement, mobilisasi bertahap dapat meningkatkan sirkulasi darah, mencegah kekakuan otot, serta mempercepat proses penyembuhan jaringan. Pada ibu post partum dengan luka sectio caesarea, mobilisasi dini yang dilakukan secara aman dan terkontrol membantu mengurangi rasa kaku dan nyeri yang muncul akibat imobilisasi berkepanjangan. Pengaturan posisi yang tepat juga berperan dalam mengurangi tekanan pada area luka insisi, sehingga menurunkan stimulasi nosireseptor dan meningkatkan kenyamanan pasien.[16]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi dan pendampingan mobilisasi, pasien menjadi lebih percaya diri untuk bergerak dan mengalami penurunan nyeri saat melakukan aktivitas. Hal ini sejalan dengan konsep self-efficacy Bandura, dimana peningkatan keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri dapat memperbaiki respon adaptif terhadap nyeri dan proses pemulihan.[20]

Foot massage merupakan bentuk terapi sentuhan yang bekerja melalui stimulasi mekanoreseptor pada telapak kaki. Berdasarkan teori gate control, sentuhan ritmik dan tekanan ringan hingga sedang dapat menghambat transmisi

impuls nyeri ke otak. Selain itu, foot massage juga merangsang pelepasan endorfin yang berperan sebagai analgesik alami tubuh. Dalam studi kasus ini, pasien melaporkan perasaan lebih rileks dan nyaman setelah dilakukan foot massage, yang diikuti dengan penurunan intensitas nyeri.[12]

Temuan ini mendukung konsep caring theory Jean Watson, yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik, sentuhan, dan kehadiran perawat dalam meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pasien. Foot massage tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga berdampak positif pada aspek psikologis pasien, seperti menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa diperhatikan.[20]

Pendekatan keperawatan praktis yang diterapkan dalam studi kasus ini mencerminkan konsep asuhan keperawatan holistik, perawat memandang pasien sebagai individu yang utuh, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Penurunan nyeri, peningkatan mobilisasi, serta respon psikologis positif yang ditunjukkan pasien menunjukkan bahwa kombinasi intervensi keperawatan nonfarmakologis mampu mendukung proses pemulihan secara menyeluruh.

Selain itu, hasil studi kasus ini juga menegaskan peran perawat sebagai educator dan fasilitator dalam proses penyembuhan. Edukasi yang diberikan kepada pasien terkait teknik nafas dalam, mobilisasi, dan posisi yang nyaman meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam perawatan diri. Hal ini sesuai dengan teori adaptasi Roy, yang menyatakan bahwa individu akan menunjukkan respon adaptif apabila mendapatkan stimulus dan dukungan yang adekuat dari lingkungan.

F. Implikasi praktik keperawatan

Hasil studi kasus ini memberikan implikasi penting bagi praktik keperawatan maternitas, khususnya dalam asuhan keperawatan pada ibu post partum dengan nyeri luka sectio caesarea. Pendekatan keperawatan praktis yang diterapkan menunjukkan bahwa intervensi nonfarmakologis dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam pelayanan keperawatan rutin.

Pertama, perawat perlu menempatkan manajemen nyeri post sectio caesarea sebagai prioritas asuhan keperawatan. Pengkajian nyeri secara sistematis dan berkelanjutan menggunakan instrumen yang terstandar memungkinkan perawat untuk merencanakan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan respon individu pasien. Dengan demikian, nyeri tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi pasca operasi, tetapi sebagai masalah keperawatan yang memerlukan penanganan aktif.[23]

Kedua, penerapan intervensi keperawatan nonfarmakologis seperti teknik nafas dalam, mobilisasi dini bertahap, pengaturan posisi yang nyaman, dan *foot massage* perlu diperkuat dalam praktik klinik. Intervensi ini relatif mudah dilakukan,

aman, serta tidak memerlukan alat khusus, sehingga dapat diterapkan diberbagai tatanan pelayanan kesehatan. Perawat diharapkan mampu mengombinasikan intervensi nonfarmakologis dengan terapi farmakologis untuk mencapai pengelolaan nyeri yang optimal.[13][9]

Ketiga, peran perawat sebagai *educator* dan fasilitator menjadi semakin penting dalam mendukung pemulihan ibu post partum. Edukasi yang jelas dan berkelanjutan mengenai manfaat mobilisasi dini, teknik relaksasi, serta posisi yang aman dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya. Partisipasi aktif pasien dalam proses perawatan terbukti berkontribusi terhadap penurunan nyeri dan percepatan pemulihan.[10]

Keempat, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keperawatan holistik dan humanis. Intervensi seperti *foot massage* tidak hanya berdampak pada penurunan nyeri fisik, tetapi juga memberikan efek psikologis berupa rasa nyaman, aman, dan diperhatikan. Pendekatan ini memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien serta meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan keperawatan.

Kelima, temuan studi kasus ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan standar operasional prosedur (SOP) atau panduan praktik keperawatan dalam manajemen nyeri post sectio caesarea. Dengan adanya panduan yang berbasis bukti, diharapkan praktik keperawatan menjadi lebih seragam, sistematis, dan berkualitas.

Secara keseluruhan, implikasi praktik keperawatan dari studi kasus ini menegaskan bahwa pendekatan keperawatan praktis berbasis bukti mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan maternitas, mendukung pemulihan holistik ibu post partum, serta memperkuat peran profesional perawat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

G. Simpulan

Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan keperawatan praktis melalui penerapan intervensi nonfarmakologis berupa teknik nafas dalam, mobilisasi dini bertahap, pengaturan posisi yang tepat, dan *foot massage* efektif dalam menurunkan intensitas nyeri luka sectio caesarea pada ibu post partum. Intervensi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pengelolaan nyeri, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, kemampuan mobilisasi, serta respon psikologis ibu selama masa pemulihan.

Pendekatan keperawatan yang berbasis teori dan praktik ini menegaskan peran strategis perawat dalam memberikan asuhan keperawatan holistik dan berpusat pada pasien. Integrasi intervensi keperawatan nonfarmakologis ke dalam

praktik klinik sehari-hari dapat menjadi pelengkap terapi farmakologis dalam manajemen nyeri post operasi.

Dengan demikian, pendekatan keperawatan praktis yang diterapkan dalam studi kasus ini berpotensi menjadi model asuhan keperawatan yang aplikatif dan berbasis bukti dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan maternitas, khususnya pada ibu post partum dengan nyeri luka sectio caesarea.

Dapat disimpulkan bahwa intervensi keperawatan nonfarmakologis memiliki peran penting sebagai bagian dari manajemen nyeri post sectio caesarea. Pendekatan keperawatan praktis yang mudah diterapkan dan berbasis teori ini dapat dijadikan alternatif dan pelengkap terapi farmakologis dalam praktik klinik. Implementasi intervensi secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan maternitas serta mendukung pemulihan optimal ibu post partum.

H. Referensi

- M. S. Harrison et al., "Cesarean birth in the Global Network for Women's and Children's Health Research: trends in utilization, risk factors, and subgroups with high cesarean birth rates," *Reprod. Health*, vol. 17, no. 3, pp. 1–11, 2020, doi: 10.1186/s12978-020-01021-7.
- A. T. Habteyes, M. D. Mekuria, H. A. Negeri, R. T. Kassa, L. K. Deribe, and E. G. Sendo, "Prevalence and associated factors of caesarean section among mothers who gave birth across Eastern Africa countries: Systematic review and meta-analysis study," *Heliyon*, vol. 10, no. 12, p. e32511, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32511.
- A. Hidayatullah and N. Noviardi, "Tatalaksana Nyeri Paska Operasi Seksio Saesarea," *UMI Med. J.*, vol. 10, no. 1, pp. 36–46, 2025, doi: 10.33096/umj.v10i1.341.
- S. Hintari, A. Ika Fibriana, J. Ilmu Kesehatan Masyarakat, F. Ilmu Keolahragaan, and U. Negeri Semarang, "208 HIGEIA 7 (2) (2023) HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT Hipertensi pada Penduduk Usia Produktif (15-59 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Pageruyung Kabupaten Kendal," 2023, doi: 10.15294/higeia/v7i2/63472.
- C. M. Angolile, B. L. Max, J. Mushemba, and H. L. Mashauri, "Global increased cesarean section rates and public health implications: A call to action," *Heal. Sci. Reports*, vol. 6, no. 5, pp. 1–5, 2023, doi: 10.1002/hsr.1274.
- S. Thomaidi, A. Sarantaki, M. Tziritidou Chatzopoulou, E. Orovou, V. Jotautis, and D. Papoutsis, "The Rising Global Cesarean Section Rates and Their Impact on

Maternal and Child Health: A Scoping Review," *J. Clin. Med.*, vol. 14, no. 22, pp. 1–14, 2025, doi: 10.3390/jcm14228102.

- A. N. Belladiena et al., "Determining Factors in Choosing a Caesarean Section: The Role of Health Financing and Availability of Health Facilities in Indonesia," *Int. J. Heal. Sci.*, vol. 5, no. 3, pp. 141–146, 2025, doi: 10.55606/ijhs.v5i3.6081.
- M. Tri Chesariyanto, Z. Zubaidah, and F. Sufiani Ikasari, "Manajemen Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea Dalam Asuhan Keperawatan Maternitas: Studi Kasus," *JoIN J. Intan Nurs.*, vol. 3, no. 1, pp. 26–30, 2024, doi: 10.54004/join.v3i1.164.
- F. F. Farida and D. O. Handajanti, "Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Tingkat Nyeri Luka Pada Ibu Post Sectio Caesarea ERACS di RSI Darus Syifa Surabaya," *IJMT Indones. J. Midwifery Today*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2024, doi: 10.30587/ijmt.v4i1.8235.
- S. Yulianti, I. Maryati, F. Keperawatan, and U. Padjadjaran, "POST SECTIO CAESAREAN ATAS INDIKASI PLASENTA PREVIA MARGINALIS : STUDI KASUS DESKRIPTIF untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi . Pemantauan pasca sesar yang penting," vol. 6, no. 1, pp. 10–23, 2022.
- M. Dini, P. Ibu, P. Dengan, and S. Caesarea, "951-Article Text-3307-1-10-20230707," vol. 10, no. 1, pp. 44–52, 2023.
- Dian Mya Mariyana, Yuni Astuti, and Rusnaningish, "Pengaruh Foot And Hand Massage Therapy Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesarea," *An-Najat*, vol. 2, no. 4, pp. 114–123, 2024, doi: 10.59841/an-najat.v2i4.1739.
- L. Pratiwi, A. Dzakiah Rz, F. Fatimatuz Zahra, J. Maknun, N. Ramahwati, and S. Yuniandani, "Asuhan Keperawatan Penurunan Nyeri Pada Ibu Post Operasi Sectio Caesarea Dengan Penerapan Foot Massage Di Rumah Sakit Mitra Plumbon Tahun 2021," *J. Public Heal. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, 2023, doi: 10.30587/jphsr.v4i2.5612.
- B. Santoso, "Hubungan Mobilisasi Dini dengan Proses Penyembuhan Luka Pasien Post Operasi Ortopedi," *J. Ilm. Kesehat. Pertiwi*, vol. 7, no. 2, pp. 110–118, 2021.
- R. Assyifa, D. Novitasari, and R. L. Suryani, "Implementasi Komunikasi Terapeutik dalam Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Sectio Caesarea," *J. Peduli Masy.*, vol. 5, no. 3, pp. 803–810, 2023.
- S. R. Yani, "Analisis Asuhan Keperawatan pada Ibu Post Sectio Caesarea dengan Penerapan Terapi Guided Imagery Untuk Mengatasi Nyeri," *J. Kesehat. Ilm.*

Indones. (Indonesian Heal. Sci. Journal), vol. 8, no. 1, pp. 125–132, 2023, doi: 10.51933/health.v8i1.954.

- Y. Y. Saputra, "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Pemenuhan Nutrisi Dengan Proses Penyembuhan Luka Ibu Post Sectio Caesarea," *Dohara Publ. Open Acces J.*, vol. 1, no. 8, pp. 281–287, 2022, [Online]. Available: <http://dohara.or.id/index.php/isjnm%7C>
- P. Handayani and S. Hamidah, "Pengaruh Mobilisasi , Nutrisi , Hygiene Luka Terhadap Penyembuhan Luka Fase Poliferasi Post Sectio Caesarea *IJMT : Jurnal Kebidanan* | 77 Data dari Riset Kesehatan Dasar Republik Menurut penelitian Neneng Sumiati *IJMT : Jurnal Kebidanan* | 78," vol. 3, no. 2, pp. 77–87, 2024.
- Lili Farlikhatun and Retno Supardi, "Pengaruh Pendampingan Mobilisasi Dini Terhadap Nyeri Pada Pasien Sectio Caesarea Di RSUD Kabupaten Bekasi," *J. Keperawatan Muhammadiyah*, vol. 2, no. 9, pp. 23–28, 2024, [Online]. Available: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM>
- E. McEwen, Melaine; Willis, *Theoretical Basis for Nursing*. 2011. [Online]. Available: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1965514&tool=p mcentrez&rendertype=abstract>
- F. Munawaroh, R. Wulandari, and A. S. B. Ginting, "Efektivitas Teknik Relaksasi Benson Dalam Mengurangi Intensitas Nyeri Pada Wanita Pasca Operasi Caesar Di Rsu Nurhayati Garut Tahun 2025," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 543–552, 2025, doi: 10.31004/innovative.v5i3.18892.
- N. Novita, H. Sumastri, and M. N. Sari, "PENGARUH TEKNIK BENSON RELAXATION TERHADAP INTENSITAS NYERI PADA IBU POST SECTIO CAESAREA DI RSUD Dr. H. Relaksasi Benson merupakan pengembangan metode relaksasi pernapasan dengan melibatkan faktor keyakinan pasien yang dapat menciptakan suatu lingkungan i," *JPP (Jurnal Kesehat. Poltekkes Palembang)*, vol. 17, no. 1, pp. 37–43, 2022.
- Mona Santika and Siska Iskandar, "jurnal_umb,+Journal+manager,+3+JKMB+April+2021-Siska+17-22 (1)," *J. Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, vol. 9, no. April, pp. 17–22, 2021.
- N. S. Kasih and I. Hamdani, "Perbandingan Efektivitas Penilaian Skala Nyeri Berdasarkan Visual Analog Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS), Dan Numeric Rating Scale (NRS)," *J. Implementa Husada*, vol. 4, no. 4, pp. 272–282, 2023.

I. Glosarium

A

Adaptasi Roy

Kemampuan individu untuk merespons stimulus internal dan eksternal secara positif guna mempertahankan kesehatan dan integritas diri

Afterpains

Nyeri yang dirasakan setelah persalinan akibat kontraksi uterus untuk kembali ke ukuran normal

Ambang nyeri

Tingkat rangsangan paling ringan yang sudah dapat dirasakan seseorang sebagai nyeri.

Angiogenesis

Proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada.

Aplikatif

Sesuatu yang bersifat dapat diterapkan secara langsung dalam praktik atau pelaksanaan nyata.

B

Baby blues

Kondisi gangguan emosi sementara pada ibu setelah melahirkan yang ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, cemas, dan perubahan suasana hati.

Bonding attachment

Proses terbentuknya ikatan emosional antara orang tua, terutama ibu, dengan bayi sejak awal kelahiran.

C

Carative factors

Prinsip-prinsip dasar dalam teori keperawatan Jean Watson yang menekankan pemberian asuhan keperawatan secara humanistik dan penuh kepedulian.

Clean wound

Luka bersih yang tidak menunjukkan tanda infeksi dan biasanya terjadi pada prosedur bedah terkontrol.

D

Deep Breathing

Teknik pernapasan dalam yang dilakukan secara perlahan untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi nyeri atau stres

Dehisensi luka

Kondisi terbukanya kembali tepi luka yang telah dijahit akibat kegagalan proses penyembuhan.

Dekade

Jangka waktu selama sepuluh tahun

Depresi postpartum

gangguan suasana hati pada ibu setelah melahirkan yang ditandai dengan kesedihan mendalam, kehilangan minat, dan gangguan fungsi sehari-hari

E

Edema

Pembengkakan jaringan akibat penumpukan cairan berlebih di dalam tubuh.

Edukasi

Proses pemberian informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang.

Endometrium

Lapisan bagian dalam rahim yang menebal untuk menerima kehamilan dan luruh saat menstruasi.

Endorfin

Hormon yang berfungsi mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan perasaan nyaman atau bahagia

Ergonomis

Kondisi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan tubuh manusia agar aman dan efisien digunakan.

F

Farmakologis

Segala tindakan atau terapi yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan.

Fascia

Jaringan ikat yang membungkus, menyokong, dan memisahkan otot, organ, serta struktur tubuh lainnya.

Fibroblas

Sel jaringan ikat yang berperan dalam pembentukan kolagen dan proses penyembuhan luka.

Foot massage

Teknik pijat pada telapak dan kaki yang bertujuan meningkatkan relaksasi, melancarkan sirkulasi darah, dan mengurangi nyeri atau kelelahan

G

Gentle care

Pendekatan perawatan yang dilakukan dengan lembut, penuh empati, dan menghormati kenyamanan serta kebutuhan klien.

H

Hemostasis

Proses fisiologis untuk menghentikan perdarahan melalui pembekuan darah dan kontraksi pembuluh darah.

Holistik

Pendekatan yang memandang manusia secara menyeluruh mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

I

Inflamasi

Respons pertahanan tubuh terhadap cedera atau infeksi yang ditandai kemerahan, bengkak, panas, nyeri, dan gangguan fungsi.

Integral

Sesuatu yang menyatu, penting, dan tidak dapat dipisahkan dari suatu keseluruhan. Interdependensi.

Intervensi

Tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk memengaruhi atau memperbaiki kondisi seseorang.

Involusi

Proses kembalinya uterus setelah persalinan, ke ukuran dan kondisi normal.

K

Konstipasi

Kondisi sulit buang air besar dengan frekuensi jarang atau feses keras.

M

Maturasi

Proses perkembangan menuju kematangan struktur dan fungsi suatu sel, jaringan, atau organisme.

Mikroorganisme

Makhluk hidup berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop.

Miometrium

Lapisan otot polos pada dinding rahim yang berperan dalam kontraksi saat persalinan dan involusi uterus.

Mobilisasi dini

Upaya menggerakkan pasien sedini mungkin setelah sakit atau operasi untuk mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi.

Mobilitas

Kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas dan mandiri

Multidimensional

Melibatkan banyak dimensi atau aspek dalam satu kesatuan.

Muskulus rectus abdominis

Otot lurus pada dinding depan perut yang berperan dalam fleksi batang tubuh dan menopang organ abdomen.

N**Non farmakologis**

Terapi yang dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan

Nosireseptor perifer

Reseptor saraf di jaringan tubuh yang berfungsi mendeteksi rangsangan nyeri akibat kerusakan atau ancaman cedera

Numeric Rating Scale

Alat ukur nyeri berupa skala angka (biasanya 0–10) untuk menilai intensitas nyeri yang dirasakan pasien.

O**Obat analgesic**

Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri.

P**Peritoneum**

Selaput tipis yang melapisi rongga perut dan menutupi organ-organ di dalamnya.

Persepsi nyeri

Proses subjektif individu dalam merasakan dan menafsirkan rangsangan nyeri.

Preferensi

Pilihan seseorang terhadap sesuatu yang lebih disukai.

Prevalensi

Proporsi kasus suatu penyakit yang ada dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu.

Proliferasi

Proses pertumbuhan dan peningkatan jumlah sel melalui pembelahan sel.

Prostaglandin

Senyawa kimia dalam tubuh yang berperan dalam proses inflamasi, nyeri, kontraksi otot, dan pengaturan berbagai fungsi fisiologis.

Provocation

Faktor atau rangsangan yang memicu atau memperberat timbulnya suatu kondisi, terutama nyeri.

Psikologis

Segala hal yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, pikiran, dan emosi seseorang.

Q

Quality

Tingkat mutu atau kesempurnaan suatu benda, layanan, atau proses dalam memenuhi standar tertentu.

R

Recovery Enhancement

Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan proses pemulihan seseorang setelah sakit atau prosedur medis.

Region

Wilayah atau area tertentu, baik secara geografis maupun bagian tubuh.

Relaksasi *Benson*

Teknik relaksasi yang dikembangkan oleh Dr. Herbert Benson untuk menenangkan tubuh dan pikiran melalui pernapasan tenang, fokus, dan repetisi kata atau doa singkat.

S

Sectio caesarea

Tindakan persalinan melalui sayatan bedah pada perut dan rahim untuk mengeluarkan bayi.

Self-efficacy

Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas atau menghadapi situasi tertentu.

Severity

Tingkat keparahan atau intensitas suatu kondisi, gejala, atau penyakit.

Stimulasi nosireseptor

Rangsangan pada reseptor nyeri di tubuh yang memicu sensasi nyeri.

T

Time

Waktu atau periode terjadinya suatu peristiwa atau proses.

Tren

Arah atau pola perubahan suatu kejadian, data, atau perilaku dari waktu ke waktu.

U

Uterus

Organ reproduksi wanita tempat janin berkembang selama kehamilan

V

Vasodilatasi

Pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah ke jaringan tubuh.

CHAPTER 5

ASUHAN LANSIA DENGAN RISIKO JATUH: INTERVENSI PENCEGAHAN YANG MUDAH DILAKUKAN

Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Peningkatan usia harapan hidup menyebabkan jumlah lansia terus bertambah dan memunculkan fenomena *ageing population* di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada bidang kesehatan karena proses menua selalu disertai penurunan fungsi fisiologis, psikologis, dan sosial, sehingga lansia berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, baik kronis maupun akut (Rahayu Syanti Yuniar Dian, Usman Devianti Reni, 2024; Rohima et al., 2019).

Salah satu masalah fisik dan biologis yang paling sering dan serius pada lansia adalah jatuh. Kejadian ini dapat menyebabkan cedera seperti luka, fraktur, gangguan mobilitas, trauma kepala, bahkan kematian, serta berdampak pada penurunan kemandirian dan kualitas hidup lansia (Kurniawan et al., 2025).

Faktor risiko jatuh pada lansia meliputi usia lanjut, jenis kelamin perempuan, penyakit kronis, disabilitas fungsional, dan gangguan kognitif. Jatuh disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi gangguan hemodinamik, efek samping obat, serta penyakit neurologis atau muskuloskeletal. Faktor ekstrinsik berkaitan dengan lingkungan, seperti pencahayaan buruk dan lantai licin. Jatuh akibat faktor ekstrinsik dapat terjadi kapan saja, terutama pada lansia dengan gangguan perhatian ringan, sedangkan jatuh akibat faktor intrinsik lebih sering terjadi saat istirahat pada lansia dengan gangguan perhatian berat. Identifikasi faktor risiko penting untuk pencegahan, meskipun memprediksi kejadian jatuh tetap sulit (Anulus et al., 2024).

Jatuh pada lansia tidak saja berdampak secara fisik namun juga dapat berdampak secara psikologis yang memberikan pengalaman syok dan takut akan resiko jatuh kembali, mengurangi aktivitas, meningkatkan ketergantungan pada keluarga sehingga memerlukan pendekatan keperawatan yang komprehensif (Hasanuddin et al., 2022; Rahayu Syanti Yuniar Dian, Usman Devianti Reni, 2024; Suratmini et al., 2025). Oleh karena itu, praktik keperawatan gerontik dituntut mampu melakukan pengkajian risiko jatuh secara sistematis, menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat, merancang intervensi pencegahan yang realistis, dan melibatkan keluarga sebagai unit pendukung utama (Kurniawan et al., 2025).

Perawat berperan penting dalam pencegahan jatuh melalui asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan, meliputi pengkajian faktor risiko, penetapan diagnosis, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan pencegahan, serta evaluasi hasil. Intervensi pencegahan jatuh tidak selalu kompleks atau mahal, tetapi dapat dilakukan melalui tindakan sederhana, edukasi, dan modifikasi lingkungan yang melibatkan pasien dan keluarga.

B. Epidemiologi Jatuh pada lansia

1. Kejadian Jatuh pada lansia

Jatuh pada lansia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar 28–35% lansia berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setidaknya satu kali dalam setahun, dan angka ini meningkat menjadi 32–42% pada kelompok usia di atas 70 tahun (World Health Organization(WHO, 2007). Data tersebut menunjukkan bahwa kejadian jatuh bukanlah peristiwa yang jarang, melainkan masalah yang umum dan berulang pada populasi lanjut usia. Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyebutkan bahwa lebih dari satu dari empat lansia mengalami jatuh setiap tahun, dan jatuh menjadi penyebab utama cedera yang memerlukan perawatan medis pada kelompok usia ini(CDC, 2023)

Di Indonesia, meskipun data nasional spesifik mengenai kejadian jatuh masih terbatas, laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa masalah mobilitas, cedera, dan ketergantungan pada lansia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa jatuh berperan besar dalam meningkatnya angka morbiditas pada lansia. Kejadian jatuh sering menjadi awal terjadinya penurunan fungsi, berkurangnya kemandirian, serta meningkatnya kebutuhan perawatan jangka panjang. Faktor demografis memiliki pengaruh yang kuat terhadap kejadian jatuh, dengan usia sebagai determinan utama. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi risiko jatuh akibat penurunan fungsi fisiologis, seperti kekuatan otot, keseimbangan, dan refleks (WHO, 2007) Jenis kelamin juga berperan, di mana perempuan dilaporkan lebih sering mengalami jatuh dan fraktur, terutama karena kepadatan tulang yang lebih rendah dan risiko osteoporosis yang lebih tinggi (Laurence Z. Rubenstein, 2006). Selain itu, tempat tinggal turut memengaruhi risiko jatuh. Lansia yang tinggal di panti atau fasilitas perawatan jangka panjang memiliki risiko jatuh lebih tinggi dibandingkan lansia yang

tinggal di rumah, karena umumnya memiliki keterbatasan fisik dan penyakit penyerta yang lebih berat (Lord, S. R., Sherrington, C., 2021).

2. Prevalensi, lokasi kejadian jatuh, dan keadaan lansia yang sering mengalami jatuh

Prevalensi jatuh pada lansia menunjukkan pola yang konsisten di berbagai negara, yakni sekitar sepertiga lansia mengalami jatuh setiap tahun (WHO, 2007). Risiko jatuh berulang meningkat secara signifikan pada lansia yang memiliki riwayat jatuh sebelumnya, sehingga riwayat jatuh menjadi prediktor terkuat kejadian jatuh di masa mendatang (CDC, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya identifikasi dini pada lansia yang pernah mengalami jatuh.

Dari segi lokasi, sebagian besar kejadian jatuh terjadi di dalam rumah, terutama di kamar mandi, kamar tidur, dan dapur. Area-area tersebut sering memiliki risiko lingkungan seperti lantai licin, pencahayaan yang kurang, serta tidak adanya pegangan. Jatuh di luar rumah umumnya terjadi di tangga, halaman, atau permukaan jalan yang tidak rata (Lord et al., 2021). Aktivitas yang sering memicu jatuh meliputi berjalan, berpindah posisi dari duduk ke berdiri, serta menuju kamar mandi, khususnya pada malam hari.

Keadaan lansia yang sering mengalami jatuh umumnya ditandai dengan gangguan keseimbangan, kelemahan otot, penurunan penglihatan, serta adanya penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan gangguan neurologis (Rubenstein, 2006; Lord et al., 2021). Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti sedatif dan antihipertensi, juga meningkatkan risiko karena dapat menimbulkan pusing dan lemah. Kombinasi faktor individu dan lingkungan inilah yang menjadikan lansia sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kejadian jatuh.

3. Pemahaman terhadap epidemiologi

Jatuh meliputi data kejadian, faktor demografis, prevalensi, lokasi, dan keadaan lansia yang sering mengalami jatuh menjadi dasar penting dalam perencanaan intervensi pencegahan. Dengan mengenali pola kejadian secara sistematis, tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat melakukan deteksi dini, menentukan kelompok berisiko tinggi, serta merancang strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

C. Faktor Resiko Jatuh

Jatuh merupakan salah satu masalah kesehatan utama pada populasi lansia. World Health Organization (World Health Organization, 2021) mendefinisikan jatuh sebagai "peristiwa tidak disengaja yang menyebabkan seseorang berada di lantai, tanah, atau tingkat yang lebih rendah." Pada kelompok usia lanjut, kejadian jatuh bukan hanya menyebabkan cedera fisik, tetapi juga berdampak psikologis, sosial,

dan ekonomi yang signifikan. Lansia yang pernah jatuh cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri, rasa takut beraktivitas, hingga kehilangan kemandirian (World Health Organization, 2021)

Secara global, sekitar 28–35% lansia usia ≥ 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun, dan angka ini meningkat pada usia ≥ 70 tahun (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, kejadian jatuh pada lansia juga menjadi masalah yang sering ditemui di layanan kesehatan primer dan komunitas. Dampak jatuh dapat berupa luka ringan, fraktur, cedera kepala, hingga kematian, terutama bila terjadi pada lansia dengan penyakit kronis atau kondisi fisik yang lemah.

Jatuh pada lansia bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi (NICE, 2023). Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor intrinsik, faktor ekstrinsik (lingkungan), faktor perilaku, dan faktor terkait obat.

1. Faktor Intrinsik

Faktor intrinsik berasal dari kondisi fisik dan psikologis lansia itu sendiri. Perubahan fisiologis akibat proses penuaan berperan besar dalam meningkatkan risiko jatuh. Penurunan massa otot (sarkopenia), kekuatan otot, dan elastisitas sendi menyebabkan lansia mengalami kelemahan dan keterbatasan gerak (Centers for Disease Control and Prevention, 2023). Gangguan gaya berjalan dan keseimbangan merupakan prediktor kuat terjadinya jatuh.

Selain itu, gangguan penglihatan seperti katarak, presbiopia, dan degenerasi makula membuat lansia sulit mengenali rintangan di sekitarnya (World Health Organization, 2021). Perubahan sistem vestibular dan proprioseptif juga menyebabkan gangguan orientasi posisi tubuh.

Penyakit kronis seperti stroke, Parkinson, artritis, diabetes, dan osteoporosis turut meningkatkan risiko jatuh. Lansia dengan gangguan neurologis sering mengalami tremor, kaku otot, dan refleks yang melambat. Sementara itu, osteoporosis meningkatkan risiko fraktur bila jatuh terjadi (NICE, 2023).

Faktor kognitif dan psikologis juga berperan penting. Lansia dengan demensia, delirium, atau depresi cenderung mengalami gangguan perhatian dan penilaian risiko. Mereka mungkin tidak menyadari bahaya lingkungan atau lupa menggunakan alat bantu jalan. Riwayat jatuh sebelumnya merupakan indikator terkuat terjadinya jatuh berulang (Centers for Disease Control and Prevention, 2023).

2. Faktor Ekstrinsik (Lingkungan)

Faktor ekstrinsik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat lansia beraktivitas. (World Health Organization, 2021). Menyebutkan bahwa sebagian besar jatuh pada lansia terjadi di rumah. Lingkungan yang tidak aman seperti

pencahayaan yang kurang, lantai licin, karpet yang tidak terpasang kuat, kabel listrik yang melintang, serta kamar mandi tanpa pegangan merupakan penyebab umum jatuh.

Tangga tanpa handrail, perbedaan tinggi lantai, dan permukaan jalan yang tidak rata juga meningkatkan risiko jatuh. Lingkungan luar rumah, seperti trotoar yang rusak atau basah, turut berkontribusi terhadap kejadian jatuh pada lansia yang masih aktif di masyarakat.

Bagi perawat, penilaian lingkungan merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan lansia. Modifikasi sederhana seperti pemasangan lampu tambahan, pegangan di kamar mandi, dan pengaturan ulang perabot dapat menurunkan risiko jatuh secara signifikan.

D. Pengkajian Risiko Jatuh Pada Lansia

Pengkajian risiko jatuh pada lansia merupakan langkah awal dan paling penting dalam asuhan keperawatan gerontik. Jatuh pada lansia bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan (WHO, 2007). Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan.

Pengkajian bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi lansia yang berisiko jatuh.
2. Menentukan faktor-faktor penyebab risiko jatuh.
3. Menjadi dasar dalam penetapan diagnosa keperawatan.
4. Menyusun rencana intervensi pencegahan yang tepat.
5. Mencegah terjadinya cedera dan penurunan kemandirian lansia.

Potter dan Perry (2017) menegaskan bahwa pengkajian yang akurat memungkinkan perawat beralih dari pendekatan reaktif (setelah jatuh terjadi) menjadi preventif.

1. Komponen Pengkajian Risiko Jatuh

Pengkajian risiko jatuh pada lansia mencakup beberapa komponen utama:

a. Riwayat Kesehatan

Perawat menggali informasi mengenai:

- 1) Riwayat jatuh dalam 6–12 bulan terakhir
- 2) Penyakit kronis (hipertensi, diabetes, stroke, Parkinson, artritis)
- 3) Keluhan pusing, lemah, nyeri sendi, atau gangguan penglihatan
- 4) Riwayat rawat inap atau operasi

WHO (2007) menyatakan bahwa riwayat jatuh sebelumnya merupakan prediktor terkuat terjadinya jatuh berulang. Lansia yang pernah jatuh memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih besar untuk jatuh kembali.

b. Status Fisik dan Fungsional

Pengkajian fisik meliputi:

- 1) Kekuatan otot, terutama ekstremitas bawah
- 2) Keseimbangan saat berdiri
- 3) Gaya berjalan (kecepatan, kestabilan, panjang langkah)
- 4) Kemampuan berpindah posisi (duduk–berdiri, tempat tidur–kursi)
- 5) Tingkat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari (ADL)

Perubahan kecil seperti langkah pendek, sering berhenti saat berjalan, atau berpegangan pada benda di sekitar merupakan tanda awal peningkatan risiko jatuh (Nugroho, 2015).

c. Status Kognitif dan Psikologis

Aspek ini mencakup:

- 1) Orientasi dan daya ingat
- 2) Adanya kebingungan atau demensia
- 3) Rasa takut jatuh (*fear of falling*)
- 4) Kondisi emosional seperti cemas atau depresi

Gangguan kognitif membuat lansia sulit menilai bahaya, sedangkan rasa takut jatuh dapat membatasi aktivitas, menurunkan kekuatan otot, dan justru meningkatkan risiko jatuh (Potter & Perry, 2017).

d. Penggunaan Obat

Perawat menilai:

- 1) Jumlah dan jenis obat yang dikonsumsi
 - 2) Obat yang memengaruhi kesadaran dan keseimbangan (sedatif, antihipertensi, diuretik, antidepresan)
 - 3) Efek samping seperti pusing, lemas, dan hipotensi ortostatik
- Polifarmasi merupakan faktor risiko penting pada lansia karena meningkatkan gangguan keseimbangan dan kesadaran (Morse, 2009).

e. Lingkungan Tempat Tinggal

Pengkajian lingkungan meliputi:

- 1) Kondisi lantai (licin, tidak rata)
- 2) Pencahayaan
- 3) Tata letak perabot
- 4) Keberadaan pegangan di kamar mandi dan tangga
- 5) Keamanan alas kaki

Sebagian besar kejadian jatuh pada lansia terjadi di rumah, sehingga pengkajian lingkungan menjadi bagian yang sangat penting (WHO, 2007).

2. Teknik Pengkajian Risiko Jatuh

Pengkajian dilakukan melalui beberapa metode:

a) Wawancara Terarah

Untuk menggali riwayat jatuh, keluhan fisik, kebiasaan aktivitas, dan penggunaan obat.

b) Observasi Langsung

Mengamati cara berjalan, berdiri, duduk, dan berpindah posisi.

c) Pemeriksaan Fisik Sederhana

Menilai keseimbangan, kekuatan otot, dan respon postural.

d) Penggunaan Instrumen Penilaian Risiko Jatuh

Beberapa instrumen yang sering digunakan:

1) *Morse Fall Scale (MFS)*: menilai riwayat jatuh, diagnosis sekunder, alat bantu, terapi IV, gaya berjalan, dan status mental (Morse, 2009).

2) *Hendrich II Fall Risk Model*: menilai kebingungan, depresi, eliminasi, pusing, jenis kelamin, obat, dan kemampuan bangun dari kursi.

3) *Timed Up and Go Test (TUG)*:

Timed Up and Go (TUG) Test merupakan tes sederhana untuk menilai mobilitas, keseimbangan, dan risiko jatuh pada lansia. Tes ini mengukur waktu yang dibutuhkan lansia untuk bangkit dari kursi, berjalan sejauh 3 meter, berbalik, kembali, dan duduk Kembali

mengukur mobilitas dan keseimbangan. Waktu >12–14 detik menunjukkan risiko jatuh meningkat (Podsiadlo & Richardson, 1991).

E. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan keputusan klinis perawat mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan aktual maupun potensial yang menjadi dasar dalam penyusunan intervensi keperawatan. Di Indonesia, penetapan diagnosis keperawatan mengacu pada SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Pada lansia dengan risiko jatuh, diagnosis keperawatan disusun berdasarkan hasil pengkajian yang mencakup kondisi fisik, psikologis, lingkungan, riwayat jatuh, kemampuan mobilitas, serta dukungan keluarga. SDKI mengelompokkan diagnosis keperawatan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Diagnosis aktual
2. Diagnosis risiko
3. Diagnosis promosi kesehatan

Dalam konteks lansia dengan risiko jatuh, diagnosis yang paling dominan adalah diagnosis risiko, meskipun dapat pula muncul diagnosis aktual dan promosi kesehatan. Salah satu diagnosis utama yang digunakan adalah Risiko Jatuh (D.0143)(Tim Pokja SDKI DPP PPN, 2016).

1. Pengertian

Beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh.

2. Faktor resiko

- a. Usia $\geq$ 65 tahun (pada usia dewasa) atau $\leq$ 2 tahun (pada anak).
- b. Riwayat jatuh
- c. Anggota gerak bawah prostesis(bantuan)
- d. Penggunaan alat bantu berjalan
- e. Penurunan tingkat kesadaran
- f. Perubahan fungsi kognitif
- g. Lingkungan tidak aman (misalnya licin, gelap, lingkungan asing).
- h. Kondisi pasca operasi
- i. Hipotensi ortostatik
- j. Perubahan kadar glukosa darah
- k. Anemia
- l. Kekuatan otot menurun
- m. Gangguan pendengaran
- n. Gangguan keseimbangan
- o. Gangguan penglihatan (misalnya glaukoma, katarak, ablasio retina, neuritis optikus).
- p. Neuropati
- q. Efek agen farmakologis (misalnya sedasi, alkohol dan anastesi umum).

F. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada lansia dengan diagnosis Risiko Jatuh disusun berdasarkan SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) dengan tujuan utama mencegah terjadinya jatuh dan mempertahankan keselamatan klien. Dalam SIKI, intervensi dirancang secara komprehensif dan sistematis, meliputi aspek observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Pendekatan ini menempatkan perawat sebagai koordinator utama dalam menjaga keselamatan lansia, sekaligus melibatkan klien dan keluarga secara aktif dalam upaya pencegahan jatuh.

Tabel 5.1 Intervensi Keperawatan

Diagnosis	SLKI	SIKI
Resiko Jatuh	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan selama ... maka Luaran : Tingkat jatuh (L.14138) Ekspektasi menurun Kriteria Hasil 1. Jatuh dari tempat tidur menurun 2. Jatuh saat berdiri menurun 3. Jatuh saat berjalan menurun 4. Jatuh saat berpindah menurun 5. Jatuh saat naik tangga menurun 6. Jatuh dsst dikamar mandi menurun 7. Jatuh saat membungkuk menurun	Intervensi Utama 1. Pencegahan Jatuh (I.14540). Tindakan Observasi : - Identifikasi factor resiko jatuh (mis . usia > 65 tahun, penurunan Tingkat kesadaran, deficit kognitif, hipotensi otostatif, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati). - Identifikasi resiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi - Identifikasi factor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh (mis. Lantai licin. Penerangan kurang). - Hitung resiko jatuh menggunakan skala (mis. Fall morse, Humpty Dumpty scale(, jika perlu - Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Terapeutik - Orientasi ruangan pada pasien dan keluarga. - Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam keadaan terkunci. - Pasang handrall tempat tidur. - Alur tempat tidur mekanis pada posisi terendah - Tempatkan pasien beresiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari nurse station - Gunakan alat bantu berjalan (mis. Kursi roda, <i>walker</i>). - Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien. Edukasi - Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah

		- Anjurkan untuk menggunakan alas kaki yang tidak licin. - Anjurkan untuk berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. - Anjurkan untuk melebarkan jarak kedua kaki untuk meingkatkan keseimbangan saat berdiri. - Ajarkan untuk menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. 2. Manajemen Keselamatan lingkungan (I.14513) Tindakan : Observasi : - Identifikasi kebutuhan keselamatan (kondisi fisik, fungsi kognitif dan Riwayat perilaku. - Monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Terapeutik - Hilangkan bahaya keselamatan lingkungan (misalnya fisik, biologi dan kimia). - Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan resiko. - Sediakan alat bantu lingkungan (misalnya <i>commode chair</i> dan pegangan tangan). - Gunakan pelindung (misalnya pengakangan fisik, rel samping, pintu kunci, pagar). - Hubungi pihak berwenang sesuai masalah komunitas (misalnya Puskesmas, polisi dan damkar). - Lakukan program skrining bahaya lingkungan (misalnya timbal). Edukasi - Ajarkan individu, keluarga dan kelompok resiko tinggi bahaya lingkungan. Intervensi pendukung 1. Dukungan Ambulasi (I.05173) Oberservasi
--	--	--

		- Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. - Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi. - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik - Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (misalnya pagar tempat tidur). - Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu. - Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi - Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. - Anjurkan untuk melakukan prosedur ambulasi dini. - Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (misalnya duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi). 2. Dukungan Mobilisasi Observasi - Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. - Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan ambulasi. Terapeutik - Fasilitasi aktivitas ambulasi (misalnya Tongkat, kruk). - Fasilitasi mobilisasi fisik, jika perlu. - Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Edukasi
--	--	---

		- Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. - Anjurkan untuk melakukan prosedur ambulasi dini. - Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (misalnya berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai dengan toleransi. 3. Pemasangan alat pengaman. Observasi - Identifikasi kebutuhan keselamatan pasien (berdasarkan Tingkat fungsi fisik dan kognitif serta Riwayat perilaku sebelumnya). Terapeutik - Pasang alat pengaman (misalnya pengekangan, pagar tempat tidur, pintu dan kunci). - Dampingi selama kegiatan diluar ruang rawat jika perlu. - Berikan tempat tidur yang rendah dan alat-alat bantuan (misalnya tangga tenat tidur, alat penyangga) jika perlu - Berikan perabot dalam ruangan yang tidak mudah jatuh. - Respon setiap panggilan dengan segera. . Edukasi - Anjurkan menjauhkan barang yang membahayakan (misalnya : karpet, furniture).
--	--	---

(Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018)

G. Simpulan

Peningkatan jumlah lansia akibat meningkatnya usia harapan hidup menjadikan kejadian jatuh sebagai masalah kesehatan masyarakat yang semakin penting, termasuk di Indonesia. Jatuh pada lansia tidak hanya menimbulkan dampak fisik seperti luka, fraktur, gangguan mobilitas, trauma kepala hingga kematian, tetapi juga berdampak psikologis (syok, takut jatuh kembali), sosial, dan pada akhirnya menurunkan kemandirian serta kualitas hidup.

Secara epidemiologis, sekitar sepertiga lansia usia ≥ 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun dan risikonya meningkat pada usia lebih tua. Kejadian jatuh banyak terjadi di rumah (kamar mandi, kamar tidur, dapur) akibat kombinasi faktor individu dan faktor lingkungan. Riwayat jatuh sebelumnya menjadi prediktor terkuat untuk jatuh berulang, sehingga deteksi dini pada kelompok berisiko tinggi sangat krusial.

Risiko jatuh bersifat multifaktorial, melibatkan faktor intrinsik (penurunan kekuatan otot/sarkopenia, gangguan keseimbangan dan gaya berjalan, gangguan penglihatan, penyakit kronis seperti stroke/Parkinson/diabetes, gangguan kognitif-psikologis), faktor ekstrinsik (pencahayaan buruk, lantai licin, karpet/kabel, tangga tanpa pegangan), serta faktor obat (polifarmasi, sedatif, antihipertensi, diuretik, antidepresan) yang dapat menyebabkan pusing, lemas, atau hipotensi ortostatik.

Karena itu, praktik keperawatan gerontik perlu melakukan pengkajian risiko jatuh secara komprehensif dan berkesinambungan melalui riwayat jatuh, status fisik-fungsional, status kognitif-psikologis, penggunaan obat, serta evaluasi lingkungan tempat tinggal, dibantu instrumen seperti Morse Fall Scale, Hendrich II, dan TUG. Hasil pengkajian menjadi dasar penetapan diagnosis keperawatan menurut SDKI, terutama Risiko Jatuh (D.0143), serta penyusunan luaran dan intervensi sesuai SLKI-SIKI.

Intervensi utama berfokus pada pencegahan jatuh dan manajemen keselamatan lingkungan, mencakup observasi faktor risiko, orientasi dan pengamanan area perawatan (kunci roda, posisi tempat tidur rendah, handrail, bel pemanggil), penggunaan alat bantu jalan, edukasi perilaku aman (alas kaki tidak licin, minta bantuan saat berpindah, strategi menjaga keseimbangan), dukungan ambulasi/mobilisasi, serta keterlibatan aktif keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan jatuh tidak selalu membutuhkan tindakan mahal, namun dapat efektif melalui langkah sederhana, edukasi, modifikasi lingkungan, dan evaluasi berkala untuk menurunkan angka jatuh dan mempertahankan keselamatan serta kemandirian lansia.

H. Referensi

Anulus, A., I Gede Ari Permana Putra, M. W. D., Jiwintarum, Y., Widiyanto, A., & Joko

Tri Atmojo. (2024). FAKTOR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK TERKAIT RISIKO JATUH PADA LANSIA: LITERATUR REVIEW. *Jurnal Keperawatan Indonesia Timur*, 77–89. <https://doi.org/10.32695/jkit.v4i2.615>

CDC. (2023). *Important Facts about Falls*.

Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *STEADI: Older adult fall prevention*. <https://www.cdc.gov/steady/>

Hasanuddin, I., AL, J. P., S, S., Rodin, M. A., Laela, N., Nurbaya, S., & Suparta, S. (2022). Edukasi Tentang Pemanfaatan Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Guna Pencegahan Stunting di Desa Cenrana Kec Panca Lautang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(8), 2458–2466. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i8.6418>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Profil Kesehatan Lansia di Indonesia*.

Kurniawan, D., Sahar, J., Rekawati, E., Ayu, R., Sartika, D., Keperawatan, P. D., Keperawatan, F. I., & Indonesia, U. (2025). *INTERVENSI PENCEGAHAN JATUH PADA LANSIA BERBASIS KEPERAWATAN KELUARGA : TINJAUAN SISTEMATIS*. 9, 2539–2545.

Laurence Z. Rubenstein. (2006). *Falls in older people: Epidemiology, risk factors and strategies for prevention*. *Age and Ageing*. 35(2 september 2006). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ageing/afl084>

Lord, S. R., Sherrington, C., & N. (2021). *Falls in Older People: Risk Factors, Strategies for Prevention and Implications for Practice*. (3rd ed). ambridge University Press.

NICE. (2023). *Falls in older people: Assessment and prevention*. National Institute for Health and Care Excellence.

Rahayu Syanti Yuniar Dian, Usman Devianti Reni, P. P. P. D. (2024). *Pencegahan penyakit Mular pada nelayan lansia dan keluarga melalui media booklet di desa Ulu Sawa Kecamatan Sawa kab Konawe Utara*. 2677–2686.

Rohima, V., Rusdi, I., Karota, E., Keperawatan, F., & Utara, U. S. (2019). Faktor Resiko Jatuh pada Lansia di Unit Pelayanan Primer Puskesmas Medan Johor. *Persatuan Perawat Nasional Indonesian*, 4(2), 109–114.

Suratmini, D., Diorarta, R., Samaria, D., Tobing, L., Ayu, S., Adyani, M., Wahyudi, C. T., Nur, S., Millah, Z. M., Nasution, N. A., Resti, A., Putri, A., Cahyani, C. O., Putri, W.

K., Kesehatan, F. I., Kronis, P., & Progresif, R. O. (2025). Pemberdayaan lansia dengan penyakit kronis dalam mengelola kecemasan melalui relaksasi Otot Progresif di Posbindu Dahlia Senja Kelurahan Liom. *Jurna; Kreativitas Pengabdian Masyarakat (PKM)*, 8(11), 5565–5580.

Tim Pokja SDKI DPP PPN. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)* (DPP Persatuan Perawat Nasional Indones (ed.); Edisi 1).

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standart Intervensi Keperawatan Indonesia* (1 (ed.)). Dewan Pengurus Pusat PPNI.

WHO. (2007). *WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age*. World Health Organization.

World Health Organization (2021). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls?utm_source

I. Glosarium

Ageing Population

Fenomena meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia dalam suatu populasi akibat peningkatan usia harapan hidup.

ADL (Activities of Daily Living)

Aktivitas dasar sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, berpindah, dan toileting.

Ambulasi

Kemampuan seseorang untuk bergerak atau berjalan secara mandiri maupun dengan bantuan.

Demensia

Gangguan kognitif progresif yang memengaruhi daya ingat, berpikir, orientasi, dan kemampuan mengambil keputusan.

Diagnosis Keperawatan

Keputusan klinis perawat tentang respons individu terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial sebagai dasar intervensi keperawatan.

Ekstrinsik

Faktor yang berasal dari luar individu, terutama lingkungan fisik, yang dapat meningkatkan risiko jatuh.

Fear of Falling

Rasa takut berlebihan akan jatuh yang dapat membatasi aktivitas dan menurunkan kemandirian lansia.

Gerontik

Bidang keperawatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan lansia.

Hipotensi Ortostatik

Penurunan tekanan darah saat perubahan posisi (misalnya dari duduk ke berdiri) yang dapat menyebabkan pusing dan jatuh.

Instrinsik

Faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kondisi fisik, penyakit, atau gangguan kognitif.

Jatuh

Peristiwa tidak disengaja yang menyebabkan seseorang berada di lantai, tanah, atau tingkat yang lebih rendah.

Morse Fall Scale (MFS)

Instrumen penilaian risiko jatuh yang menilai riwayat jatuh, diagnosis sekunder, alat bantu, terapi IV, gaya berjalan, dan status mental.

Morbiditas

Tingkat atau angka kejadian penyakit dalam suatu populasi.

Polifarmasi

Penggunaan lebih dari satu jenis obat secara bersamaan, umum pada lansia dan berisiko menimbulkan efek samping.

Pengkajian

Proses sistematis untuk mengumpulkan data tentang kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan klien.

Risiko Jatuh (D.0143)

Diagnosis keperawatan dalam SDKI yang menggambarkan kerentanan individu mengalami kerusakan fisik akibat jatuh.

SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia)

Standar nasional diagnosis keperawatan yang disusun oleh PPNI.

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia)

Panduan nasional intervensi keperawatan berdasarkan diagnosis yang ditetapkan.

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia)

Standar hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan.

Sarkopenia

Penurunan massa dan kekuatan otot akibat proses penuaan.

Timed Up and Go (TUG) Test

Tes sederhana untuk menilai mobilitas dan keseimbangan dengan mengukur waktu bangun dari kursi, berjalan 3 meter, berbalik, kembali, dan duduk.

CHAPTER 6

PASIENT CEMAS MENJELANG TINDAKAN MEDIS: KOMUNIKASI TERAPEUTIK DASAR

Erwin Silitonga, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Kecemasan atau ansietas merupakan suatu kondisi berupa kekhawatiran yang bersifat menyeluruh dan tidak terarah secara spesifik, yang berkaitan dengan perasaan ketidakpastian serta ketidakberdayaan. Kondisi emosional ini tidak memiliki objek yang ancaman yang jelas dan dialami secara subjektif oleh individu serta diekspresikan secara interpersonal. Perbedaan antara kecemasan dan rasa takut adalah bahwa kecemasan timbul dari evaluasi kognitif terhadap keberadaan ancaman. Kecemasan adalah reaksi emosional terhadap evaluasi mental pada bahaya. Kemampuan untuk mengalami kecemasan memiliki peran adaptif dalam mempertahankan kehidupan, namun apabila tingkatnya berlebihan, kondisi ini dapat mengganggu kehidupan. (Stuart, Gail W. 2006:144).

Menurut Gail Stuard Wiscarz Sandra J Sundeen tahun (2006) menjelaskan bahwa dalam kajian keluarga, kecemasan merupakan fenomena yang umum ditemukan. Ansietas dapat dialami oleh siapa pun sebagai respon terhadap stresor yang dihadapi, termasuk ketika terdapat anggota keluarga yang sakit, sehingga memicu kekhawatiran pada anggota keluarga lainnya. Studi epidemiologis dan penelitian keluarga menunjukkan bahwa kecemasan hampir selalu muncul dalam setiap keluarga dengan variasi bentuk serta karakteristik yang berbeda yaitu, Stres dan Trauma: Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kehilangan, atau trauma masa lalu yang belum terselesaikan sangat memicu kecemasan. Biologis: Ketidakseimbangan neurotransmitter (zat kimia otak), perubahan hormon (estrogen, kortisol), genetik, dan masalah pada bagian otak seperti amigdala dan hipokampus. Lingkungan dan Sosial: Konflik hubungan, tekanan sosial, kurangnya dukungan, atau pengalaman traumatis seperti kekerasan. Gaya Hidup: Kurang tidur, konsumsi kafein berlebihan, alkohol, atau obat-obatan tertentu bisa memperburuk kecemasan. Kondisi Medis: Penyakit kronis atau masalah seperti tiroid dapat memicu gejala kecemasan (Videbac, 2008).

B. Kecemasan

Kecemasan muncul sebagai respon terhadap penilaian individu terhadap ancaman, termasuk ancaman yang dirasakan terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan diri. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tindakan medis sering dipersepsikan pasien sebagai situasi yang mengancam karena berkaitan dengan rasa nyeri, risiko komplikasi, serta ketidakpastian hasil. Menurut Keliat bahwa kecemasan pada pasien dapat dipicu oleh stresor internal dan eksternal, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur medis, pengalaman buruk sebelumnya, serta ketakutan terhadap perubahan kondisi kesehatan. Kecemasan ini tidak hanya dialami oleh pasien, tetapi juga dapat dirasakan oleh keluarga pasien. Kecemasan yang dialami pasien menjelang tindakan medis dapat memengaruhi respon fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis, peningkatan tekanan darah, denyut nadi, serta otot tegang adalah tanda-tanda kecemasan. Secara psikologis, kecemasan dapat menurunkan kemampuan konsentrasi, menghambat penerimaan informasi, serta memengaruhi kemampuan pasien dalam mengambil keputusan terkait perawatan (Keliat, 2015).

Tingkat kecemasan bervariasi dan kecemasan dapat mengganggu kemampuan berpikir dan kerjasama pasien selama tindakan medis. Menurut Stuart (2007, 2016), tingkat kecemasan terbagi menjadi empat kategori: ringan, sedang, berat, dan panik, yang masing-masing memiliki karakteristik respons perilaku, kognitif, dan afektif berbeda, dari waspada (ringan) hingga hilangnya kendali (panik), serta dapat diatasi dengan strategi adaptif atau maladaptif. Tingkat Kecemasan Menurut Stuart:

1. Kecemasan Ringan:

Karakteristik: Ketegangan ringan, meningkatkan kewaspadaan, memperluas lapang persepsi, memotivasi belajar dan kreativitas, serta dapat membantu pemecahan masalah.

Respons: Waspada, sedikit gelisah, bisa berfokus pada hal penting.

2. Kecemasan Sedang:

Karakteristik: Mempersempit lapang persepsi, fokus pada hal penting tapi bisa diarahkan, kurang perhatian selektif.

Respons: Gelisah, jantung berdebar, otot tegang, bicara cepat, sulit konsentrasi.

3. Kecemasan Berat:

Karakteristik: Sulit fokus, persepsi sangat menyempit, membutuhkan bantuan untuk mengarahkan perhatian, merasa terancam.

Respons: Perilaku kompulsif, ketakutan meningkat, kesulitan berpikir jernih, menarik diri.

4. Panik:

Karakteristik: Kehilangan kendali, persepsi sangat terbatas, merasa akan terjadi sesuatu yang buruk, tidak mampu belajar atau menyelesaikan masalah.

Respons: Detak jantung sangat cepat, gemetar, keringat dingin, kesulitan bernapas, merasa seperti akan mati atau gila.

Aspek Respon Kecemasan Menurut Stuart:

1. **Perilaku:** Gelisah, tremor, bicara cepat, menarik diri, menghindari masalah.
2. **Kognitif:** Kehilangan fokus, mudah lupa, bingung, mimpi buruk, takut kehilangan kendali.
3. **Afektif:** Tegang, tidak sabar, gugup, ketakutan, rasa bersalah, malu.

Respon Adaptif vs Maladaptif:

1. **Adaptif:** Mengatasi kecemasan dengan positif (berdoa, bicara, relaksasi).
2. **Maladaptif:** Menggunakan strategi merusak (alkohol, penyalahgunaan obat, perilaku agresif).

C. Kecemasan Menjelang Tindakan Medis

Prosedur medis, yang meliputi kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, merupakan komponen penting dari perawatan kesehatan. Perawatan ini dilakukan sesuai dengan indikasi medis tertentu dengan tujuan membantu pasien mencapai kesehatan terbaiknya. Namun, bagi pasien, tindakan medis sering kali dipersepsikan sebagai situasi yang menimbulkan ancaman, baik secara fisik maupun psikologis. Smeltzer dan Bare menyatakan bahwa prosedur medis, terutama yang bersifat invasif, dapat menjadi stress terutama bagi pasien karena melibatkan rasa nyeri, perubahan fungsi tubuh, serta ketidakpastian terhadap hasil tindakan. Kondisi tersebut dapat memicu respons emosional berupa kecemasan, ketegangan, dan ketakutan, khususnya apabila pasien tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum tindakan dilakukan (Smeltzer & Bare, 2010). Respons pasien terhadap tindakan medis sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap ancaman dan kemampuan koping yang dimiliki. Pasien yang memiliki pemahaman terbatas mengenai prosedur yang akan dijalani cenderung menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang mendapatkan penjelasan secara jelas dan sistematis (Potter & Perry, 2010).

Ketika operasi medis dilakukan tanpa persiapan psikologis yang memadai, kondisi fisiologis pasien dapat terganggu, termasuk peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan otot yang tegang (Rahima, 2022). Oleh karenanya, pendekatan holistik dalam tindakan medis sangat diperlukan, yaitu dengan memperhatikan tidak hanya aspek biologis, tetapi juga aspek psikologis dan emosional pasien. Dengan memahami karakteristik dan dampak psikologis dari tindakan medis, tenaga

kesehatan diharapkan mampu memberikan asuhan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menjadi dasar penting dalam penerapan komunikasi terapeutik sebagai upaya untuk menurunkan kecemasan pasien menjelang tindakan medis (Winarni et al., 2025). Salah satu metode yang efektif untuk mengurangi kekhawatiran pasien sebelum perawatan medis adalah dengan memahami dampak psikologis dari operasi tersebut, kemudian menggunakan komunikasi terapeutik untuk memberikan pengetahuan serta dukungan emosional, sehingga proses pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih lancar (Winarni et al., 2025; Lazdia et al., 2010-2022).

Berbagai kondisi medis serius sering kali membutuhkan tindakan medis segera yang secara alami menimbulkan kecemasan tinggi pada pasien, baik karena rasa takut akan prosedur itu sendiri, nyeri, maupun ketakutan akan hasil diagnosis. Berikut adalah beberapa kondisi medis dan tindakan medis yang umum mengakibatkan kecemasan:

1. Kondisi Jantung dan Kardiovaskular

Serangan Jantung / Sindrom Koroner Akut: Membutuhkan tindakan *angiografi* (kateterisasi jantung) atau pemasangan *stent* (ring) segera. Aritmia (Detak Jantung Tidak Teratur): Membutuhkan tindakan *kardioversi* (kejut jantung) atau pemasangan alat pacu jantung. Kecemasan Terkait: Pasien sering mengalami kecemasan ekstrem karena ketakutan akan kematian mendadak.

2. Penyakit Pernapasan Kronis

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) atau Asma Berat: Sesak napas yang ekstrem (*dyspnea*) menimbulkan kecemasan tinggi karena perasaan tercekik. Tindakan Medis: Penggunaan ventilator, pemasangan selang dada (*chest tube*), atau *bronkoskopi*.

3. Penyakit Metabolik dan Neurologis

Hipoglikemia (Gula Darah Rendah) atau Diabetes: Perubahan kimia otak akibat gula darah rendah bisa memicu serangan panik. Epilepsi atau Cedera Otak: Gangguan saraf ini bisa memicu gejala kecemasan kronis. Masalah Tiroid (*Hipertiroidisme*): Produksi hormon berlebih memicu palpitasi dan kecemasan.

4. Kanker dan Penyakit Kronis

Prosedur Diagnosis Kanker: Biopsi, pemindaian *MRI/CT Scan*, dan tindakan invasif lainnya sering memicu *Tomophobia* (ketakutan terhadap prosedur medis). Penyakit Kronis: Penyakit seperti Lupus atau *Multiple Sclerosis*, yang memerlukan pengobatan jangka panjang.

5. Prosedur Medis yang Memicu Kecemasan (Procedural Anxiety)

Pembedahan (Bedah Besar atau Kecil): Rasa takut akan anestesi, nyeri pasca operasi, atau hasil operasi (*Tomophobia*). Tindakan Invasif: Penyuntikan,

pengambilan sampel darah, endoskopi, atau hemodialisis (cuci darah). Dampak Kecemasan pada Tindakan Medis: Kecemasan pre-operasi dapat memicu pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin, yang meningkatkan detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Hal ini dapat mempersulit tindakan medis dan menghambat proses pemulihan (Mitchell, 2010).

Penanganan:

Jika kecemasan tidak dapat diatasi, dokter mungkin melibatkan psikiater untuk memberikan penanganan seperti terapi kognitif perilaku atau obat-obatan anti-cemas untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum tindakan medis (Baldwin et al., 2014).

D. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan proses interaksi yang terencana dan bertujuan antara tenaga kesehatan dan pasien untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, termasuk kecemasan. Komunikasi ini bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada empati, kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Menurut Keliat komunikasi terapeutik adalah alat utama dalam praktik keperawatan untuk membantu pasien mengekspresikan perasaan, memahami situasi yang dihadapi, serta meningkatkan kemampuan coping. Dalam konteks pasien yang cemas menjelang tindakan medis, komunikasi terapeutik berperan penting dalam menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan rasa aman (Keliat, 2015).

Komunikasi terapeutik merupakan komponen esensial dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam menghadapi pasien yang mengalami kecemasan menjelang tindakan medis. Penerapan komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga berkontribusi pada hasil tindakan medis yang lebih optimal. Penerapan komunikasi terapeutik dapat dilakukan melalui beberapa teknik, seperti mendengarkan secara aktif, memberikan informasi yang jelas dan jujur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menunjukkan sikap empati. Penjelasan mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, manfaat, serta kemungkinan risiko perlu disampaikan secara bertahap dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian yang menjadi salah satu sumber utama kecemasan. Selain itu, sikap non verbal tenaga kesehatan, seperti kontak mata, ekspresi wajah yang tenang, dan sentuhan terapeutik yang tepat, juga berperan dalam menciptakan hubungan yang mendukung. Pasien yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih kooperatif dan mampu mengelola kecemasannya dengan lebih baik (Potter & Perry, 2010).

Dalam konteks pratindakan medis, komunikasi terapeutik berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kecemasan melalui pemberian informasi yang adekuat dan realistis. Potter dan Perry menekankan bahwa penjelasan prosedur yang jelas, penggunaan bahasa yang sederhana, serta pemberian ruang bagi pasien untuk mengemukakan pertanyaan dapat mengurangi tingkat ketakutan serta meningkatkan persepsi pasien terhadap kendali atas kondisi yang sedang dihadapi. Lebih lanjut, sikap empati dan kehadiran perawat secara emosional merupakan bagian penting dari komunikasi terapeutik. Pasien yang merasa dipahami dan diterima cenderung menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah serta mampu bekerjasama dengan tenaga kesehatan selama proses tindakan medis. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik tidak hanya berperan dalam aspek psikologis, tetapi juga berkontribusi terhadap keberhasilan tindakan medis dan proses penyembuhan pasien.

Kemampuan perawat dalam mengelola emosi diri atau kecerdasan emosional menghadapi pasien cemas karena akan menjalani tindakan medis juga sangat mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami pasien. Kemampuan Kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) perawat memiliki peran krusial dalam merawat pasien yang cemas menghadapi tindakan medis. Perawat yang memiliki kecerdasan emosional mampu mengidentifikasi, memahami, dan mengendalikan perasaan mereka sendiri serta perasaan pasien mereka, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman dan mengurangi kecemasan pasien. Komponen Kecerdasan Emosional dalam Tindakan Keperawatan meliputi: Empati yaitu bahwa perawat mampu merasakan kecemasan pasien dan memahaminya tanpa terbawa suasana, memungkinkan mereka memberikan kenyamanan yang tulus. Pengendalian Diri yaitu Perawat tetap tenang, profesional, dan sabar meskipun menghadapi pasien yang rewel, panik, atau marah, terutama di situasi gawat darurat. Komunikasi Terapeutik yaitu perawat mampu menggunakan komunikasi yang efektif, mendengarkan aktif, dan peka terhadap isyarat non-verbal (bahasa tubuh/ekspresi wajah pasien) untuk mendeteksi ketakutan yang tidak diungkapkan dan Kesadaran Diri yaitu dimana perawat mengenali batasan emosinya sendiri sehingga tidak mengalami burnout yang bisa memengaruhi pelayanan. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Silitonga & et al, 2025) yang berjudul “Kecerdasan Emosional Dengan Kinerja Perawat Dalam Menerapkan Asuhan Keperawatan” yang mengatakan bahwasannya ada keterkaitan kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan, yang dapat diartikan dengan kemampuan perawat menurunkan tingkat kecemasan pasien merupakan keberhasilan dalam melakukan asuhan keperawatan.

Komunikasi terapeutik efektif menurunkan kecemasan pasien akibat tindakan medis dengan membangun kepercayaan melalui mendengarkan aktif, empati, bahasa mudah dipahami, dan memberi ruang tanya jawab; ini membantu pasien memahami kondisi, mengurangi ketakutan, dan mempersiapkan diri secara psikologis, serta dapat mencegah penundaan operasi akibat stres berat. Tujuannya adalah membantu mengatasi masalah, mengambil tindakan efektif, memperbaiki pengalaman emosional, dan mempercepat kesembuhan dengan membangun hubungan profesional yang berpusat pada penyembuhan pasien.

1. Prinsip Utama Komunikasi Terapeutik

Mendengarkan Aktif: Memberi perhatian penuh pada pasien, tidak hanya mendengar kata-kata tapi juga emosi yang tersirat.

Empati & Sikap Terbuka: Menunjukkan pemahaman dan penerimaan terhadap perasaan pasien, tanpa menghakimi.

Bahasa Sederhana: Menjelaskan prosedur medis menggunakan istilah yang mudah dimengerti pasien.

Sikap & Kontak Mata Ramah: Menjaga sikap tubuh yang rileks dan kontak mata untuk membangun kedekatan.

Memberi Waktu & Ruang: Membiarkan pasien mengekspresikan kecemasan dan mengajukan pertanyaan.

Langkah Penerapan untuk Pasien Cemas

a. Pembukaan (Fase Orientasi):

- 1) Sapa pasien dengan ramah, perkenalkan diri.
- 2) Tanyakan perasaan pasien saat ini, "Bagaimana perasaan Bapak/Ibu hari ini?".
- 3) Sampaikan tujuan pertemuan: "Saya di sini untuk membantu Bapak/Ibu memahami tindakan yang akan dijalani".

b. Kerja (Fase Kerja):

- 1) Jelaskan prosedur medis secara bertahap dan jelas, gunakan perumpamaan jika perlu.
- 2) Validasi perasaan pasien (misal: "Wajar jika merasa cemas").
- 3) Dorong pasien untuk mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran (takut nyeri, takut hasil, takut cacat).
- 4) Tawarkan teknik relaksasi sederhana (tarik napas dalam).
- 5) Berikan informasi terkait apa yang akan terjadi selama serta sesudah tindakan untuk mengurangi ketidakpastian.

c. Terminasi (Fase Terminasi):

- 1) Rangkum diskusi dan pastikan pasien memahami.
- 2) Tawarkan dukungan berkelanjutan.

3) Tanyakan apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan atau dibicarakan.

2. Manfaat Komunikasi Terapeutik

- a. Menurunkan Kecemasan: Informasi yang jelas mengurangi ketakutan yang tidak berdasar.
- b. Meningkatkan Koping: Membantu pasien mengelola emosi dan pikiran negatif.
- c. Mempersiapkan Pasien: Memungkinkan pasien mengambil peran aktif dalam penyembuhan.
- d. Mencegah Efek Fisiologis: Mengurangi gejala kecemasan berat (tekanan darah naik, mual) yang bisa membahayakan.

E. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Cemas Menjelang Tindakan Medis Komunikasi Terapietik Dasar

Perawatan keperawatan untuk individu yang mengalami kecemasan sebelum prosedur medis merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk membantu pasien mengatasi respon emosional yang muncul akibat ketidakpastian, ketakutan, dan persepsi ancaman terhadap kesehatan maupun keselamatan dirinya. Kecemasan yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi kondisi fisiologis, psikologis, serta kesiapan pasien dalam menjalani tindakan medis (Sari & Wahyuni, 2018). Dengan menggunakan strategi komunikasi terapeutik, perawat sangat penting dalam memberikan perawatan keperawatan. Pertukaran profesional antara perawat dan pasien yang direncanakan, dirancang, dan berpusat pada pasien secara sengaja dikenal sebagai komunikasi terapeutik. Melalui komunikasi ini, perawat dapat membangun hubungan saling percaya sehingga pasien merasa aman untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan ketakutannya (Hidayat & Nurhayati, 2019).

Menurut lestari tahap awal asuhan keperawatan dimulai dengan pengkajian, yaitu mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien, factor pencetus kecemasan, serta respon fisik dan psikologis yang muncul. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengukuran tanda-tanda vital. Pada tahap ini, perawat memakai teknik komunikasi terapeutik misalnya mendengarkan secara aktif, memberi kesempatan pasien berbicara, serta menunjukkan sikap empati. Selanjutnya pada tahap diagnose keperawatan, perawat dapat menetapkan masalah keperawatan seperti kecemasan berhubungan dengan kurangnya informasi atau pengalaman sebelumnya terhadap tindakan medis. Penetapan diagnosa yang tepat menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan.

Seorang perawat setelah melakukan pengkajian dengan pasien yang mengalami kecemasan dapat mengklasifikasikan tanda dan gejalanya jadi data subjektif serta data objektif. Data subjektif terdiri dari: "tidak nafsu makan,

diare/konstipasi, gelisah, berkeringat, tangan gemetar, sakit kepala dan sulit tidur, lelah, sulit berfikir, mudah lupa, merasa tidak berharga, perasaan tidak aman, merasa tidak bahagia, sedih dan sering menangis, sulit menikmati kegiatan harian, kehilangan minat gairah." Data objektif dapat berupa: "nadi dan tekanan darah naik, tidak mampu menerima informasi dari luar, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya ketakutan atas sesuatu yang tidak spesifik/jelas, pekerjaan sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan kegiatan harian, gerakan meremas tangan, bicara berlebihan dan cepat" (Stuart, 2009).

Pada tahap perencanaan dan implementasi, perawat merancang intervensi yang berfokus pada penurunan tingkat kecemasan pasien. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai prosedur tindakan medis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan dukungan emosional, serta mengajarkan teknik relaksasi sederhana. Seluruh tindakan ini dilakukan melalui komunikasi terapeutik yang efektif, seperti penggunaan sentuhan terapeutik, sikap tenang, dan respon verbal yang menenangkan (Song & Lindquist, 2015).

Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Keberhasilan asuhan keperawatan ditunjukkan dengan berkurangnya tanda-tanda kecemasan, pasien tampak lebih tenang, kooperatif, dan mampu menghadapi tindakan medis dengan lebih siap. Evaluasi juga menjadi dasar guna menetapkan apakah intervensi mesti dilanjutkan, dimodifikasi, ataupun dihentikan. Dengan penerapan asuhan keperawatan yang komprehensif dan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat dapat membantu pasien mengelola kecemasan secara adaptif, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung keberhasilan tindakan medis yang akan dilakukan.

1. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Ansietas

Penyebab:

- a. Terjadi krisis situasional
- b. Kebutuhan individu yang tidak terpenuhi
- c. Krisis pada tahap perkembangan
- d. Ancaman terhadap konsep diri
- e. Persepsi terhadap ancaman kematian
- f. Kekhawatiran akan kegagalan
- g. Ketidakharmonisan dalam sistem keluarga
- h. Hubungan orang tua dan anak yang tidak memadai
- i. Faktor genetik, seperti temperamen mudah teragitasi sejak lahir
- j. Penyalahgunaan zat adiktif

- k. Terpapar bahaya lingkungan, misalnya toksin atau polutan
- l. Keterbatasan dalam memperoleh informasi

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif:

- a. Kebingungan
- b. Adanya kekhawatir terhadap dampak dari keadaan yang dialami
- c. Konsentrasi terganggu

Objektif:

- a. Perilaku terlihat gelisah
- b. Ekspresi terlihat tegang
- c. Gangguan pola tidur

Gejala dan Tanda Minor

Subjektif:

- a. Pusing
- b. Penurunan nafsu makan (anoreksia)
- c. Sensasi berdebar pada jantung (palpitasi)
- d. Perasaan tidak berdaya

Objektif:

- a. Peningkatan frekuensi napas
- b. Denyut nadi naik
- c. Naiknya tekanan darah
- d. Keringat berlebihan (diaforesis)
- e. Tremor
- f. Tampak pucat pada wajah
- g. Suara bergetar
- h. Kontak mata buruk
- i. Keseringan BAK
- j. Berorientasi pada masa lalu

Kondisi Klinis Terkait

- a. Penyakit kronis progresif, seperti kanker atau gangguan autoimun
- b. Penyakit akut
- c. Proses hospitalisasi
- d. Rencana operasi
- e. Ketidakjelasan penyakit
- f. Gangguan neurologis
- g. Tahap pertumbuhan dan perkembangan

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016)

2. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia

Reduksi Ansietas

Observasi:

- Mengidentifikasi perubahan tingkat kecemasan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tekanan yang dialami pasien.
- Nilai kemampuan pasien dalam membuat keputusan
- Amati manifestasi ansietas baik secara verbal maupun nonverbal

Terapeutik:

- Bangun lingkungan terapeutik guna meningkatkan rasa percaya pasien
- Temani pasien untuk membantu mereka merasa lebih tenang dan memahami situasi yang membuat mereka cemas.
- Perhatikan dengan saksama apa yang dikatakan.
- Bersikap tenang dan sabar.
- Siapkan atau berikan benda-benda pribadi yang menenangkan.
- Dorong pasien untuk mengenali situasi yang memicu kecemasan.
- Bicarakan tentang persiapan praktis untuk acara-acara mendatang.

Edukasi:

- Jelaskan prosesnya, sebutkan perasaan yang mungkin muncul.
- Berikan detail yang akurat tentang prognosis, jalannya pengobatan, dan diagnosis.
- Jika perlu, dorong anggota keluarga untuk tetap bersama pasien.
- Bila perlu, promosikan aktivitas yang tidak bersifat kompetitif.
- Promosikan berbagi pikiran dan perasaan.
- Lakukan aktivitas yang mengurangi stres.
- Gunakan strategi mengatasi stres secara bertanggung jawab.
- Gunakan berbagai metode relaksasi.

Kolaborasi:

- Kolaborasi pemberian obat anti ansietas, apabila diperlukan (Keough & Schmidt, 2012)

Standart Luaran Keperawatan Indonesia

Tingkat ansietas dalam asuhan keperawatan dinilai melalui indicatorsubjektif dan objektif yang mencakup respon kognitif, afektif, dan fisiologi paseien (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018).

Tabel 6.1 Kriteria Hasil Tingkat Ansietas

Meningkat	Cukup Menigkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
-----------	-------------------	--------	------------------	---------

Verbalisasi kebingungan	1	2	3	4	5
Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi	1	2	3	4	5
Perilaku gelisah	1	2	3	4	5
Perilaku tegang	1	2	3	4	5
Keluhan pusing	1	2	3	4	5
Anoreksia	1	2	3	4	5
Palpitasi	1	2	3	4	5
Diaforesis	1	2	3	4	5
Tremor	1	2	3	4	5
Pucat	1	2	3	4	5

	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Konsentrasi	1	2	3	4	5
Pola tidur	1	2	3	4	5
Frekuensi pernapasan	1	2	3	4	5
Frekuensi nadi	1	2	3	4	5
Tekanan darah	1	2	3	4	5
Kontak mata	1	2	3	4	5
Pola berkemih	1	2	3	4	5
Orientasi	1	2	3	4	5

F. Kesimpulan

Kecemasan (ansietas) merupakan respons emosional berupa kekhawatiran yang menyeluruh dan tidak spesifik, muncul dari penilaian kognitif terhadap ancaman, dan bersifat adaptif bila ringan namun dapat mengganggu fungsi bila berlebihan. Kecemasan dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti stres dan trauma, ketidakseimbangan biologis (neurotransmitter/hormon), faktor genetik, lingkungan-sosial, gaya hidup, maupun kondisi medis, serta sering muncul dalam konteks keluarga terutama saat ada anggota keluarga yang sakit.

Dalam pelayanan kesehatan, kecemasan sering meningkat menjelang tindakan medis karena pasien memandang prosedur sebagai situasi mengancam: nyeri, risiko komplikasi, perubahan fungsi tubuh, dan ketidakpastian hasil. Kecemasan pra-tindakan dapat menimbulkan dampak fisiologis (tekanan darah dan nadi meningkat, otot tegang, gangguan napas) serta dampak psikologis (konsentrasi menurun, sulit

menerima informasi, dan terganggunya pengambilan keputusan), sehingga dapat memengaruhi kerja sama pasien dan kelancaran tindakan medis. Tingkat kecemasan menurut Stuart terbagi menjadi ringan, sedang, berat, dan panik, masing-masing dengan respons perilaku, kognitif, dan afektif yang berbeda, serta dapat ditangani melalui strategi koping adaptif.

Komunikasi terapeutik menjadi intervensi kunci untuk menurunkan kecemasan pasien menjelang tindakan medis. Melalui hubungan profesional yang dilandasi empati, kepercayaan, mendengarkan aktif, pemberian informasi yang jelas dan jujur, bahasa sederhana, serta dukungan verbal dan nonverbal, pasien dapat merasa lebih aman, memahami prosedur, mengurangi ketidakpastian, dan menjadi lebih kooperatif. Efektivitas komunikasi terapeutik juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional perawat dalam mengelola emosi diri dan merespons emosi pasien.

Asuhan keperawatan pada pasien cemas dilakukan secara sistematis melalui pengkajian tingkat kecemasan dan faktor pencetus, penetapan diagnosis (misalnya Ansietas menurut SDKI), perencanaan–implementasi intervensi reduksi ansietas (SIKI) termasuk edukasi, dukungan emosional, relaksasi, serta kolaborasi pemberian obat antiansietas bila diperlukan, kemudian evaluasi menggunakan indikator luaran (SLKI). Keberhasilan asuhan ditandai dengan menurunnya gejala subjektif dan objektif kecemasan, pasien lebih tenang, mampu menerima informasi, dan lebih siap menjalani tindakan medis.

G. Referensi

- Baldwin, D. S., Waldman, S., & Allgulander, C. (2014). Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders. *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 18(2), 73–85.
- Hidayat, A., & Nurhayati. (2019). Hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien preoperatif. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 14(1), 45–52.
- Keliat, B. A. (2015). Keperawatan kesehatan jiwa. Jakarta: EGC.
- Keough, M. E., & Schmidt, N. B. (2012). Refinement of a brief anxiety sensitivity reduction intervention. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 80(5), 766–772.
- Lazdia, W., Cahyani, A. A., & Kartika, I. R. (2010–2020). Komunikasi terapeutik dan kecemasan pasien rawat inap bedah.

- Lestari, T. (2017). Peran perawat dalam mengatasi ansietas pasien pratindakan medis. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 5(2), 88–94.
- Mitchell, M. (2010). Patient anxiety and modern elective surgery. *Journal of Clinical Nursing*, 19(7–8), 912–920.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2010). *Fundamentals of Nursing: Konsep, Proses, dan Praktik* (Edisi Indonesia). Jakarta: EGC.
- Putri, R. M., Siregar, R., & Handayani, S. (2020). Intervensi keperawatan dalam menurunkan kecemasan pasien sebelum tindakan medis. *Jurnal Keperawatan Klinik*, 7(3), 210–217.
- Rahima. (2022). Pengaruh kondisi fisiologis dan psikologis pasien dalam proses penyembuhan pasca-operasi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Kesehatan*, 8(1), 21–31
- Sari, D. P., & Wahyuni, S. (2018). Pengaruh komunikasi terapeutik terhadap tingkat kecemasan pasien pra operasi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(2), 95–102.
- Silitonga, E., & et al. (2025). Kecerdasan Emosional Dengan Kinerja Perawat Dalam Menerapkan Asuhan Keperawatan. *Journal of Biology Education, Science & Technology*, 8(12), 393–399
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth* (Edisi Indonesia). Jakarta: EGC.
- Song, Y., & Lindquist, R. (2015). Effects of mindfulness-based stress reduction on depression, anxiety, stress and mindfulness in Korean nursing students. *Nurse Education Today*, 35(1), 86–90.
- Stuart, G. W., & Sundeen, S. J. (2006). *Principles and practice of psychiatric nursing* (8th ed., p. 144). St. Louis, MO: Mosby.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI)* (Edisi 1, hlm. 180). Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)* (Edisi 1, hlm. 134). Jakarta: DPP PPNI
- Videbeck, S. L. (2008). *Psychiatric–mental health nursing* (4th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Winarni, L., Hariningsih, W., & Ocktavia, I. (2025). Pengaruh komunikasi terapeutik terhadap tingkat kecemasan pasien pre-operasi di ruang Fransiscus RSUD St. Antonius Pontianak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel*.

H. Glosarium

ADAPTIF (respons/koping adaptif): Cara menghadapi kecemasan secara positif dan sehat, misalnya berdoa, berbicara, relaksasi, mencari dukungan.

Afektif: Aspek emosi/perasaan yang muncul pada seseorang (misalnya tegang, takut, gugup).

Burnout: Kelelahan emosional/mental akibat stres berkepanjangan yang dapat memengaruhi kualitas kerja tenaga kesehatan.

Chest tube (selang dada): Alat medis berupa selang yang dipasang di rongga dada untuk mengeluarkan udara/cairan; dapat memicu kecemasan karena invasif.

Dyspnea: Sesak napas; dapat memperberat kecemasan karena sensasi "tercekik".

Edukasi: Pemberian informasi/penjelasan kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi kecemasan.

Fisiologis: Respon tubuh yang dapat berubah akibat kecemasan (misalnya nadi cepat, tekanan darah naik, napas cepat).

Hipokampus: Bagian otak yang terkait memori dan regulasi stres; terlibat dalam respons kecemasan.

Hospitalisasi: Proses perawatan di rumah sakit yang dapat menjadi stresor pemicu kecemasan.

Indikasi medis: Alasan/pertimbangan klinis mengapa tindakan medis perlu dilakukan.

Lingkungan terapeutik: Suasana aman, nyaman, mendukung, dan penuh kepercayaan yang dibangun untuk membantu pasien lebih tenang.

CHAPTER 7

ANAK DENGAN DEMAM AKUT : PERAN PERAWAT DALAM EDUKASI ORANG TUA

Dr. Ethyca Sari S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Demam merupakan salah satu manifestasi klinis yang paling sering ditemukan pada anak dan menjadi penyebab utama kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik di pelayanan primer, unit gawat darurat, maupun rumah sakit rujukan. Secara fisiologis, demam merupakan respons adaptif tubuh terhadap proses infeksi atau inflamasi, namun dalam praktiknya kondisi ini sering dipersepsikan secara negatif oleh orang tua. Banyak orang tua menganggap demam sebagai tanda awal penyakit berat yang dapat mengancam jiwa anak, sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan atau yang dikenal sebagai fever phobia.

Demam akut pada anak didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh di atas nilai normal yang berlangsung kurang dari tujuh hari dan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Meskipun sebagian besar kasus demam akut bersifat ringan dan dapat sembuh dengan perawatan suportif, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai mekanisme terjadinya demam, tujuan biologis demam, serta cara penanganan yang tepat sering kali berujung pada tindakan yang tidak rasional. Beberapa contoh tindakan tersebut antara lain pemberian obat antipiretik secara berlebihan, penggunaan kombinasi obat tanpa indikasi yang jelas, pemberian antibiotik tanpa resep tenaga kesehatan, serta penggunaan metode tradisional yang berpotensi membahayakan anak, seperti kompres alkohol atau pembatasan asupan cairan.

Kecemasan orang tua terhadap demam anak juga sering dipicu oleh kekhawatiran akan terjadinya komplikasi, terutama kejang demam. Persepsi yang keliru mengenai kejang demam sering menyebabkan orang tua mengambil keputusan yang tidak tepat dan terburu-buru, termasuk membawa anak ke fasilitas kesehatan meskipun kondisi masih stabil atau sebaliknya menunda pertolongan medis ketika tanda bahaya sudah muncul. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam penanganan demam akut pada anak bukan hanya terletak pada aspek medis, tetapi juga pada kurangnya edukasi kesehatan yang komprehensif bagi orang tua.

Dalam konteks pelayanan kesehatan anak, perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan edukasi kepada orang tua. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan anak dan keluarga, sehingga

memiliki kesempatan luas untuk menyampaikan informasi kesehatan secara berkesinambungan. Peran perawat tidak hanya terbatas pada pemberian asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai edukator, konselor, dan advokat bagi anak dan keluarganya. Melalui pendekatan edukatif yang tepat, perawat dapat membantu orang tua memahami bahwa demam merupakan gejala, bukan penyakit, serta menjelaskan kapan demam dapat ditangani di rumah dan kapan diperlukan pertolongan medis segera (3).

Edukasi yang diberikan oleh perawat harus berbasis bukti (*evidence-based practice*), mudah dipahami, serta disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya, dan kepercayaan orang tua. Edukasi yang efektif terbukti dapat meningkatkan pengetahuan orang tua, mengurangi kecemasan, meningkatkan keterampilan dalam melakukan perawatan anak di rumah, serta menurunkan angka kunjungan yang tidak perlu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, edukasi yang baik juga berperan dalam mencegah kesalahan penanganan demam yang dapat membahayakan keselamatan anak, seperti overdosis antipiretik dan keterlambatan deteksi tanda bahaya (4)

Dengan demikian, peran perawat dalam edukasi orang tua menjadi komponen yang sangat penting dalam manajemen anak dengan demam akut. Pendekatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan anak secara langsung, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam merawat anaknya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai anak dengan demam akut dan peran perawat dalam edukasi orang tua perlu dikaji secara mendalam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan anak dan keselamatan pasien pediatrik.

B. Konsep Demam pada Anak

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep demam pada anak merupakan dasar penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman dan efektif, sekaligus menjadi landasan utama dalam memberikan edukasi kepada orang tua. Kesalahan persepsi tentang demam masih sering terjadi, baik di masyarakat maupun di lingkungan pelayanan kesehatan, sehingga perawat perlu memahami konsep demam secara ilmiah agar mampu menjelaskan kondisi ini dengan bahasa yang mudah dipahami dan aplikatif.

1. Definisi Demam

Demam merupakan kondisi peningkatan suhu tubuh di atas batas normal sebagai akibat dari perubahan pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai “termostat” tubuh yang mengatur keseimbangan suhu agar tetap berada dalam rentang normal. Pada kondisi tertentu, seperti

infeksi atau peradangan, hipotalamus akan menaikkan titik setel (*set point*) suhu tubuh sehingga suhu tubuh meningkat secara sistemik (1).

Pada anak, batas suhu tubuh yang dikategorikan sebagai demam umumnya adalah $\geq 38^{\circ}\text{C}$, namun nilai ini sangat bergantung pada metode pengukuran yang digunakan. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Rektal: dianggap paling akurat untuk bayi dan anak kecil, dengan nilai demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$.
- b. Oral: digunakan pada anak yang lebih besar, dengan nilai demam $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$.
- c. Aksila: sering digunakan karena mudah dan aman, namun kurang akurat; demam biasanya $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$.
- d. Timpani (telinga): praktis, namun hasil dapat dipengaruhi oleh teknik dan posisi alat.

Perawat perlu memahami perbedaan metode pengukuran ini karena kesalahan interpretasi suhu tubuh dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat. Dalam praktik keperawatan, perawat juga memiliki peran penting dalam mengedukasi orang tua mengenai cara mengukur suhu tubuh anak yang benar dan konsisten, serta menjelaskan bahwa variasi metode pengukuran dapat menghasilkan angka yang berbeda (2). Penting untuk dipahami bahwa demam bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala atau tanda dari suatu kondisi yang mendasarinya. Dengan pemahaman ini, perawat dapat membantu orang tua untuk tidak hanya berfokus pada angka suhu tubuh, tetapi juga pada kondisi umum anak, seperti tingkat kesadaran, asupan cairan, aktivitas, dan adanya tanda bahaya lainnya.

2. Mekanisme Terjadinya Demam

Secara fisiologis, demam merupakan hasil dari respons kompleks sistem imun terhadap rangsangan tertentu, terutama infeksi. Ketika tubuh anak terpapar patogen seperti virus atau bakteri, sel-sel imun akan melepaskan zat yang disebut pirogen. Pirogen dapat berasal dari luar tubuh (*pirogen eksogen*), seperti toksin bakteri, atau dari dalam tubuh (*pirogen endogen*), seperti interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) (5). Pirogen endogen ini akan memengaruhi hipotalamus dengan meningkatkan produksi prostaglandin E₂ (PGE₂). Peningkatan PGE₂ menyebabkan hipotalamus menaikkan *set point* suhu tubuh. Akibatnya, tubuh akan menganggap suhu normal sebagai "terlalu rendah" dan memicu mekanisme peningkatan suhu, seperti:

- a. Vasokonstriksi perifer (kulit terasa dingin)
- b. Menggigil

c. Peningkatan metabolisme

Proses ini menjelaskan mengapa anak yang sedang demam sering tampak menggigil meskipun suhu tubuhnya meningkat. Setelah patogen berhasil dikendalikan dan kadar pirogen menurun, hipotalamus akan menurunkan kembali *set point* suhu tubuh ke kondisi normal. Pada fase ini, tubuh akan melepaskan panas melalui vasodilatasi dan berkeringat (1). Dari sudut pandang klinis, mekanisme demam sebenarnya bersifat protektif. Suhu tubuh yang meningkat dapat:

- a. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme
- b. Meningkatkan aktivitas sel imun
- c. Mempercepat respons penyembuhan

Namun, pada anak, terutama bayi dan balita, respons fisiologis terhadap demam masih belum matang sepenuhnya. Oleh karena itu, demam yang tidak dipantau dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti dehidrasi, peningkatan kebutuhan metabolik, dan pada sebagian anak dapat memicu kejang demam. Pemahaman mekanisme ini sangat penting bagi perawat dalam menentukan intervensi yang tepat serta menjelaskan kepada orang tua bahwa tujuan penanganan demam bukan semata-mata menurunkan suhu, tetapi menjaga kenyamanan dan keselamatan anak.

3. Demam Akut pada Anak

Demam akut pada anak didefinisikan sebagai demam yang berlangsung kurang dari 7 hari dan umumnya disebabkan oleh infeksi akut. Penyebab tersering demam akut pada anak adalah infeksi virus, seperti infeksi saluran pernapasan atas, gastroenteritis, dan penyakit virus lainnya. Infeksi bakteri juga dapat menjadi penyebab, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan infeksi virus (4). Sebagian besar kasus demam akut pada anak bersifat *self-limiting*, artinya dapat sembuh dengan sendirinya seiring dengan membaiknya kondisi infeksi. Namun demikian, demam akut tetap memerlukan pemantauan yang tepat karena pada beberapa kondisi dapat menjadi tanda awal penyakit serius. Oleh karena itu, perawat perlu menilai demam secara holistik, tidak hanya berdasarkan durasi dan tinggi suhu tubuh, tetapi juga memperhatikan:

- a. Usia anak
- b. Kondisi umum dan tingkat kesadaran
- c. Pola makan dan minum
- d. Riwayat kejang demam
- e. Adanya tanda bahaya, seperti sesak napas, muntah terus-menerus, atau ruam perdarahan

Dalam praktik keperawatan, pemahaman mengenai demam akut sangat penting untuk menentukan prioritas asuhan dan edukasi yang diberikan kepada orang tua. Perawat perlu menjelaskan bahwa tidak semua demam memerlukan pengobatan agresif atau antibiotik, serta menekankan pentingnya observasi kondisi anak secara menyeluruh. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam merawat anak di rumah, mengurangi kecemasan berlebihan, dan mencegah keterlambatan penanganan pada kondisi yang berisiko.

Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai definisi demam, mekanisme terjadinya demam, dan karakteristik demam akut pada anak menjadi fondasi utama bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, rasional, dan berbasis bukti, sekaligus mendukung peran perawat sebagai edukator bagi orang tua.

4. Implikasi Konsep Demam pada Anak dalam Praktik Keperawatan

Pemahaman konsep demam pada anak tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dapat diterapkan secara langsung dalam praktik keperawatan. Perawat berperan sebagai penghubung antara ilmu medis dan pemahaman orang tua, sehingga konsep demam dapat diterjemahkan menjadi tindakan perawatan yang aman, rasional, dan efektif.

C. Dampak Demam Akut pada Anak dan Keluarga

Demam akut pada anak tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek psikologis, emosional, dan sosial, baik pada anak maupun keluarganya, khususnya orang tua. Dalam konteks keperawatan anak dan keluarga, demam akut harus dipahami sebagai kondisi yang bersifat multidimensional, karena respons keluarga terhadap demam sering kali menentukan bagaimana anak dirawat, kapan pertolongan medis dicari, serta keputusan-keputusan kesehatan yang diambil selama masa sakit anak.

1. Dampak Demam Akut terhadap Anak

Secara fisik, demam akut dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis pada tubuh anak. Peningkatan suhu tubuh akan meningkatkan laju metabolisme basal, kebutuhan oksigen, serta kebutuhan cairan. Apabila tidak diimbangi dengan asupan cairan yang adekuat, anak berisiko mengalami dehidrasi, terutama pada bayi dan balita yang cadangan cairannya terbatas. Selain itu, demam sering disertai dengan penurunan nafsu makan, lemas, rewel, dan gangguan tidur, yang secara keseluruhan dapat menurunkan kenyamanan dan kualitas hidup anak selama sakit (6).

Pada sebagian anak, demam akut dapat memicu terjadinya kejang demam, terutama pada usia 6 bulan hingga 5 tahun. Meskipun sebagian besar kejang

demam bersifat sederhana dan tidak menimbulkan kerusakan neurologis jangka panjang, kondisi ini sering menimbulkan pengalaman yang menakutkan, baik bagi anak maupun orang tua. Dari sudut pandang keperawatan, kejadian ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat memperberat kecemasan keluarga dan memengaruhi pola perawatan anak selanjutnya. Selain dampak fisik, demam akut juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Anak yang mengalami demam sering kali merasa tidak nyaman, mudah menangis, dan menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Pada anak usia prasekolah dan sekolah, kondisi ini dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau ketergantungan yang lebih tinggi terhadap orang tua. Perubahan perilaku ini perlu dipahami sebagai respons normal anak terhadap kondisi sakit, namun tetap memerlukan pendekatan keperawatan yang suportif dan empatik (7)

2. Dampak Psikologis Demam Akut terhadap Orang Tua

Demam akut pada anak sering menimbulkan respons emosional yang kuat pada orang tua, terutama ibu sebagai pengasuh utama. Banyak orang tua menganggap demam sebagai tanda awal penyakit serius atau kondisi yang dapat membahayakan nyawa anak. Persepsi ini sering diperkuat oleh kurangnya pengetahuan, pengalaman traumatis sebelumnya, serta informasi yang tidak akurat dari lingkungan atau media sosial. Kondisi ini dikenal sebagai *ketakutan terhadap demam* atau *fever phobia* (7).

Kecemasan orang tua terhadap demam anak sering kali berpusat pada ketakutan akan kejang demam, kerusakan otak, atau kematian. Kekhawatiran ini dapat muncul bahkan pada demam ringan dan menyebabkan orang tua melakukan pemantauan suhu secara berlebihan, memberikan obat penurun panas terlalu sering, atau menggunakan berbagai metode penanganan yang tidak dianjurkan. Dalam jangka pendek, kecemasan ini dapat mengganggu kemampuan orang tua untuk berpikir rasional dan membuat keputusan yang tepat terkait perawatan anak.

Selain kecemasan, orang tua juga dapat mengalami stres emosional akibat rasa tidak berdaya dalam menghadapi kondisi anak yang sakit. Stres ini dapat diperberat oleh kurangnya dukungan sosial, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, atau pengalaman sebelumnya yang kurang menyenangkan saat membawa anak ke fasilitas kesehatan. Pada beberapa keluarga, kondisi ini bahkan dapat memicu konflik antaranggota keluarga terkait cara penanganan demam anak.

3. Dampak Demam Akut terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga

Kecemasan dan ketakutan orang tua terhadap demam akut pada anak dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perawatan. Orang tua yang sangat cemas cenderung mengambil keputusan secara impulsif, seperti segera membawa anak ke unit gawat darurat meskipun kondisi anak masih stabil. Sebaliknya, sebagian orang tua dapat menunda pencarian pertolongan medis karena menganggap demam sebagai kondisi biasa, sehingga berisiko terlambat mendeteksi tanda bahaya. (8). Keputusan yang tidak tepat dalam penanganan demam dapat berdampak pada keselamatan anak, misalnya pemberian antipiretik dengan dosis yang tidak sesuai, penggunaan obat tanpa resep tenaga kesehatan, atau penerapan praktik tradisional yang berisiko. Dari sudut pandang keperawatan, kondisi ini menunjukkan bahwa dampak demam akut tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek pengetahuan, sikap, dan kepercayaan keluarga. (9). Demam akut juga dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi keluarga. Orang tua mungkin harus meninggalkan pekerjaan sementara untuk merawat anak, mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeriksaan kesehatan, atau mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat kurang tidur selama menjaga anak yang demam. Dampak ini semakin terasa pada keluarga dengan sumber daya terbatas.

4. Implikasi Dampak Demam Akut bagi Praktik Keperawatan

Pemahaman mengenai dampak demam akut pada anak dan keluarga memiliki implikasi penting dalam praktik keperawatan. Perawat tidak hanya berfokus pada penurunan suhu tubuh anak, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi psikologis orang tua dan dinamika keluarga. Pendekatan keperawatan yang berorientasi pada keluarga (*family-centered care*) menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Perawat berperan dalam:

- a. Mengidentifikasi tingkat kecemasan orang tua
- b. Memberikan informasi yang jelas, konsisten, dan berbasis bukti
- c. Menenangkan orang tua melalui komunikasi terapeutik
- d. Memberdayakan orang tua agar mampu merawat anak secara mandiri dan aman

Dengan memahami dampak demam akut secara menyeluruh, perawat dapat membantu keluarga mengelola kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri orang tua, serta mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan anak (10).

D. Peran Perawat dalam Asuhan Anak dengan Demam Akut

Perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam asuhan anak dengan demam akut karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat, paling lama berinteraksi, dan paling sering berkomunikasi dengan anak serta keluarganya. Dalam konteks pelayanan kesehatan anak, peran perawat tidak hanya terbatas pada tindakan teknis keperawatan, tetapi juga mencakup peran edukatif, advokat, dan suportif bagi keluarga. Asuhan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dan berpusat pada keluarga (*family-centered care*) terbukti dapat meningkatkan kualitas perawatan anak dengan demam akut serta mengurangi kecemasan orang tua (6).

Peran perawat dalam asuhan anak dengan demam akut meliputi peran sebagai pemberi asuhan keperawatan, edukator kesehatan, advokat pasien dan keluarga, serta konselor bagi orang tua. Keempat peran ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik keperawatan sehari-hari.

1. Perawat sebagai Pemberi Asuhan Keperawatan

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat bertanggung jawab melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Pada anak dengan demam akut, pengkajian keperawatan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk menentukan tingkat keparahan kondisi anak dan kebutuhan intervensi selanjutnya. (11)ⁱ. Pengkajian yang dilakukan perawat tidak hanya berfokus pada pengukuran suhu tubuh, tetapi juga mencakup kondisi umum anak, tingkat kesadaran, aktivitas, pola makan dan minum, serta adanya tanda bahaya. Perawat juga perlu mengkaji riwayat kesehatan anak, termasuk usia, riwayat imunisasi, riwayat kejang demam, serta kondisi lingkungan dan dukungan keluarga. Pendekatan pengkajian yang komprehensif ini sejalan dengan standar asuhan keperawatan anak yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (3).

Dalam tahap implementasi, perawat melakukan berbagai tindakan keperawatan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan anak, seperti memantau suhu tubuh secara berkala, memastikan kecukupan cairan, membantu mengatur pakaian anak agar tidak terlalu tebal, serta berkolaborasi dengan tenaga medis dalam pemberian terapi farmakologis sesuai indikasi. Perawat juga berperan dalam mencegah komplikasi demam, seperti dehidrasi dan kejang demam, melalui pemantauan yang berkesinambungan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai respons anak terhadap asuhan yang diberikan, termasuk penurunan keluhan, perbaikan kondisi umum, serta kemampuan orang tua dalam melanjutkan perawatan di rumah. Dengan

demikian, peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan menjadi dasar utama dalam penanganan anak dengan demam akut.

2. Perawat sebagai Edukator Kesehatan

Peran perawat sebagai edukator kesehatan merupakan peran yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam asuhan anak dengan demam akut. Edukasi yang diberikan perawat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam merawat anak yang mengalami demam, baik selama berada di fasilitas kesehatan maupun setelah kembali ke rumah.

Dalam praktik keperawatan, perawat perlu memberikan edukasi yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan tingkat pemahaman orang tua. Materi edukasi meliputi pengertian demam, penyebab demam akut, cara mengukur suhu tubuh yang benar, serta prinsip dasar penanganan demam di rumah. Perawat juga perlu menjelaskan bahwa demam merupakan respons alami tubuh terhadap infeksi dan tidak selalu berbahaya, sehingga orang tua tidak perlu panik berlebihan (IDAI, 2020).

Edukasi mengenai penggunaan obat penurun panas juga menjadi aspek penting. Perawat perlu mengajarkan dosis yang tepat sesuai usia dan berat badan anak, interval pemberian obat, serta risiko penggunaan obat yang berlebihan. Selain itu, perawat harus meluruskan berbagai mitos yang masih berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa demam harus selalu diturunkan hingga suhu normal atau bahwa kejang demam selalu berakibat fatal.

Perawat juga berperan dalam mengedukasi orang tua mengenai tanda bahaya demam yang memerlukan pertolongan medis segera, seperti penurunan kesadaran, kejang, sesak napas, muntah berulang, atau anak tidak mau minum sama sekali. Edukasi yang efektif akan meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam merawat anak dan mencegah keterlambatan penanganan pada kondisi yang berisiko⁽¹²⁾

3. Perawat sebagai Advokat Pasien dan Keluarga

Sebagai advokat pasien dan keluarga, perawat berperan melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan yang aman, sesuai kebutuhan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dalam kasus anak dengan demam akut, perawat perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis anak serta kesiapan keluarga dalam menerima dan melanjutkan perawatan. (11).

Perawat juga berperan sebagai penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan lainnya. Apabila orang tua mengalami kesulitan memahami informasi medis yang diberikan, perawat dapat membantu menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, perawat dapat menyampaikan

kekhawatiran atau kebutuhan keluarga kepada tim kesehatan agar perawatan yang diberikan lebih sesuai dan komprehensif.

Peran advokasi ini sangat penting terutama pada keluarga dengan keterbatasan pengetahuan atau sumber daya. Dengan melakukan advokasi yang tepat, perawat dapat membantu mencegah tindakan medis yang tidak perlu, memastikan penggunaan obat yang aman, serta mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis informasi.

4. Perawat sebagai Konselor bagi Orang Tua

Demam akut pada anak sering menimbulkan kecemasan dan stres emosional pada orang tua. Oleh karena itu, perawat juga berperan sebagai konselor yang memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada keluarga. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat membantu orang tua mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya yang mereka alami.

Sebagai konselor, perawat perlu bersikap empatik, tidak menghakimi, dan memberikan rasa aman kepada orang tua. Perawat dapat membantu orang tua memahami kondisi anak secara realistis, menenangkan kecemasan, serta memberikan harapan yang rasional berdasarkan kondisi klinis anak. Dukungan emosional ini sangat penting untuk membantu orang tua tetap tenang dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam perawatan anak. Pendekatan konseling yang dilakukan perawat juga dapat meningkatkan hubungan saling percaya antara perawat dan keluarga. Hubungan yang baik ini akan memudahkan proses edukasi dan meningkatkan kepatuhan orang tua terhadap rencana perawatan yang telah disepakati (13)

5. Integrasi Peran Perawat dalam Asuhan Berpusat pada Keluarga

Keempat peran perawat sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, dan konselor harus dijalankan secara terintegrasi dalam kerangka asuhan keperawatan berpusat pada keluarga. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan anak, sehingga orang tua tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses perawatan.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut secara optimal, perawat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak dengan demam akut, mengurangi kecemasan orang tua, serta mencegah kesalahan penanganan yang dapat membahayakan anak. Oleh karena itu, peran perawat dalam asuhan anak dengan demam akut merupakan komponen kunci dalam pelayanan keperawatan anak yang berkualitas dan berkelanjutan.

E. Edukasi Orang Tua tentang Demam Akut

Edukasi orang tua merupakan komponen kunci dalam asuhan keperawatan anak dengan demam akut. Keberhasilan penanganan demam pada anak tidak hanya ditentukan oleh intervensi medis di fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan orang tua dalam melanjutkan perawatan secara mandiri di rumah. Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan keluarga.

1. Tujuan Edukasi Orang Tua

a. Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua

Tujuan utama edukasi adalah meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai demam sebagai suatu gejala, bukan penyakit. Banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru bahwa demam selalu berbahaya dan harus segera diturunkan hingga suhu normal. Melalui edukasi, perawat membantu orang tua memahami mekanisme demam, penyebabnya, serta perbedaan antara demam ringan dan demam yang memerlukan penanganan segera. Peningkatan pengetahuan ini menjadi dasar penting bagi orang tua dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perawatan anak (6)

b. Mengurangi Kecemasan Orang Tua

Kurangnya pengetahuan sering kali memicu kecemasan berlebihan pada orang tua. Edukasi yang tepat dapat membantu orang tua memahami bahwa sebagian besar demam akut bersifat ringan dan dapat ditangani di rumah. Dengan penjelasan yang jelas dan berbasis bukti, perawat dapat menurunkan tingkat kecemasan orang tua, sehingga mereka lebih tenang, rasional, dan mampu merawat anak secara optimal. (14)

c. Meningkatkan Keterampilan Perawatan di Rumah

Selain pengetahuan, edukasi juga bertujuan meningkatkan keterampilan praktis orang tua dalam merawat anak yang demam, seperti mengukur suhu tubuh dengan benar, memberikan cairan, dan menggunakan obat antipiretik sesuai dosis. Keterampilan ini sangat penting agar orang tua tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan, tetapi mampu melakukan perawatan dasar secara mandiri dan aman (13)

d. Mencegah Komplikasi

Edukasi yang efektif berperan dalam mencegah komplikasi demam, seperti dehidrasi, kejang demam, dan keterlambatan penanganan penyakit serius. Dengan mengetahui tanda bahaya dan langkah yang harus dilakukan, orang tua dapat segera mencari pertolongan medis pada waktu yang tepat (7)

2. Materi Edukasi yang Perlu Disampaikan (10)

a. Pengertian dan Penyebab Demam

Perawat perlu menjelaskan bahwa demam adalah respons alami tubuh terhadap infeksi atau peradangan. Penyebab demam akut pada anak sebagian besar adalah infeksi virus, meskipun infeksi bakteri juga dapat terjadi. Penjelasan ini penting untuk mencegah penggunaan antibiotik yang tidak rasional.

b. Cara Mengukur Suhu Tubuh yang Benar

Perawat harus mengajarkan metode pengukuran suhu tubuh yang tepat sesuai usia anak, termasuk cara menggunakan termometer aksila atau digital. Orang tua juga perlu diberi pemahaman bahwa hasil pengukuran dapat berbeda tergantung metode yang digunakan dan hal tersebut merupakan kondisi yang normal.

c. Penanganan Demam di Rumah

Materi ini mencakup prinsip dasar perawatan demam di rumah, seperti memastikan anak cukup istirahat, memberikan cairan yang cukup, serta menjaga kenyamanan anak. Perawat juga perlu menekankan bahwa tujuan utama penanganan demam adalah meningkatkan kenyamanan anak, bukan semata-mata menurunkan suhu tubuh.

d. Penggunaan Obat Antipiretik yang Aman

Perawat harus menjelaskan jenis antipiretik yang aman untuk anak, dosis sesuai berat badan dan usia, serta interval pemberian obat. Edukasi ini penting untuk mencegah overdosis dan efek samping obat akibat penggunaan yang tidak tepat.

e. Tanda Bahaya yang Memerlukan Pertolongan Medis Segera

Orang tua perlu mengetahui tanda bahaya demam, seperti penurunan kesadaran, kejang, sesak napas, muntah terus-menerus, tidak mau minum, atau demam pada bayi usia kurang dari tiga bulan. Informasi ini membantu orang tua dalam menentukan kapan harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan.

F. Strategi Edukasi yang Efektif

Edukasi yang efektif harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi psikososial orang tua.

1. Edukasi Verbal Sederhana

Perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menggunakan istilah medis yang sulit dipahami. Edukasi verbal memungkinkan interaksi langsung dan penyesuaian informasi sesuai kebutuhan orang tua.

2. Media Leaflet atau Booklet

Penggunaan media cetak seperti leaflet atau booklet dapat membantu orang tua mengingat kembali informasi yang telah disampaikan. Media ini juga dapat dibawa pulang sebagai panduan perawatan di rumah.

3. Demonstrasi Langsung

Demonstrasi langsung, seperti cara mengukur suhu atau memberikan obat, sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua. Metode ini sangat dianjurkan dalam edukasi keperawatan anak.

4. Metode Teach-Back

Metode teach-back dilakukan dengan meminta orang tua mengulangi kembali informasi yang telah diberikan. Cara ini membantu perawat menilai sejauh mana orang tua memahami edukasi yang disampaikan. Komunikasi terapeutik menjadi landasan utama dalam seluruh strategi edukasi. Sika

G. Penanganan Demam di Rumah: Peran Edukasi Perawat

Penanganan demam di rumah merupakan bagian penting dari manajemen demam akut pada anak, mengingat sebagian besar kasus demam akut tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan dapat ditangani secara mandiri oleh keluarga. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran sentral dalam membimbing dan memberdayakan orang tua agar mampu melakukan perawatan demam secara aman, tepat, dan rasional di rumah. Edukasi yang diberikan perawat bertujuan untuk mencegah komplikasi, mengurangi kecemasan orang tua, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan anak selama mengalami demam (15). Perawat perlu memastikan bahwa orang tua tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengerti alasan di balik setiap tindakan perawatan. Dengan demikian, orang tua diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat ketika anak mengalami demam, baik dalam kondisi ringan maupun saat muncul tanda bahaya.

1. Memberikan Cairan yang Cukup

Pemberian cairan yang cukup merupakan aspek fundamental dalam penanganan demam pada anak. Secara fisiologis, peningkatan suhu tubuh akan meningkatkan laju metabolisme dan pengeluaran cairan melalui keringat serta pernapasan. Apabila kehilangan cairan ini tidak diimbangi dengan asupan yang adekuat, anak berisiko mengalami dehidrasi, terutama pada bayi dan balita yang cadangan cairan tubuhnya relatif terbatas (6). Perawat perlu mengedukasi orang tua bahwa tanda-tanda awal dehidrasi dapat berupa berkurangnya frekuensi buang air kecil, mulut kering, anak tampak lemas, serta menangis tanpa air mata. Oleh karena itu, orang tua dianjurkan untuk meningkatkan pemberian cairan selama anak demam, meskipun nafsu makan anak menurun.

Jenis cairan yang diberikan harus disesuaikan dengan usia anak. Pada bayi, ASI tetap menjadi pilihan utama karena selain memenuhi kebutuhan cairan, ASI juga mengandung zat imunologis yang membantu proses penyembuhan. Pada anak yang lebih besar, cairan dapat berupa air putih, oralit, atau cairan rumah tangga lain yang aman dan mudah diterima anak. Perawat juga perlu mengingatkan orang tua untuk memberikan cairan secara bertahap dan sering, terutama bila anak tidak mampu minum dalam jumlah besar sekaligus.

Edukasi mengenai pentingnya cairan ini bertujuan untuk mencegah komplikasi demam berupa dehidrasi dan mempercepat pemulihan kondisi anak.

2. Mengatur Pakaian Anak

Pengaturan pakaian anak selama demam merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan suhu tubuh dan meningkatkan kenyamanan anak. Perawat perlu menjelaskan bahwa saat demam, tubuh anak berusaha melepaskan panas melalui kulit. Penggunaan pakaian yang terlalu tebal atau berlapis-lapis justru akan menghambat proses pengeluaran panas tersebut dan dapat menyebabkan suhu tubuh semakin meningkat.

Orang tua perlu diajarkan untuk mengenakan pakaian yang tipis, longgar, dan menyerap keringat, seperti pakaian berbahan katun. Lingkungan tempat anak beristirahat juga perlu dijaga agar tetap nyaman, tidak terlalu panas dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Penggunaan selimut tebal sebaiknya dihindari, kecuali anak menggigil hebat pada fase awal demam, dan itupun hanya sementara.

Perawat juga perlu meluruskan anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa anak yang demam harus “dibungkus” agar tidak masuk angin. Edukasi ini penting agar orang tua memahami bahwa pengaturan pakaian yang tepat justru membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan aman (7)

3. Memberikan Antipiretik Sesuai Dosis

Pemberian obat antipiretik merupakan salah satu tindakan yang sering dilakukan orang tua ketika anak mengalami demam. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan antipiretik dilakukan secara aman dan rasional. Edukasi harus mencakup jenis obat yang dianjurkan, dosis yang tepat sesuai berat badan dan usia anak, frekuensi pemberian, serta cara pemberian yang benar.

Perawat perlu menekankan bahwa tujuan utama pemberian antipiretik adalah untuk meningkatkan kenyamanan anak, bukan semata-mata untuk menurunkan angka suhu tubuh. Antipiretik diberikan apabila anak tampak tidak nyaman, rewel, atau kesakitan akibat demam. Pemberian obat secara rutin tanpa mempertimbangkan kondisi anak perlu dihindari.

Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah pemberian dosis yang berlebihan, interval pemberian yang terlalu dekat, atau penggunaan lebih dari satu jenis antipiretik tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Perawat harus menjelaskan risiko yang dapat timbul akibat kesalahan tersebut, seperti gangguan fungsi hati atau ginjal. Dengan edukasi yang jelas dan berulang, perawat dapat membantu orang tua menggunakan antipiretik secara aman dan bertanggung jawab (3)

4. Menghindari Praktik yang Tidak Dianjurkan

Masih banyak praktik penanganan demam yang dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun atau informasi yang tidak tepat, yang justru berpotensi membahayakan anak. Salah satu praktik yang sering ditemukan adalah penggunaan kompres alkohol. Perawat perlu menjelaskan bahwa alkohol dapat diserap melalui kulit dan saluran pernapasan anak, sehingga berisiko menimbulkan efek toksik.

Selain itu, pemberian obat-obatan tanpa resep, termasuk antibiotik, juga merupakan praktik yang tidak dianjurkan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan efek samping yang merugikan. Perawat juga perlu mengingatkan orang tua untuk tidak menggunakan obat tradisional atau ramuan tertentu tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama pada bayi dan balita.

Edukasi mengenai praktik yang harus dihindari ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan anak selama perawatan di rumah. Perawat perlu menyampaikan informasi ini dengan pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi, sehingga orang tua dapat menerima dan menerapkan edukasi dengan baik.

5. Peran Edukasi Perawat dalam Meningkatkan Keselamatan Anak

Secara keseluruhan, edukasi perawat dalam penanganan demam di rumah berfokus pada pemberdayaan orang tua agar mampu merawat anak secara mandiri, aman, dan efektif. Dengan pemahaman yang baik mengenai pemberian cairan, pengaturan pakaian, penggunaan antipiretik, serta praktik yang harus dihindari, orang tua diharapkan dapat mencegah komplikasi demam dan meningkatkan kenyamanan anak.

Pendekatan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan membantu membangun kepercayaan diri orang tua, mengurangi kecemasan berlebihan, serta memperkuat peran keluarga sebagai mitra utama dalam asuhan keperawatan anak dengan demam akut.

H. Pencegahan Kesalahan Umum dalam Penanganan Demam pada Anak

Penanganan demam pada anak di lingkungan keluarga masih sering diwarnai oleh berbagai kesalahan yang berpotensi membahayakan keselamatan anak. Kesalahan-kesalahan tersebut umumnya berakar dari kurangnya pengetahuan orang tua, persepsi yang keliru tentang demam, serta pengaruh informasi yang tidak akurat dari lingkungan sekitar maupun media. Oleh karena itu, pencegahan kesalahan dalam penanganan demam menjadi bagian penting dari asuhan keperawatan anak. Perawat memiliki peran strategis dalam meluruskan miskonsepsi dan membimbing orang tua agar mampu melakukan perawatan demam secara aman dan rasional melalui edukasi yang berkelanjutan. (16)

1. Overdosis Obat Antipiretik

Salah satu kesalahan paling sering terjadi dalam penanganan demam pada anak adalah pemberian obat antipiretik secara berlebihan. Banyak orang tua beranggapan bahwa semakin sering obat penurun panas diberikan, maka demam anak akan lebih cepat sembuh. Persepsi ini mendorong orang tua untuk memberikan obat antipiretik dengan dosis yang tidak sesuai, interval yang terlalu dekat, atau bahkan mengombinasikan dua jenis antipiretik tanpa rekomendasi tenaga kesehatan.

Dalam praktik klinis, overdosis antipiretik dapat menimbulkan dampak serius bagi anak, seperti gangguan fungsi hati dan ginjal. Risiko ini semakin besar pada bayi dan balita karena sistem metabolisme tubuh mereka belum berkembang sempurna. Selain itu, pemberian antipiretik yang berlebihan dapat menutupi gejala penyakit yang mendasari, sehingga memperlambat deteksi kondisi serius. (8).

Perawat berperan penting dalam mencegah terjadinya kesalahan ini dengan memberikan edukasi yang jelas dan konsisten mengenai penggunaan antipiretik yang aman. Perawat perlu menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian antipiretik adalah untuk meningkatkan kenyamanan anak, bukan sekadar menurunkan angka suhu tubuh. Edukasi harus mencakup dosis sesuai berat badan dan usia anak, interval pemberian yang tepat, serta pentingnya mencatat waktu pemberian obat. Dengan pendekatan edukatif yang tepat, perawat dapat membantu orang tua menggunakan antipiretik secara rasional dan aman (3)

2. Pemberian Antibiotik tanpa Resep Tenaga Kesehatan

Kesalahan umum lainnya adalah pemberian antibiotik tanpa resep atau rekomendasi tenaga kesehatan. Praktik ini masih sering ditemukan di masyarakat, baik karena sisa obat dari pengobatan sebelumnya maupun karena anggapan bahwa demam selalu disebabkan oleh infeksi bakteri. Padahal, sebagian besar

demam akut pada anak disebabkan oleh infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik ((7).

Pemberian antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti resistensi antibiotik, reaksi alergi, dan gangguan keseimbangan flora normal tubuh anak. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat memberikan rasa aman palsu bagi orang tua, sehingga mereka mengabaikan pemantauan kondisi anak secara menyeluruh.

Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi mengenai perbedaan infeksi virus dan bakteri, serta menjelaskan bahwa antibiotik hanya efektif untuk infeksi bakteri tertentu. Perawat juga perlu menekankan pentingnya mengikuti anjuran tenaga kesehatan dan tidak menggunakan antibiotik tanpa pemeriksaan yang memadai. Edukasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan resistensi antibiotik dan peningkatan keselamatan pasien anak. (9),

3. Panik Berlebihan terhadap Kejang Demam

Kejang demam merupakan salah satu komplikasi demam yang paling ditakuti oleh orang tua. Ketakutan ini sering kali tidak proporsional dengan risiko yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kepanikan berlebihan. Banyak orang tua menganggap bahwa kejang demam dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau kematian, padahal sebagian besar kejang demam bersifat sederhana dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang ((7). Panik berlebihan terhadap kejang demam dapat mendorong orang tua melakukan tindakan yang tidak tepat, seperti mengguncang anak, memasukkan benda ke dalam mulut anak, atau segera memberikan berbagai obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Tindakan-tindakan tersebut justru berpotensi membahayakan anak.

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi yang benar mengenai kejang demam, termasuk pengertian, faktor risiko, serta penanganan awal yang tepat. Edukasi ini bertujuan untuk membantu orang tua tetap tenang dan mampu bertindak secara rasional apabila kejang demam terjadi. Selain itu, perawat perlu menekankan bahwa kejang demam tidak selalu dapat dicegah dengan pemberian antipiretik, sehingga fokus perawatan tetap pada pemantauan kondisi anak secara menyeluruh.

4. Peran Edukasi Perawat dalam Meluruskan Miskonsepsi

Ketiga kesalahan umum dalam penanganan demam tersebut menunjukkan pentingnya peran edukasi perawat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan keluarga. Edukasi tidak cukup diberikan sekali, tetapi perlu diulang dan diperkuat pada setiap kesempatan interaksi dengan orang tua. Perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh konkret, serta

memanfaatkan media edukasi yang sesuai untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan baik.

Selain memberikan informasi, perawat juga perlu membangun hubungan saling percaya dengan orang tua melalui komunikasi terapeutik. Pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi akan membuat orang tua lebih terbuka menerima informasi dan bersedia mengubah kebiasaan yang tidak tepat. Dengan demikian, edukasi yang dilakukan perawat tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku orang tua dalam merawat anak yang demam. (14)

5. Implikasi Pencegahan Kesalahan terhadap Keselamatan Anak

Pencegahan kesalahan dalam penanganan demam memiliki implikasi yang besar terhadap keselamatan anak. Dengan pemahaman yang benar dan dukungan edukatif dari perawat, orang tua diharapkan mampu melakukan perawatan demam secara aman, rasional, dan sesuai rekomendasi kesehatan. Hal ini akan mengurangi risiko efek samping obat, mencegah resistensi antibiotik, serta menurunkan kecemasan dan kepanikan yang tidak perlu.

Dengan demikian, perawat memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa penanganan demam di rumah dilakukan secara tepat. Edukasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti menjadi strategi utama dalam mencegah kesalahan umum dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan anak dengan demam akut. (11)

I. Kolaborasi Perawat dan Orang Tua dalam Perawatan Anak dengan Demam Akut

Kolaborasi antara perawat dan orang tua merupakan kunci utama dalam keberhasilan perawatan anak dengan demam akut. Anak, terutama pada usia bayi dan balita, sangat bergantung pada orang tua dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengambilan keputusan terkait kesehatan. Oleh karena itu, perawatan anak dengan demam tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa keterlibatan aktif orang tua sebagai mitra dalam proses asuhan keperawatan.

Pendekatan keperawatan anak yang menekankan asuhan berpusat pada keluarga (*family-centered care*) menempatkan orang tua sebagai bagian integral dari tim perawatan. Dalam pendekatan ini, perawat tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung orang tua agar mampu menjalankan perannya secara efektif dalam merawat anak (6).

1. Bentuk Kolaborasi Perawat dan Orang Tua

Kolaborasi perawat dan orang tua dalam perawatan anak dengan demam akut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui komunikasi

terbuka, keterlibatan orang tua dalam perencanaan perawatan, serta pengambilan keputusan bersama.

Perawat perlu melibatkan orang tua sejak tahap awal asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian kondisi anak. Informasi yang diberikan orang tua mengenai riwayat demam, respons anak terhadap obat, dan perubahan perilaku anak sangat penting dalam menentukan rencana perawatan. Dengan melibatkan orang tua secara aktif, perawat dapat memperoleh gambaran kondisi anak yang lebih komprehensif.

Dalam tahap perencanaan dan implementasi, perawat perlu menjelaskan tujuan perawatan dan pilihan tindakan yang tersedia dengan bahasa yang mudah dipahami. Orang tua diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta mengungkapkan kekhawatiran mereka. Pendekatan ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab orang tua terhadap perawatan anak. (17)

2. Peran Perawat dalam Membangun Hubungan Kolaboratif

Perawat memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan kolaboratif yang didasari oleh saling percaya dan saling menghargai. Sikap empatik, terbuka, dan tidak menghakimi sangat diperlukan agar orang tua merasa nyaman dan dihargai. Hubungan yang baik antara perawat dan orang tua akan memudahkan proses edukasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap rencana perawatan yang telah disepakati.

Perawat juga perlu menghargai pengalaman dan pengetahuan orang tua mengenai anaknya. Orang tua merupakan pihak yang paling mengenal kondisi dan kebiasaan anak sehari-hari. Dengan menghargai peran ini, perawat dapat memperkuat kemitraan dan menciptakan suasana perawatan yang lebih positif dan suportif(7)

3. Dampak Kolaborasi terhadap Keberhasilan Perawatan

Kolaborasi yang efektif antara perawat dan orang tua terbukti dapat meningkatkan keberhasilan perawatan anak dengan demam akut. Orang tua yang dilibatkan secara aktif cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi anak, lebih percaya diri dalam melakukan perawatan di rumah, serta lebih cepat mengenali tanda bahaya yang memerlukan pertolongan medis.

Selain itu, kolaborasi yang baik juga dapat mengurangi kecemasan orang tua dan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas asuhan keperawatan anak dan keselamatan pasien pediatrik (7)

J. Tantangan Perawat dalam Edukasi Orang Tua tentang Demam Akut

Meskipun edukasi orang tua merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan anak dengan demam akut, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan dengan mudah. Perawat sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas edukasi yang diberikan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami agar perawat dapat mengembangkan strategi yang tepat dan adaptif.

1. Perbedaan Tingkat Pendidikan Orang Tua

Perbedaan tingkat pendidikan dan latar belakang pengetahuan orang tua menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberian edukasi. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin mengalami kesulitan memahami informasi medis, sementara orang tua dengan pendidikan tinggi terkadang memiliki informasi yang berlebihan dari berbagai sumber yang belum tentu benar.

Perawat perlu menyesuaikan metode dan bahasa edukasi dengan kemampuan pemahaman orang tua. Penggunaan istilah sederhana, contoh konkret, dan demonstrasi langsung sangat membantu dalam mengatasi hambatan ini. Edukasi yang disampaikan secara bertahap dan diulang juga dapat meningkatkan pemahaman orang tua. (18)

2. Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional

Budaya dan kepercayaan tradisional masih memiliki pengaruh kuat dalam praktik perawatan anak di masyarakat. Beberapa orang tua masih mempercayai praktik tradisional tertentu dalam penanganan demam, seperti membungkus anak dengan selimut tebal atau menggunakan ramuan tertentu. Kepercayaan ini terkadang bertentangan dengan prinsip perawatan kesehatan yang aman.

Perawat perlu menyikapi kondisi ini dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya. Edukasi tidak boleh dilakukan dengan cara menghakimi atau menolak secara langsung kepercayaan orang tua, tetapi dengan memberikan penjelasan ilmiah yang logis dan mudah dipahami. Pendekatan yang menghargai budaya akan meningkatkan penerimaan orang tua terhadap edukasi yang diberikan (18)

3. Keterbatasan Waktu Pelayanan

Keterbatasan waktu pelayanan di fasilitas kesehatan sering menjadi kendala dalam pemberian edukasi yang optimal. Beban kerja perawat yang tinggi dapat membatasi waktu interaksi dengan orang tua, sehingga edukasi yang diberikan menjadi singkat dan kurang mendalam.

Untuk mengatasi tantangan ini, perawat dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan waktu yang tersedia, misalnya dengan menggunakan media

edukasi tertulis, leaflet, atau poster. Edukasi singkat namun fokus pada poin-poin penting juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam kondisi keterbatasan waktu.

4. Tuntutan Perawat untuk Kreatif dan Adaptif

Berbagai tantangan tersebut menuntut perawat untuk bersikap kreatif dan adaptif dalam menyampaikan edukasi. Perawat perlu mengembangkan kemampuan komunikasi, memahami karakteristik keluarga, serta memilih strategi edukasi yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan orang tua.

Dengan pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada keluarga, perawat dapat mengatasi berbagai hambatan dalam edukasi dan tetap menjalankan perannya secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan anak dengan demam akut dan memperkuat peran perawat sebagai edukator Kesehatan (13)

K. Simpulan

Demam akut merupakan salah satu kondisi yang paling sering dialami oleh anak dan menjadi penyebab utama orang tua mencari pelayanan kesehatan. Meskipun sebagian besar demam akut pada anak bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya, kondisi ini sering menimbulkan kecemasan yang tinggi pada orang tua akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme demam, cara penanganan yang tepat, serta potensi komplikasi yang mungkin terjadi. Ketidaktahuan dan miskonsepsi dalam penanganan demam dapat menyebabkan tindakan yang tidak rasional dan berisiko terhadap keselamatan anak.

Perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam asuhan anak dengan demam akut, tidak hanya sebagai pemberi asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai edukator, konselor, dan advokat bagi anak dan keluarga. Peran edukatif perawat menjadi kunci dalam membantu orang tua memahami bahwa demam merupakan respons fisiologis tubuh terhadap infeksi atau proses inflamasi, serta tidak selalu menandakan penyakit yang berbahaya. Edukasi yang tepat, berbasis bukti, dan disampaikan dengan pendekatan yang empatik dapat meningkatkan pengetahuan, mengurangi kecemasan, serta memberdayakan orang tua dalam merawat anak secara mandiri dan aman di rumah.

Melalui edukasi yang komprehensif, perawat dapat membimbing orang tua dalam melakukan penanganan demam di rumah, seperti pemberian cairan yang adekuat, pengaturan pakaian anak, penggunaan antipiretik secara rasional, serta penghindaran praktik yang tidak dianjurkan. Selain itu, perawat berperan penting dalam mencegah kesalahan umum dalam penanganan demam, termasuk overdosis obat antipiretik, penggunaan antibiotik tanpa resep, serta kepanikan berlebihan

terhadap kejang demam. Upaya ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan anak dan kualitas perawatan yang diberikan oleh keluarga.

Kolaborasi yang efektif antara perawat dan orang tua menjadi fondasi utama dalam keberhasilan perawatan anak dengan demam akut. Dengan melibatkan orang tua dalam setiap proses pengambilan keputusan, perawat dapat membangun hubungan saling percaya dan menciptakan asuhan keperawatan yang berpusat pada keluarga. Meskipun perawat menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan edukasi, seperti perbedaan tingkat pendidikan, pengaruh budaya, dan keterbatasan waktu pelayanan, pendekatan yang kreatif, adaptif, dan sensitif terhadap kebutuhan keluarga dapat meningkatkan efektivitas edukasi.

Secara keseluruhan, peran perawat dalam edukasi orang tua merupakan elemen penting dalam manajemen demam akut pada anak. Penguatan peran ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi orang tua dalam merawat anak yang demam, menurunkan angka kunjungan yang tidak perlu ke fasilitas kesehatan, serta mencegah komplikasi yang dapat membahayakan anak. Dengan demikian, perawat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan anak dan mendukung tercapainya derajat kesehatan anak yang optimal.

L. Referensi

Wilson HMJ. Wong;s Essentials Of Pediatric Nursing. Elsevier; 2019.

Wong D.L. Pediatric Nursing. Elsevier; 2021.

Kemnetrian Kesehatan Indonesia. Pedoman pelayanan Kesehatan anak. Jakarta: Kemekes RI; 2022.

Chiappini E. Management Of fever Of the ini children:summary of the italian pediatric Society Guideline. Clinical Therapeutic; 2017. 1–10 p.

Guyton A.C. TextbookOf medical Physiology. Elsevier; 2020.

kemetrian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Ajar Keperawatan Anak. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan; 2021.

IDAI. Panduan Penatalaksanaa Demam Dan Kejang Demam Pada Anak. Jakarta; 2020.

Sudibyo DG, Anindra RP, Gihart Y El, Alvin R, Kharisma N, Pratiwi SC, et al. Ibu, Pengetahuan Cara, D A N Demam, Penanganan. 2023;7(2):69–76.

Wilanda A. Demam, Penanganan Anak, Pada Studi, Tahun Sectional, Cross. 2025;6(2):372–9.

- Mira Arista. Asuhan Keperawatan Keluarga Tentang Edukasi Manajemen Demam Pada Ny . F Yang Memiliki Balita Dengan Masalah Keperawatan Defisit Pengetahuan Di Wilayah Puskesmas Kamonji Kota Palu Family Nursing Care On Fever Management Education For Mrs . F Who Has A Todd. 2024;7(12):5089–99.
- Damayanti I, Sari RS, Muthoharoh S. Gudang Jurnal Ilmu Kesehatan Asuhan Keperawatan Anak Kejang Demam Dengan Pemberian Edukasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua Dalam Penanganan Kejang Demam Berulang Di Ruangan Perawatan Anak RS An-Nisa Tangerang. 2024;2(2014):33–45.
- Supartini. Buku Ajar Konsep Keperawatan Anak. Jakarta: EGC; 2014.
- Nurfatul Jannah. Peran Perawat dalam Melaksanakan Konseling Kesehatan pada Masyarakat. 2025;4(03):188–92.
- Anisa. Intervensi Dukungan Emosional dan Konseling Perawat untuk Menurunkan Beban Psikologis Pasien Infertil yang Mengikuti Program Bayi Tabung. 2022;5(2019):1230–41.
- Hidayat. Pengantar Ilmu Keperawatan anak. Jakrata: Salemba Medika; 2017.
- Daniswara MA, Humaedi A, Lukitasari N, Farmasi P, Binawan U. Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Dalam Kelurahan Rangkapan Jaya Education On The Level Of Mothers Knowledge In Self- Medication For Handling Fever In Children In Rangkapan Jaya Village. 2024;7(2):208–15.
- Budi IS, Munzaemah S, Listyarini AD, Studi P, Keperawatan I. Hubungan pengetahuan ibu dengan penanganan kejang demam berulang di ruang anak rumah sakit islam sunan kudus. 2021;8(1):1–10.
- Nursalam. Konsep Dan Penerapan Keperawatan keluarga. Jakarta: Salemba Medika; 2020.

M. Glosarium

Advokasi Keperawatan

Tindakan perawat dalam melindungi kepentingan, hak, dan keselamatan pasien serta keluarga selama proses asuhan keperawatan.

Afebris

Kondisi ketika suhu tubuh berada dalam batas normal dan tidak mengalami demam.

Antibiotik

Obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan tidak dianjurkan untuk demam yang disebabkan oleh infeksi virus.

Antipiretik

Obat penurun panas yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh, seperti parasetamol dan ibuprofen.

Asuhan Keperawatan Anak

Pelayanan keperawatan profesional yang diberikan kepada anak sesuai tahap tumbuh kembang dan melibatkan keluarga dalam proses perawatan.

Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Nursing)

Asuhan keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan nilai keluarga dalam pengambilan keputusan keperawatan.

Asuhan Berpusat pada Keluarga (Family Centered Care)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan anak.

Cairan Adekuat

Kecukupan asupan cairan yang diperlukan anak untuk mencegah dehidrasi selama demam.

Dehidrasi

Kondisi kekurangan cairan tubuh yang dapat terjadi pada anak dengan demam akibat peningkatan penguapan dan penurunan asupan cairan.

Demam

Peningkatan suhu tubuh di atas nilai normal sebagai respons fisiologis tubuh terhadap infeksi atau inflamasi.

Demam Akut

Demam yang berlangsung kurang dari tujuh hari dan umumnya disebabkan oleh infeksi akut.

Edukasi Berkelanjutan

Proses pendidikan kesehatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua.

Edukator Kesehatan

Peran perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga.

Empati

Kemampuan perawat untuk memahami dan merasakan kondisi emosional orang tua tanpa menghakimi.

Etika Keperawatan

Prinsip moral yang menjadi pedoman perawat dalam memberikan asuhan keperawatan.

Fever Phobia

Kecemasan berlebihan orang tua terhadap demam pada anak yang sering kali tidak berdasarkan fakta medis.

Hipotalamus

Bagian otak yang berfungsi mengatur suhu tubuh.

Hospitalisasi Anak

Proses perawatan anak di rumah sakit yang dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada anak dan orang tua.

Keamanan Pasien (Patient Safety)

Upaya pencegahan kesalahan dan cedera pada pasien selama perawatan.

Kejang Demam

Kejang yang terjadi bersamaan dengan demam pada anak usia 6 bulan–5 tahun tanpa gangguan saraf pusat.

Kepatuhan Orang Tua

Kesesuaian tindakan orang tua terhadap anjuran dan rencana perawatan yang diberikan tenaga kesehatan.

Konselor Keperawatan

Peran perawat dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada pasien dan keluarga.

Komunikasi Terapeutik

Komunikasi yang dilakukan perawat secara sadar dan terarah untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi masalah kesehatan.

Komplikasi

Kondisi tambahan yang dapat memperberat penyakit utama.

Manajemen Demam

Upaya sistematis untuk mengatasi demam melalui tindakan nonfarmakologis dan farmakologis.

Miskonsepsi

Pemahaman yang keliru mengenai kondisi kesehatan, termasuk anggapan bahwa semua demam berbahaya.

Monitoring Suhu Tubuh

Pemantauan suhu tubuh anak secara berkala untuk menilai perkembangan kondisi demam.

Nonfarmakologis

Tindakan penanganan tanpa obat, seperti pemberian cairan dan pengaturan pakaian.

Overdosis Obat

Pemberian obat melebihi dosis yang dianjurkan.

Pendidikan Kesehatan

Upaya terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat.

Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik.

Pengambilan Keputusan Bersama

Proses kolaboratif antara perawat dan keluarga dalam menentukan rencana perawatan.

Peran Perawat

Tanggung jawab profesional perawat sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, dan advokat.

Persepsi Orang Tua

Cara pandang orang tua dalam menilai kondisi demam pada anak.

Pirogen

Zat penyebab peningkatan suhu tubuh.

Praktik Tidak Rasional

Tindakan penanganan demam yang tidak sesuai dengan rekomendasi medis.

Promosi Kesehatan

Upaya meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dalam menjaga kesehatan.

Resistensi Antibiotik

Kondisi bakteri yang kebal terhadap antibiotik akibat penggunaan tidak tepat.

Self-Limiting Disease

Penyakit yang dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus.

Stres Orang Tua

Respon emosional orang tua akibat kondisi sakit pada anak.

Suhu Tubuh Normal

Rentang suhu tubuh normal anak, umumnya 36,5–37,5°C.

Tanda Bahaya Demam

Gejala yang menandakan kondisi serius dan memerlukan penanganan medis segera.

Terapi Farmakologis

Penanganan demam menggunakan obat-obatan.

Tumbuh Kembang Anak

Proses perubahan fisik, mental, dan sosial anak sesuai usia.

CHAPTER 8

CARA MEMBUAT RENCANA ASUHAN YANG SEDERHANA BERDASARKAN CONTOH KASUS

Dr. Ns. Tutik Rahayu, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan / Prolog

Kanker serviks merupakan salah satu keganasan pada sistem reproduksi perempuan yang masih menjadi masalah kesehatan global, khususnya di negara berkembang (Membrilla-Beltran et al., 2023). Upaya pencegahan melalui skrining dan vaksinasi human papillomavirus (HPV) terus ditingkatkan (Chew et al., 2021) sebagian besar kasus kanker serviks masih terdiagnosis pada stadium lanjut sehingga memerlukan terapi komprehensif, termasuk kemoterapi (Neu et al., 2025). Terapi kemoterapi berperan penting dalam pengendalian penyakit, baik sebagai terapi utama maupun sebagai terapi adjuvan, namun sering kali menimbulkan berbagai efek samping yang berdampak signifikan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien (Di et al., 2024).

Efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks meliputi mual dan muntah, kelelahan, nyeri, gangguan nutrisi, penurunan imunitas, serta perubahan citra tubuh (Trawińska et al., 2025). Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas hidup pasien, tetapi juga berdampak pada peran dan fungsi perempuan dalam keluarga dan Masyarakat (Membrilla-Beltran et al., 2023). Dalam perspektif keperawatan maternitas, pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi sering menghadapi konflik peran, kecemasan terhadap kesehatan reproduksi, serta ketidakpastian masa depan yang berpotensi meningkatkan beban psikologis selama proses pengobatan (Chen et al., 2024).

Perawat memiliki peran strategis dalam mendampingi pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi, mulai dari pengkajian kondisi pasien secara komprehensif, pengelolaan efek samping terapi, hingga pemberian edukasi dan dukungan psikososial (Liebermann et al., 2023). Asuhan keperawatan yang diberikan secara sistematis dan berkesinambungan terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mengurangi intensitas gejala, serta meningkatkan kualitas hidup pasien kanker serviks (Li et al., 2023). Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan menyusun rencana asuhan keperawatan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kondisi klinis pasien.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang terencana dengan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Hasil tinjauan sistematis dan meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa asuhan keperawatan yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki respons adaptasi pasien terhadap kemoterapi, serta menurunkan keluhan efek samping seperti kelelahan dan mual muntah. Temuan ini menegaskan pentingnya peran perawat dalam memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan asuhan yang holistik dan berfokus pada kebutuhan individu (Ant, 2024).

Dalam praktik klinik, kompleksitas kondisi pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi sering menjadi tantangan tersendiri bagi perawat, terutama dalam menyusun rencana asuhan keperawatan yang efektif dan efisien (Nashwan & Hani, 2023). Rencana asuhan keperawatan yang terlalu kompleks dapat menyulitkan implementasi di lapangan, sementara rencana yang terlalu sederhana berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan pasien secara menyeluruh (Othman, 2021). Oleh karena itu, diperlukan panduan praktis penyusunan rencana asuhan keperawatan yang sederhana, sistematis, dan berbasis standar keperawatan, sehingga mudah diterapkan tanpa mengabaikan prinsip asuhan keperawatan yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan bab ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam menyusun rencana asuhan keperawatan sederhana pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi dalam perspektif keperawatan maternitas. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu perawat, khususnya perawat maternitas, dalam memberikan asuhan yang terarah, bermakna, dan berpusat pada pasien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan pada pasien kanker serviks.

B. Konsep Rencana Asuhan Keperawatan Sederhana

Dalam praktik klinik, kompleksitas kondisi pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi sering menjadi tantangan tersendiri bagi perawat, khususnya dalam menyusun rencana asuhan keperawatan yang efektif dan efisien. Rencana asuhan keperawatan yang terlalu kompleks berpotensi menyulitkan implementasi di lapangan, sementara rencana yang terlalu sederhana berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan pasien secara menyeluruh. Beberapa studi menunjukkan bahwa perawat membutuhkan panduan yang sistematis dan terstandar agar proses keperawatan dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengurangi kualitas asuhan (Yuwanto & Astutik, 2024). Penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) terbukti membantu perawat dalam menyusun rencana

asuhan keperawatan yang lebih terarah, praktis, dan mudah diaplikasikan dalam praktik klinik sehari-hari, termasuk pada pasien kanker yang menjalani terapi kompleks seperti kemoterapi (Sdki et al., 2023).

Konsep rencana asuhan keperawatan sederhana menekankan pada penyusunan rencana keperawatan yang fokus, realistis, dan mudah diaplikasikan di lapangan tanpa mengurangi prinsip asuhan keperawatan yang komprehensif. Rencana asuhan keperawatan sederhana tidak berarti mengabaikan kompleksitas masalah pasien, tetapi lebih menekankan pada kemampuan perawat dalam menentukan prioritas masalah dan memilih intervensi yang paling relevan serta berdampak langsung terhadap kondisi pasien. Pendekatan ini menjadi penting terutama pada pasien dengan kondisi kronis dan kompleks, seperti pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi.

Pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi sering mengalami berbagai masalah keperawatan secara simultan, baik fisik maupun psikologis, sehingga berpotensi menimbulkan beban perawatan yang tinggi. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu menyusun rencana asuhan keperawatan yang terfokus pada masalah utama yang paling memengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup pasien. Rencana asuhan keperawatan yang sederhana membantu perawat dalam mengelola waktu, sumber daya, dan energi secara lebih efektif, khususnya di lingkungan pelayanan kesehatan dengan keterbatasan tenaga dan beban kerja yang tinggi (Young et al., 2025).

Dalam konteks keperawatan maternitas, rencana asuhan keperawatan sederhana pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi perlu mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan peran reproduktif Perempuan (Dhakil et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip asuhan keperawatan holistik yang memandang pasien sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai penderita penyakit. Rencana asuhan keperawatan yang disusun harus mampu mengakomodasi kebutuhan pasien terkait manajemen efek samping kemoterapi, dukungan emosional, edukasi kesehatan, serta pelibatan keluarga dalam proses perawatan (Retnaningsih et al., 2026).

Secara operasional, penyusunan rencana asuhan keperawatan sederhana tetap mengacu pada standar keperawatan yang berlaku, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Penggunaan standar ini membantu perawat dalam menyusun rencana asuhan yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Namun demikian, dalam penerapannya, perawat perlu menyesuaikan isi rencana asuhan dengan kondisi klinis pasien, fase kemoterapi yang sedang dijalani, serta respons individu terhadap terapi.

Prinsip utama dalam rencana asuhan keperawatan sederhana meliputi fokus pada masalah prioritas, tujuan yang realistis dan terukur, serta intervensi yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Fokus pada masalah prioritas berarti perawat tidak menyusun terlalu banyak diagnosis keperawatan dalam satu waktu, melainkan memilih masalah yang paling membutuhkan penanganan segera. Tujuan keperawatan ditetapkan secara spesifik dan realistis agar mudah dievaluasi, sedangkan intervensi keperawatan dipilih berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman klinis perawat.

Dengan demikian, konsep rencana asuhan keperawatan sederhana merupakan pendekatan yang relevan dan aplikatif dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu perawat, khususnya perawat maternitas, dalam memberikan asuhan yang efektif, efisien, dan berpusat pada pasien, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

C. Karakteristik Pasien Kanker Serviks yang Menjalani Kemoterapi

Pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi umumnya memperlihatkan pola karakteristik klinis dan psikososial tertentu yang muncul akibat keterkaitan antara proses penyakit, efek terapi sitotoksik, serta kondisi individual pasien. Kemoterapi dirancang untuk menekan pertumbuhan sel kanker, namun sifatnya yang tidak selektif menyebabkan sel-sel normal dengan laju pembelahan tinggi turut terdampak. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai keluhan fisik, antara lain kelelahan, nyeri, mual, serta penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup pasien (Fang et al., 2024). Selain perubahan fisik, pasien juga berisiko mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan penurunan rasa percaya diri selama menjalani pengobatan. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisik dan psikososial tersebut saling berhubungan dan berkontribusi terhadap meningkatnya beban perawatan pada pasien kanker serviks. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap karakteristik klinis dan psikososial pasien menjadi dasar penting bagi perawat dalam merancang rencana asuhan keperawatan yang terarah, adaptif terhadap kebutuhan pasien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup selama kemoterapi (Tong et al., 2021).

1. Efek Samping Kemoterapi

Kemoterapi pada pasien kanker serviks sering menimbulkan efek samping yang bervariasi, baik akut maupun kronis. Efek samping yang paling sering dilaporkan meliputi mual dan muntah, kelelahan, nyeri, anoreksia, rambut rontok, gangguan mukosa mulut, serta penurunan jumlah sel darah yang meningkatkan

risiko infeksi dan perdarahan. Tingkat keparahan efek samping ini dipengaruhi oleh jenis obat kemoterapi, dosis, frekuensi pemberian, serta kondisi fisik dan psikologis pasien. Kelelahan terkait kanker (*cancer-related fatigue*) merupakan salah satu keluhan yang paling sering dan paling mengganggu aktivitas sehari-hari pasien. Kelelahan ini tidak selalu membaik dengan istirahat dan dapat berlangsung lama bahkan setelah siklus kemoterapi selesai. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan pasien dalam menjalankan peran sehari-hari, termasuk peran sebagai ibu, istri, maupun anggota keluarga (Zhao et al., 2025).

2. Masalah Keperawatan yang Sering Muncul

Berbagai efek samping kemoterapi berkontribusi terhadap munculnya masalah keperawatan yang kompleks dan saling berkaitan. Masalah keperawatan yang sering dijumpai pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi antara lain nyeri, kelelahan, gangguan nutrisi, ansietas, gangguan pola tidur, serta ketidaknyamanan fisik dan psikologis. Selain itu, risiko infeksi akibat penurunan imunitas menjadi perhatian utama dalam asuhan keperawatan pasien kemoterapi (Zhang et al., 2024). Masalah keperawatan tersebut memerlukan pendekatan prioritas dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan. Perawat perlu mengidentifikasi masalah yang paling berdampak terhadap keselamatan dan kualitas hidup pasien, kemudian menyusun intervensi yang terfokus dan realistis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip rencana asuhan keperawatan sederhana yang menekankan efektivitas dan kemudahan implementasi di praktik klinik.

3. Dampak terhadap Fungsi Reproduksi dan Peran Maternitas

Dalam perspektif keperawatan maternitas, pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi menghadapi tantangan yang signifikan terkait fungsi reproduksi dan peran maternitasnya. Kemoterapi diketahui memiliki efek gonadotoksik yang dapat memengaruhi fungsi ovarium, menyebabkan gangguan siklus menstruasi, menopause dini, serta penurunan fertilitas, khususnya pada perempuan usia reproduktif. Kondisi ini sering menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan memiliki keturunan di masa depan dan berdampak pada kesejahteraan psikologis pasien. Selain aspek biologis, perubahan fisik dan psikologis akibat kemoterapi, seperti kelelahan berkepanjangan, nyeri, serta gangguan emosional, turut memengaruhi kemampuan pasien dalam menjalankan peran sebagai ibu, pasangan, dan anggota keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan fungsi reproduksi, fungsi seksual, serta penurunan kualitas hidup merupakan konsekuensi yang sering dialami pasien kanker serviks setelah menjalani terapi kanker (Membrilla-Beltran et al., 2023). Oleh karena itu, asuhan keperawatan

perlu dirancang secara holistik dengan mempertimbangkan dukungan terhadap peran maternitas pasien melalui edukasi kesehatan reproduksi, dukungan emosional, serta pelibatan keluarga dalam proses perawatan, guna membantu pasien beradaptasi dan mempertahankan kualitas hidup selama dan setelah kemoterapi

4. Respons Psikologis dan Spiritual Pasien

Diagnosis kanker serviks dan proses kemoterapi sering menimbulkan respons psikologis yang beragam, seperti kecemasan, ketakutan, depresi, dan perasaan tidak berdaya. Ketidakpastian terhadap hasil pengobatan, perubahan citra tubuh, serta kekhawatiran terhadap peran sosial dan keluarga menjadi sumber stres yang signifikan bagi pasien. Studi menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dan depresi pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi cenderung lebih meningkat. Selain respons psikologis, aspek spiritual juga memainkan peran penting dalam proses adaptasi pasien terhadap penyakit dan pengobatan. Banyak pasien memanfaatkan nilai-nilai spiritual dan religius sebagai mekanisme koping untuk menghadapi penderitaan, meningkatkan harapan, dan menemukan makna dalam pengalaman sakit. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan spiritual sesuai dengan nilai dan keyakinan pasien, sebagai bagian dari asuhan keperawatan holistik (Toledo et al., 2021).

D. Langkah Praktis Penyusunan Rencana Asuhan Keperawatan

Penyusunan rencana asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi memerlukan pendekatan yang sistematis, terfokus, dan aplikatif. Rencana asuhan keperawatan yang sederhana tidak berarti mengurangi kualitas asuhan, melainkan menekankan pada pemilihan masalah prioritas, luaran yang realistis, serta intervensi yang relevan dengan kondisi pasien. Pendekatan ini penting mengingat pasien kemoterapi sering mengalami berbagai masalah secara simultan, baik fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga perawat perlu mengelola asuhan secara efektif dan efisien (Toledo et al., 2021).

1. Pengkajian Keperawatan Fokus

Pengkajian keperawatan merupakan langkah awal yang menentukan kualitas rencana asuhan keperawatan. Pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi, pengkajian perlu difokuskan pada efek samping terapi serta dampaknya terhadap fungsi fisik, psikologis, dan peran maternitas pasien.

Data subjektif meliputi keluhan yang dirasakan pasien seperti nyeri, mual, kelelahan, gangguan tidur, kecemasan, serta perubahan persepsi terhadap tubuh dan peran dirinya. Sementara itu, data objektif mencakup hasil pemeriksaan fisik,

tanda-tanda vital, status nutrisi, kondisi kulit dan mukosa, serta hasil pemeriksaan penunjang seperti kadar hemoglobin atau leukosit yang berkaitan dengan efek kemoterapi.

Aspek maternitas juga menjadi bagian penting dalam pengkajian, khususnya pada pasien usia reproduktif. Perawat perlu mengkaji dampak kemoterapi terhadap fungsi reproduksi, peran sebagai ibu atau istri, serta dukungan keluarga yang tersedia. Pengkajian yang komprehensif dan terfokus ini menjadi dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan yang tepat.

2. Penetapan Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan sesuai dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi, beberapa diagnosis keperawatan yang sering muncul antara lain nyeri, kelelahan, ansietas, ketidaknyamanan, dan gangguan citra tubuh (Yuwanto & Prasetyo, 2023)

Diagnosis nyeri sering berkaitan dengan proses penyakit maupun efek samping kemoterapi. Kelelahan muncul sebagai respons terhadap terapi kanker yang berkepanjangan dan dapat memengaruhi kemampuan pasien menjalankan aktivitas sehari-hari. Ansietas sering dialami pasien akibat ketidakpastian pengobatan dan perubahan kondisi tubuh. Ketidaknyamanan dan gangguan citra tubuh juga umum terjadi seiring perubahan fisik seperti rambut rontok atau penurunan berat badan. Penetapan diagnosis keperawatan yang tepat dan prioritas akan memudahkan perawat dalam menyusun luaran dan intervensi yang terarah.

3. Penetapan Luaran Keperawatan (SLKI)

Luaran keperawatan ditetapkan berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan dan mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Luaran harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan kondisi pasien yang sedang menjalani kemoterapi.

Sebagai contoh, pada diagnosis nyeri, luaran keperawatan dapat berupa penurunan intensitas nyeri hingga tingkat ringan, meningkatnya kenyamanan pasien, dan kemampuan pasien mengontrol nyeri. Pada diagnosis kelelahan, luaran dapat mencakup peningkatan tingkat energi dan kemampuan pasien melakukan aktivitas ringan secara mandiri. Luaran yang realistis akan memudahkan evaluasi dan meningkatkan keberhasilan asuhan keperawatan.

4. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan luaran yang ingin dicapai dan mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Intervensi pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi meliputi manajemen nyeri,

edukasi kemoterapi, dukungan psikososial, intervensi nonfarmakologi, serta pelibatan keluarga dalam proses perawatan.

Manajemen nyeri dapat dilakukan melalui pemberian terapi farmakologis sesuai kolaborasi medis dan intervensi nonfarmakologis seperti teknik relaksasi dan distraksi. Edukasi kemoterapi bertujuan meningkatkan pemahaman pasien tentang efek samping terapi dan cara mengelolanya secara mandiri. Dukungan psikososial diberikan untuk membantu pasien menghadapi kecemasan dan perubahan peran. Pelibatan keluarga penting untuk memperkuat dukungan emosional dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan.

5. Implementasi dan Evaluasi

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan intervensi keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Perawat perlu memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kondisi pasien. Selama implementasi, perawat juga melakukan observasi terhadap respons pasien terhadap intervensi yang diberikan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian luaran keperawatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi berbasis respons pasien memungkinkan perawat untuk menentukan apakah rencana asuhan keperawatan perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau dihentikan. Pendekatan evaluasi yang berkelanjutan ini membantu memastikan bahwa asuhan keperawatan tetap berfokus pada kebutuhan pasien dan mendukung peningkatan kualitas hidup pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi.

E. Contoh kasus klinis dan rencana asuhan keperawatan

1. Deskripsi Kasus Klinis

Seorang perempuan berusia 42 tahun, menikah, memiliki dua orang anak, datang ke ruang rawat onkologi untuk menjalani siklus kemoterapi keempat akibat kanker serviks stadium IIB. Pasien sebelumnya telah menjalani radioterapi dan saat ini menjalani kemoterapi lanjutan sesuai program medis. Pasien mengeluhkan nyeri di daerah panggul, mudah lelah, serta merasa cemas menjelang dan selama proses kemoterapi. Pasien juga menyampaikan kekhawatiran terkait perannya sebagai ibu, terutama keterbatasan dalam merawat anak selama menjalani pengobatan.

Secara fisik, pasien tampak lemah, ekspresi wajah menunjukkan ketidaknyamanan, dan aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Pasien juga mengungkapkan perasaan tidak percaya diri akibat perubahan fisik yang dialaminya selama kemoterapi, seperti rambut rontok dan penurunan berat badan. Kondisi tersebut berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial pasien,

sehingga memerlukan rencana asuhan keperawatan yang terfokus, sistematis, dan mudah diaplikasikan.

2. Pengkajian Keperawatan

Data Subjektif

- a. Mengeluh nyeri panggul dengan skala 6 dari 10
- b. Merasa cepat lelah meskipun aktivitas ringan
- c. Mengatakan sering merasa cemas dan khawatir terhadap kelanjutan pengobatan
- d. Mengungkapkan perasaan sedih dan kurang percaya diri akibat perubahan fisik
- e. Khawatir tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu secara optimal

Data Objektif

- a. Tampak lemah dan meringis saat bergerak
- b. Aktivitas terbatas
- c. Ekspresi wajah tampak gelisah
- d. Menarik diri dari interaksi sosial

3. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Berdasarkan hasil pengkajian, diagnosis keperawatan yang ditetapkan adalah:

- a. Nyeri Akut berhubungan dengan proses penyakit dan efek kemoterapi
- b. Kelelahan berhubungan dengan efek samping kemoterapi
- c. Ansietas berhubungan dengan ketidakpastian proses pengobatan dan perubahan peran
- d. Gangguan Citra Tubuh berhubungan dengan perubahan fisik akibat kemoterapi

Diagnosis tersebut dipilih sebagai prioritas karena paling memengaruhi kenyamanan, kemampuan beraktivitas, serta kualitas hidup pasien selama menjalani kemoterapi

4. Luaran Keperawatan (SLKI)

Luaran keperawatan yang diharapkan meliputi:

- a. Status Nyeri membaik, ditandai dengan penurunan intensitas nyeri dan peningkatan kenyamanan
- b. Tingkat Kelelahan menurun, pasien mampu melakukan aktivitas sesuai toleransi
- c. Tingkat Ansietas menurun, pasien tampak lebih tenang dan mampu mengekspresikan perasaan
- d. Citra Tubuh meningkat, pasien menunjukkan penerimaan terhadap perubahan fisik

Luaran ditetapkan secara realistis sesuai kondisi pasien kemoterapi dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup

5. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Manajemen Nyeri

- a. Mengkaji nyeri secara komprehensif
- b. Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan distraksi
- c. Memberikan dukungan emosional
- d. Kolaborasi pemberian analgesik sesuai program medis

Manajemen Energi

- a. Mengatur keseimbangan aktivitas dan istirahat
- b. Mengajarkan aktivitas ringan bertahap
- c. Edukasi konservasi energi
- d. Melibatkan keluarga dalam membantu aktivitas pasien

Manajemen Ansietas

- a. Melakukan komunikasi terapeutik
- b. Memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang tindakan keperawatan
- c. Memfasilitasi dukungan spiritual sesuai keyakinan pasien
- d. Melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung

Peningkatan Citra Tubuh

- a. Memfasilitasi ekspresi perasaan terkait perubahan fisik
- b. Memberikan dukungan psikososial
- c. Memperkuat peran pasien sebagai ibu dan anggota keluarga
- d. Mendorong adaptasi positif terhadap perubahan tubuh

6. Implementasi Keperawatan

Intervensi keperawatan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dalam perawatan harian pasien. Perawat melakukan pengkajian nyeri secara rutin, membimbing pasien melakukan teknik relaksasi, serta memberikan edukasi terkait pengelolaan kelelahan. Dukungan emosional diberikan melalui komunikasi terapeutik, dengan melibatkan keluarga dalam proses perawatan untuk memperkuat peran maternitas pasien. Intervensi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis pasien selama menjalani kemoterapi

7. Evaluasi Keperawatan

Hasil evaluasi menunjukkan:

- a. Nyeri pasien menurun menjadi skala 3 dari 10
- b. Pasien mampu melakukan aktivitas ringan dengan periode istirahat yang cukup
- c. Tingkat kecemasan berkurang dan pasien tampak lebih tenang

d. Pasien mulai menunjukkan penerimaan terhadap perubahan fisik dan lebih terbuka dalam berinteraksi

Luaran keperawatan tercapai secara bertahap dan menunjukkan bahwa rencana asuhan keperawatan sederhana yang disusun bersifat efektif dan aplikatif

8. Refleksi Kasus

Kasus ini menggambarkan bahwa penyusunan rencana asuhan keperawatan yang sederhana, terfokus, dan berbasis SDKI–SLKI–SIKI mampu menjawab kebutuhan pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi secara holistik. Pendekatan keperawatan maternitas yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan peran ibu menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses pengobatan (Yuwanto & Prasetyo, 2023)

F. Peran Perawat Maternitas pada Pasien Kanker Serviks yang Menjalani Kemoterapi

Pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi mengalami perubahan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang kompleks sebagai dampak dari penyakit dan terapi sitotoksik yang dijalani. Dalam konteks keperawatan maternitas, kondisi ini menuntut perawat untuk memberikan asuhan yang tidak hanya berfokus pada penanganan klinis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan holistik pasien sebagai perempuan dan ibu. Perawat berperan sebagai *care provider* dengan melakukan pengkajian komprehensif, pemantauan respon pasien terhadap kemoterapi, serta pemberian intervensi keperawatan yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien selama proses pengobatan (Lyu et al., 2024).

Selain sebagai pemberi asuhan, perawat maternitas memiliki peran penting sebagai edukator dalam memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami terkait kemoterapi, efek samping yang mungkin muncul, serta strategi perawatan mandiri yang dapat dilakukan pasien dan keluarga di rumah. Edukasi yang efektif membantu pasien meningkatkan pemahaman terhadap kondisi kesehatannya, memperkuat kemampuan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan yang dijalani. Peran edukatif ini menjadi sangat krusial mengingat pasien kanker serviks sering menghadapi ketidakpastian selama proses terapi.

Perawat juga berperan sebagai konselor yang memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi pasien yang mengalami kecemasan, ketakutan, maupun perubahan citra diri selama kemoterapi. Pendekatan komunikasi terapeutik memungkinkan perawat membantu pasien mengekspresikan perasaan, mengembangkan mekanisme koping adaptif, serta mempertahankan harga diri sebagai perempuan dan ibu. Studi menunjukkan bahwa dukungan emosional yang

diberikan perawat berkontribusi signifikan terhadap penurunan distress psikologis dan peningkatan kesejahteraan pasien kanker (Lyu et al., 2024)

Sebagai advokat, perawat maternitas berperan dalam membantu pasien menyuatkan kebutuhan dan preferensi mereka selama menjalani perawatan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pengobatan dan perawatan lanjutan. Peran advokasi ini mencakup perlindungan hak pasien, fasilitasi komunikasi antara pasien dengan tim kesehatan, serta dukungan terhadap kemampuan pasien untuk melakukan *self-advocacy* sesuai dengan nilai dan kondisi individu (Wesmiller, 2022). Melalui peran ini, perawat berkontribusi dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien.

Selain itu, perawat maternitas berfungsi sebagai pendamping keluarga dengan melibatkan anggota keluarga dalam proses perawatan pasien. Dukungan keluarga terbukti berperan penting dalam membantu pasien menghadapi beban fisik dan psikologis selama kemoterapi. Perawat memfasilitasi keterlibatan keluarga melalui edukasi, dukungan emosional, serta pemberdayaan keluarga sebagai sistem pendukung utama pasien. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keperawatan holistik yang memandang pasien dan keluarga sebagai satu kesatuan dalam proses asuhan keperawatan (Azcárate-cenoz et al., 2025).

G. Simpulan

Penyusunan rencana asuhan keperawatan sederhana pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi terbukti efektif dan feasible untuk diterapkan dalam praktik keperawatan, khususnya pada layanan maternitas. Asuhan keperawatan sederhana yang disusun secara sistematis berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) mampu membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah keperawatan utama, menetapkan tujuan yang terukur, serta melaksanakan intervensi yang terarah dan realistis sesuai kondisi pasien.

Pendekatan sederhana namun terstruktur ini sangat relevan bagi pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi, mengingat kompleksitas dampak terapi terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, dan peran maternitas. Asuhan keperawatan yang ringkas dan aplikatif memudahkan perawat dalam memberikan asuhan berkelanjutan, meningkatkan konsistensi praktik klinik, serta mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan pada jenjang D3, S1, maupun profesi.

Selain itu, perawat maternitas memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan holistik kepada pasien kanker serviks. Peran sebagai care provider, edukator, konselor, advokat, dan pendamping keluarga memungkinkan perawat untuk tidak

hanya berfokus pada manajemen gejala kemoterapi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan psikososial, spiritual, serta dukungan terhadap peran reproduksi dan maternitas pasien. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keperawatan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat asuhan (patient- and family-centered care).

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut:

1. Penguatan Praktik Keperawatan

Fasilitas pelayanan kesehatan disarankan untuk mendorong penggunaan ASKEP sederhana berbasis SDKI–SLKI–SIKI sebagai standar praktik, khususnya pada perawatan pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi, guna meningkatkan mutu dan kontinuitas asuhan keperawatan

2. Pengembangan Pendidikan Keperawatan

Institusi Pendidikan keperawatan perlu mengintegrasikan contoh ASKEP sederhana dan aplikatif ke dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk studi kasus, modul praktik klinik, maupun pembelajaran berbasis masalah, agar mahasiswa lebih siap menghadapi kondisi nyata di lapangan.

3. Peningkatan Kompetensi Perawat Maternitas

Perawat maternitas dianjurkan untuk terus meningkatkan kompetensi klinik dan komunikasi terapeutik melalui pelatihan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan efek samping kemoterapi, dukungan psikososial, dan pelibatan keluarga dalam perawatan pasien kanker serviks.

4. Penguatan Kolaborasi dan Dukungan Keluarga

Praktik keperawatan perlu lebih menekankan kolaborasi interprofesional serta pelibatan keluarga sebagai mitra dalam perawatan, mengingat peran keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan adaptasi pasien selama menjalani kemoterapi.

5. Pengembangan Penelitian Keperawatan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan ASKEP sederhana terhadap luaran klinis dan kualitas hidup pasien kanker serviks, sehingga dapat memperkuat bukti ilmiah dalam praktik keperawatan maternitas berbasis evidence.

H. Referensi

- Ant, A. (2024). *The Role of Nursing in the Management of Chemotherapy Extravasation : A Systematic Review Regarding Public Health*. 1–19.
- Azcárate-cenoz, N., Alfaro-díaz, C., Naef, R., & Verweij, L. (2025). *A Nurse- - Led Family Support Intervention for Families Living With Cancer : An Experience- - Based Co- - Design Study*. 1–19. <https://doi.org/10.1111/jan.70073>
- Chen, H., Zhou, L., Fong, D., Cun, Y., Yang, Z., & Wan, C. (2024). Quality of life and its related-influencing factors in patients with cervical cancer based on the scale QLICP-CE(V2.0). *BMC Women's Health*, 24(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03068-1>
- Chew, K. T., Kampan, N., & Shafiee, M. N. (2021). Perception and knowledge of human papillomavirus (HPV) vaccine for cervical cancer prevention among fully vaccinated female university students in the era of HPV vaccination: A cross-sectional study. *BMJ Open*, 11(12), 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047479>
- Dhakal, K., Chen, C., Wang, P., Mboineki, J. F., & Adhikari, B. (2024). Existing psychological supportive care interventions for cervical cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 24(1), 1–24. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18634-3>
- Di, X., Gao, Z., Yu, H., Liu, X., Zhao, J., Wang, J., & Zhang, H. (2024). 125I seed brachytherapy for non-central pelvic recurrence of cervical cancer after external beam radiotherapy. *Radiation Oncology* , 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s13014-024-02454-1>
- Fang, H., Tan, Y., Sun, Y., & Wang, W. (2024). Effectiveness of nursing care for cervical cancer patients undergoing chemotherapy: Systematic review and meta-analysis. *African Journal of Reproductive Health*, 28(12), 46–51. <https://doi.org/10.29063/ajrh2024/v28i12.5>
- Li, Z., Chen, S., Mahjabeen, I., & Shafique, R. (2023). *Nurses and doctors 's awareness and knowledge towards treatment and care of cervical cancer patients: a cross-sectional study*. 1–10.
- Liebermann, E., Sego, R., Vieira, D., Cheng, Q., Xu, B., Arome, M., Azevedo, A., Ginsburg, O., & So, W. K. W. (2023). Asia-Paci f i c Journal of Oncology Nursing Roles and activities of nurses in cancer prevention and early detection in low- and middle-income countries: A scoping review. *Asia-Pacific Journal of*

- Oncology Nursing*, 10(7), 100242. <https://doi.org/10.1016/j.apjon.2023.100242>
- Lyu, X. C., Jiang, H. J., Lee, L. H., Yang, C. I., & Sun, X. Y. (2024). Oncology nurses' experiences of providing emotional support for cancer patients: a qualitative study. *BMC Nursing*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01718-1>
- Membrilla-Beltran, L., Cardona, D., Camara-Roca, L., Aparicio-Mota, A., Roman, P., & Rueda-Ruzafa, L. (2023). Impact of Cervical Cancer on Quality of Life and Sexuality in Female Survivors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph20043751>
- Nashwan, A. J., & Hani, S. B. (2023). Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 10(9), 100277. <https://doi.org/10.1016/j.apjon.2023.100277>
- Neu, M., Wöhrle, C. M., Walter, R., Balagiannis, N., Poettgen, C., Käsmann, L., Stuschke, M., Dannecker, C., Stüben, G., & Kahl, K. H. (2025). Multimodal chemoradiotherapy including interstitial brachytherapy enhances outcomes in FIGO stage IVA cervical cancer: a focus on tumor control and quality of life. *Strahlentherapie Und Onkologie*, 1018–1030. <https://doi.org/10.1007/s00066-025-02407-x>
- Othman, E. H. (2021). *Nursing diagnoses among oncology patients in medical units: a retrospective study of patients' records*. 1–9.
- Retnaningsih, D., Nihayati, H. E., & Efendi, F. (2026). *The Role of Family Resilience and Social Support among Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Systematic Review*. 17(January), 270–280. <https://doi.org/10.31674/mjn.2026.v17i03.026>
- Sdkı, S. P., Keperawatan, A., İi, T., Tunny, H., & Wabula, L. R. (2023). *Latumeten Ambon*. 3(2), 433–438.
- Toledo, G., Ochoa, C. Y., & Farias, A. J. (2021). Religion and spirituality: their role in the psychosocial adjustment to breast cancer and subsequent symptom management of adjuvant endocrine therapy. *Supportive Care in Cancer*, 29(6), 3017–3024. <https://doi.org/10.1007/s00520-020-05722-4>
- Tong, L., He, M., Zou, Y., & Li, Z. (2021). Effects of bundled nursing combined with peer support on psychological state and self-efficacy of patients with cervical cancer undergoing chemotherapy. *American Journal of Translational Research*, 13(9), 10649–10655.

- Trawińska, J., Skręt-magierło, J. E., Czetyrbok, E., Bielatowicz, J., Szczepańska, A., Rybicka, A., Kowalski, S., Myszka, A., Skręt, A., Barnaś, E., Gawlik, M., & Gawlik, B. (2025). *Quality of life in patients with cervical cancer and endometrial cancer during adjuvant treatment — similarities and differences useful in personalized care*. <https://doi.org/10.22514/ejgo.2025.007>
- Wesmler, S. W. (2022). *Oncology Nurses' Role in Promoting Patient Self-Advocacy*. 26(3), 239–243. <https://doi.org/10.1188/22.CJON.239-243>.Oncology
- Young, Y., Hong, B., Young, S., Cho, S., Sun, H., & Lee, J. (2025). International Journal of Nursing Studies The effect of nurse-led enhanced supportive care as an early primary palliative care approach for patients with advanced cancer: A randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*, 168(August 2024), 105102. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2025.105102>
- Yuwanto, M. A., & Astutik, E. E. (2024). *Indonesian Nursing Standards Training (Diagnosis, Outcomes and Interventions) for Nursing Documentation*. 2(1), 37–44.
- Yuwanto, M. A., & Prasetyo, R. E. (2023). *Implementation of Nursing Care Documentation Based on Indonesian Nursing Care Standards (SDKI , SLKI , and SIKI) in Hospitals*. 1(1), 17–23.
- Zhang, J., Wang, S., Wang, Y., Zhuang, J., Hang, L., Wu, Y., Xu, D., & Huang, C. (2024). Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing Symptom clusters and network analysis in patients with gynecologic cancer undergoing chemotherapy: A cross-sectional study. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 11(12), 100612. <https://doi.org/10.1016/j.apjon.2024.100612>
- Zhao, J., Zhan, L., Pang, Y., Shen, S., Huang, J., Zhang, W., & Wei, S. (2025). *Prevalence and risk factors for cancer- related fatigue in women with malignant gynecological tumors: a meta-analysis and systematic review*.

I. Glosarium

Adjuvan (terapi adjuvan): Terapi tambahan setelah terapi utama (misalnya setelah operasi/radioterapi) untuk menurunkan risiko kekambuhan kanker.

Advokat (peran perawat): Peran perawat untuk melindungi hak pasien, membantu pasien menyuarkan kebutuhan, dan memfasilitasi komunikasi pasien dengan tim kesehatan.

Beban perawatan: Tingkat tuntutan fisik, psikologis, sosial, dan waktu yang dialami pasien/keluarga selama menjalani perawatan.

Cancer-related fatigue: Kelelahan terkait kanker yang menetap, tidak selalu membaik dengan istirahat, dan sering mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dukungan psikososial: Bantuan untuk aspek psikologis dan sosial pasien, seperti dukungan emosi, motivasi, dan hubungan sosial.

Efek samping akut: Efek yang muncul segera atau dalam waktu singkat setelah kemoterapi (misalnya mual muntah).

Fungsi reproduksi: Kemampuan dan proses biologis reproduksi (misalnya fungsi ovarium, siklus haid, kesuburan).

Gangguan mukosa mulut (mukositis): Peradangan/iritasi pada mulut akibat kemoterapi yang dapat menyebabkan nyeri dan sulit makan.

Gonadotoksik: Bersifat merusak/menurunkan fungsi gonad (ovarium), sehingga dapat menyebabkan gangguan menstruasi atau infertilitas.

Hemoglobin (Hb): Komponen sel darah merah yang membawa oksigen; dapat menurun akibat kemoterapi dan menyebabkan lemah/cepat lelah.

Intervensi nonfarmakologi: Upaya tanpa obat untuk mengurangi gejala (misalnya relaksasi, distraksi, manajemen aktivitas).

Kanker serviks: Keganasan pada leher rahim (serviks), sering terkait infeksi HPV dan dapat berdampak pada fungsi reproduksi.



PROFIL PENULIS



Ulfa Nur Rohmah (Ulfa), lahir di Tanjung Enim (Sumatera Selatan), 24 Januari 1995. Penulis sering disapa Ulfa ini merupakan anak pasangan dari Slamet (Ayah) dan Mar'atul Jannah (Ibu). Penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim (2009-2012). Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Bagian Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (2012-2018) dan telah menyelesaikan sekolah program Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Airlangga (2018-2020). Penulis memulai bekerja sebagai dosen sejak tahun 2020. Saat ini penulis bekerja dan aktif sebagai Dosen di Bagian Keperawatan Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya departemen Keperawatan Medikal Bedah. Selain melakukan pengajaran, penulis juga aktif berbagai kegiatan tridharma lainnya yaitu sebagai dalam penulis buku, reviewer dan publikasi artikel penelitian di nasional maupun internasional, editor jurnal, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : ulfanurrohmah@fk.unsri.ac.id



Asnani, S. Kep. Ns. M. Ked, Lahir di Tulungagung, 11 Oktober 1971; Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu: S1 + Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan ke jenjang S 2 Ilmu Kedokteran Dasar Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2011. Saat ini penulis bekerja di Prodi D III Keperawatan Sutopo Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, mengampu Mata Kuliah: Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis, Keperawatan Dasar Manusia, Metodologi Keperawatan, Anatomi Fisiologi dan patofisiologi. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Penulis buku, Publikasi, seminar, workshop, prosiding dan aktif di organisasi profesi PPNI bidang kehumasan Komisariat prodi D III Keperawatan Sutopo Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email asnaniibr@gmail.com



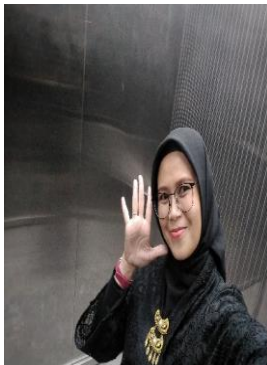
PROFIL PENULIS



Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd. adalah seorang akademisi dan praktisi keperawatan yang berdedikasi pada pengembangan pendidikan vokasi keperawatan di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan (S.Kp.), magister pendidikan (M.Pd.), dan meraih gelar doktor (S3) dalam bidang Manajemen Pendidikan.

Dr. Susi Milwati aktif sebagai dosen senior di program studi Keperawatan dan berpengalaman dalam praktik klinik, penelitian, serta pengembangan kurikulum keperawatan berbasis kompetensi. Beliau juga menulis berbagai buku ajar dan modul praktik klinik yang banyak digunakan oleh mahasiswa D3 Keperawatan.

Dengan pengalaman akademik dan praktis yang luas, Dr. Susi Milwati berkomitmen membentuk lulusan perawat vokasi yang kompeten, profesional, dan siap memberikan asuhan keperawatan bermutu.



Ns. Nina Sunarti, M.Kep. Lahir di Bekasi pada tanggal 05 Maret 1982 putri ke dua dari pasangan Eddy Sunarso (Alm) dan Nakirah (Alm). Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan (2004), Ners (2005) dan S2 Keperawatan (2017) di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap di Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta. Sebagai dosen penulis juga menjalankan Tridharma, melaksanakan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai narasumber/fasilitator. Karyanya sudah ada dalam jurnal nasional, internasional, HaKI dan buku. Penulis aktif dalam organisasi PPNI Jakarta Utara, pernah menjabat sebagai ketua dan sekretaris DPK Akper Harum. Saat ini penulis menjabat sebagai sekretaris DPK PPNI Pendidikan Jakarta Utara. Penulis juga aktif Alamat Email penulis: nina.nti@bsi.ac.id.

Motto: "*The best preparation for tomorrow is doing your best today*"

PROFIL PENULIS



Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis lahir di Mandas pada 24 Agustus 1978. Mengawali pendidikan keperawatan dari SPK Waingapu (1998), melanjutkan D-III Keperawatan Waingapu (2005), kemudian meraih gelar Sarjana Keperawatan dan profesi Ners dari Universitas Diponegoro Semarang (2010). Gelar Magister Keperawatan diperoleh dari Universitas yang sama pada tahun 2016. Karier keperawatan dimulai sebagai perawat pelaksana di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu (1999–2000), lalu bertugas di Puskesmas Tana Rara (2000–2005) dan Puskesmas Kombapari (2005–2006). Sejak 2006, penulis berkiprah sebagai tenaga pengajar di Program Studi Keperawatan Waingapu hingga 2021, kemudian menjadi dosen di Prodi Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang sejak 2022 hingga sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan organisasi PPNI, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Wakil Ketua DPD PPNI Sumba Timur, serta saat ini sebagai Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI NTT. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail domianus2012@gmail.com



Erwin Silitonga, lahir di Lumban Tanjung, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada 3 Oktober 1975. Menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Dewi Medan selesai tahun 1997, selanjutnya menyelesaikan Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara di tahun 2003, serta menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan dengan konsentrasi Manajemen keperawatan pada tahun 2013. Karir sebagai dosen dimulai begitu tamat dari diploma tiga keperawatan sebagai asisten dosen mulai tahun 1998. Beberapa tahun kemudian ditetapkan dengan status dosen tetap yayasan Dewi Maya Medan dan pernah dipercaya diberbagai jabatan struktural seperti sebagai wakil direktur dan jabatan direktur di Akademi Keperawatan Dewi Maya Medan. Seiring dengan perkembangan situasi pada tahun 2018, berpindah tugas ke Universitas Sari Mutiara Indonesia (USM-Indonesia), sebagai dosen tetap yayasan. Pada tahun 2023 dipercaya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan di Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan USM-Indonesia sampai dengan saat ini. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan tetap dijalankan sebagai pengajar di program studi keperawatan dengan konsentrasi pengajaran bidang manajemen keperawatan. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan dan terjadwal, dan skope penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mayoritas fokus pada bidang keperawatan dan manajemen keperawatan.



PROFIL PENULIS



Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes. Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktorat Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS. William booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995 bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, penguji osche AIPNI serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com



Dr. Ns Tutik Rahayu M.Kep., Sp.Kep., Mat. Lahir di Magelang. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan Spesialis pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai perawat pelaksana di RS Telogorejo Semarang dan tahun 1996 sd sekarang sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tutikrahayu@unissula.ac.id

Sinopsis

"Bunga Rampai: Praktik Keperawatan dalam Berbagai Situasi Klinik—Contoh Kasus Sederhana dan Penyelesaian Asuhan" merupakan bookchapter yang dirancang sebagai panduan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat pemula, maupun tenaga kesehatan yang ingin memperkuat kemampuan berpikir kritis dan keterampilan klinik melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus. Buku ini menyajikan beragam situasi klinik yang sering dijumpai di layanan kesehatan mulai dari kondisi akut hingga kronis, dari masalah fisik hingga psikososial dengan contoh kasus yang disusun sederhana namun tetap merepresentasikan tantangan nyata di lapangan.

Setiap bab menghadirkan studi kasus singkat yang dilengkapi dengan langkah penyelesaian asuhan keperawatan secara sistematis, meliputi pengkajian, analisis data, penetapan diagnosis keperawatan, perumusan luaran, penyusunan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pembaca diajak memahami cara menetapkan prioritas masalah, merancang tujuan yang realistis, memilih intervensi yang tepat dan mudah diterapkan, serta mengevaluasi hasil asuhan secara terukur. Penyajian yang ringkas dan aplikatif membuat buku ini cocok digunakan sebagai pegangan saat praktik klinik, bahan diskusi tutorial, maupun referensi penyusunan asuhan keperawatan dalam tugas akademik.

Melalui kumpulan kasus dan penyelesaian yang terstruktur, bookchapter ini diharapkan mampu membantu pembaca mengintegrasikan teori dengan praktik, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan klinis, serta membangun kebiasaan dokumentasi asuhan yang rapi dan sesuai standar. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga menjadi jembatan untuk membentuk praktik keperawatan yang profesional, aman, berpusat pada pasien dan keluarga, serta relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masa kini.

“Bunga Rampai: Praktik Keperawatan dalam Berbagai Situasi Klinik—Contoh Kasus Sederhana dan Penyelesaian Asuhan” merupakan bookchapter yang dirancang sebagai panduan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat pemula, maupun tenaga kesehatan yang ingin memperkuat kemampuan berpikir kritis dan keterampilan klinik melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus. Buku ini menyajikan beragam situasi klinik yang sering dijumpai di layanan kesehatan mulai dari kondisi akut hingga kronis, dari masalah fisik hingga psikososial dengan contoh kasus yang disusun sederhana namun tetap merepresentasikan tantangan nyata di lapangan.

Setiap bab menghadirkan studi kasus singkat yang dilengkapi dengan langkah penyelesaian asuhan keperawatan secara sistematis, meliputi pengkajian, analisis data, penetapan diagnosis keperawatan, perumusan luaran, penyusunan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pembaca diajak memahami cara menetapkan prioritas masalah, merancang tujuan yang realistis, memilih intervensi yang tepat dan mudah diterapkan, serta mengevaluasi hasil asuhan secara terukur. Penyajian yang ringkas dan aplikatif membuat buku ini cocok digunakan sebagai pegangan saat praktik klinik, bahan diskusi tutorial, maupun referensi penyusunan asuhan keperawatan dalam tugas akademik.

Melalui kumpulan kasus dan penyelesaian yang terstruktur, bookchapter ini diharapkan mampu membantu pembaca mengintegrasikan teori dengan praktik, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan klinis, serta membangun kebiasaan dokumentasi asuhan yang rapi dan sesuai standar. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga menjadi jembatan untuk membentuk praktik keperawatan yang profesional, aman, berpusat pada pasien dan keluarga, serta relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masa kini.

ISBN 978-634-7556-66-0



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

